

# terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA  
Y TERAPEUTICA  
DE GRUPO FAMILIAR

---

## 10

TRABAJOS PRESENTADOS EN EL  
II CONGRESO ARGENTINO  
DE  
TERAPIA FAMILIAR  
(CONTINUACION)

1<sup>er</sup>. Premio del  
CONCURSO  
TERAPIA FAMILIAR 1981



# terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica  
del grupo familiar

Año V - N° 10 - Diciembre de 1982

## Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

## Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

## Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

- Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires-San Antonio-Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina-St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Bloch (New York)

Ives Colas (Lyon)

C. Sluzki (Buenos Aires-S. Francisco-California)

J. Howells (Ipswich-Inglaterra)

Israel Zwerling (Filadelfia)

Florence Kaslow (Miami)

## Director Administrativo

Alberto Cattán

## Secretaria

Graciela Rodríguez

## Asesor Editorial

Alfredo Carlino

## Asesor Gráfico

Patricia Luppi

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 142516.

Coordinación gráfica: Patricia Luppi, Tel. 33-3041, int. 42. Composición: Osmar Luis Bondoni, San Carlos 1250, Santos Lugares.

Tarifa reducida 3052 — Franqueo pagado 339 — Número del Registro Internacional de Publicaciones Científicas ISSN 0325-5905.

Impreso en Edigraf S.A.  
Delgado 834  
Diciembre 1982

## INDICE

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EDITORIAL .....                                                                                              | 7   |
| NORMA GLADYS FUCCI; ELENA KATZ DE LEBENSOHN;<br>MARIO RAUL LITMANOVICH Y CARLOS ALBERTO MAHUAD               |     |
| Terapia familiar sistémica: un modelo de abordaje con especial referencia al funcionamiento del equipo ..... | 9   |
| LAURA GRINBERG DE OTTADO, ALICIA BETRIA DE PALOU y RINA PALENQUE DE SEINELDIN                                |     |
| Reflexiones acerca de la selección de los miembros en la terapia familiar .....                              | 27  |
| ESTELA S. DE GURMAN                                                                                          |     |
| Familia. Una novela ... familiar .....                                                                       | 35  |
| SAUL KAROL                                                                                                   |     |
| El enfermo orgánico: de la relación médico-paciente a la terapia familiar .....                              | 43  |
| ANALIA KORNBLIT, SILVIA WASERTREGUER y JAIME SZWARSTEIN                                                      |     |
| Abordaje de la familia con un "paciente orgánico" crónico. .                                                 | 55  |
| STELLA MARIS MOLINA                                                                                          |     |
| Indicación y contraindicación de terapia de pareja .....                                                     | 67  |
| J. J. MORGAN y J. R. BOZZO                                                                                   |     |
| Anorexia nerviosa .....                                                                                      | 77  |
| ALEJANDRO G. PISCITELLI                                                                                      |     |
| Las nociones de estructura y sistema y el proyecto de una ciencia unificada del hombre .....                 | 93  |
| MARIA CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES                                                                         |     |
| Algunos cuestionamientos acerca de la función del terapeuta                                                  | 107 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SUSANA ROMERO y MARTA SIERRA                                                                                      |     |
| Aproximación a la dinámica familiar e individual de pacientes con trastornos en la adquisición del lenguaje ..... | 115 |
| WANDA SANTI                                                                                                       |     |
| Anorexia nerviosa. Una comunicación clínica .....                                                                 | 127 |
| ALBA MARTA SCHABAS                                                                                                |     |
| El juego de las identidades en el sistema familiar .....                                                          | 141 |
| ANNY SPEIER, ESNEA AULETTA y RUBEN VADAGNEL                                                                       |     |
| Aplicación de la terapia familiar en niños y adolescentes ...                                                     | 149 |
| HAYDEE M.C. DE TORONCHIK                                                                                          |     |
| Trastornos del sueño en la primera infancia .....                                                                 | 167 |
| EDMUNDO ZIMMERMAN                                                                                                 |     |
| Psicoanálisis y terapia familiar. Algunas articulaciones .....                                                    | 177 |
| 1er. PREMIO DEL CONCURSO TERAPIA FAMILIAR 1981                                                                    |     |
| MARIO TISMINETZKY y DANIEL FRANKEL                                                                                |     |
| Comprensión y tratamiento interaccional del alcoholismo. La familia alcohólica .....                              | 187 |
| CONCURSO 1982 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR                                                                  | 215 |

## EDITORIAL

*En el actual volumen se incluye, además de los trabajos correspondientes al 2º Congreso Argentino de Terapia Familiar, el trabajo ganador del primer premio del Concurso Terapia Familiar 1981.*

*Esta vez recayó en un meritorio trabajo realizado en el Centro de Salud Mental de La Matanza, zona de impacto transcultural muy importante del Gran Buenos Aires.*

*Es un buen ejemplo de la transformación que las instituciones que se ocupan de la salud mental de nuestros habitantes debieran realizar para encarar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento bajo la óptica de la terapia familiar. Sólo así se podría realizar un verdadero trabajo terapéutico que se ocupe no sólo del individuo, sino del grupo que mediatiza su inclusión en el mundo circundante y que esté también centrado en la interacción entre el sistema familiar y los macrosistemas comunitarios.*

*Los integrantes del jurado que seleccionó el trabajo ganador fueron, como en el concurso del año anterior, las licenciadas Estrella Joselevich y Ana P. de Quiroga, y los doctores Juan J. Morgan, Guillermo Vidal, Octavio Fernández Mouján e Isidoro Berenstein. A ellos, una vez más, nuestro agradecimiento por tan proba labor.*

*Hasta la próxima*

*El Director*

---

Terapia familiar sistémica: un modelo de abordaje con especial referencia al funcionamiento del equipo.

---

Dra. NORMA GLADYS FUCCI; Lic. ELENA KATZ DE LEBENSOHN; Dr. MARIO RAUL LITMANOVICH; Dr. CARLOS ALBERTO MAHUAD

---

*Integrantes del Centro de Estudio de Terapia Familiar (CE.TE.FA.), Rosario. Director: Fidel Lebensohn. Tucumán 1060 - P.B. A - Rosario.*

---

*"... la ética puritana basada sobre el trabajo de todos los días, la acumulación de bienes y el individualismo, parece ser la antítesis de la ética sistémica".*

Rabkin

#### Algunas consideraciones teóricas sobre nuestro modelo de trabajo

La base conceptual fundamental del modelo que actualmente sustentamos, considera que el ser sólo es en relación. Más específicamente, el hombre es en relación con su contexto.

El ser humano se maneja, habitualmente, con un rango muy reducido de metaniveles de abstracción de su realidad, y se encuentra apresado en un orden en el que predomina la confusión de la mente percibiéndose a sí misma, en un período de tiempo.

La consecuencia de esta confusión, en la convivencia humana, está al servicio del mantenimiento de un esquema de auto-percepción (y del contexto relacional) que requiere que el otro se adecue a una realidad que resulta total o parcialmente extraña respecto de su propia idea de ser-en-el-mundo.

La base de lo que aparece como egoísmo humano está en la presunción homocéntrica del ser de poder clasificar el universo

incluyéndose a sí mismo como miembro de la clase que categoriza —encerrándose, así, en la paradoja russelliana.

Si bien es imprescindible la definición dentro del caos entrópico para obtener conocimiento, es *en* la relación entre nuestras definiciones perceptuales y la de los otros, que forman nuestro contexto relacional, donde se permite la confirmación necesaria para el desarrollo de la individualidad y se determinan sus posibilidades de cambio.

El crecimiento continuo se da en el presente continuo.

En el presente continuo no hay esquemas.

Los esquemas son recuerdos de experiencias pasadas, organizados por la mente.

Potencialmente, en el presente, la relación es un encuentro inédito, una experiencia nueva.

Con la mente enfocada en la reedición de esquemas perceptuales aprendidos en el pasado, el presente es una redundancia.

La redundancia perceptual es cero observación de la realidad ya que anula la diferencia, que es la que permite su conocimiento.

De acuerdo a nuestra epistemología sistémica, basada, fundamentalmente, en las ideas de Gregory Bateson y la Escuela de Milán, el terapeuta familiar que cruza la trayectoria de un sistema de hombres en interacción, él mismo, es un hombre en interacción con sus propios modelos perceptuales del pasado.

Su identidad terapéutica dependerá de la claridad con que maneje e integre sus múltiples aprendizajes funcionales de otras relaciones y otros contextos, en el contexto de la sesión; es decir, de acuerdo a como pueda mantener su función como terapeuta discriminándose del sistema que consulta.

El instrumento metodológico que hemos montado para permitir esta experiencia de afirmación terapéutica en el aquí y ahora de la sesión, es la supervisión en vivo, de la cual hablaremos más adelante.

## Nuestro modelo operativo

### A) Proceso grupal:

El equipo actual, formado por un supervisor y cuatro terapeutas, dos masculinos y dos femeninos, es fruto de un proceso prácticamente ininterrumpido de 10 años, aproximadamente, de trabajo clínico, al principio institucional y luego en forma privada, hasta la fundación de CE.TE.FA.

En todo este tiempo se ha producido un proceso natural y evolutivo de decantación y de modificación de la estructura interna del grupo, de modo que los que estamos aquí y ahora somos los que podemos mantener un cierto nivel de complementariedad flexible, adecuado al trabajo de investigación.

A pesar de que el equipo cumple esta última labor como propuesta de trabajo desde los últimos dos años, no debemos desconocer la fundamental importancia que ha tenido en nuestra relación actual la tarea asistencial conjunta, que siempre hemos desempeñado y que es la que nos permite, hasta ahora, tener un grado de mutuo conocimiento profundo, exento de espíritu competitivo.

Mencionamos esto porque pensamos que el elemento básico que posibilita la asistencia terapéutica en un equipo de trabajo, es la coherencia, como producto total, entre el pensamiento sistémico y la acción.

Es posible deponer aspectos personales cuando se cuenta con una ideología en común. Dejamos de ser simétricos en lo personal para pasar a ser complementarios con respecto a un metanivel.

El esfuerzo por ser coherentes en el metanivel ideológico nos permite saltar por sobre las características individuales que, indudablemente, nos llevarían a posturas estériles en detrimento de la creatividad en el trabajo asistencial y de conceptualización, que se retroalimentan entre sí.

Somos complementarios con respecto a un modo de pensar pero no en la acción, ya que allí se expresan las características y posibilidades individuales que configuran el estilo terapéutico.

Hemos descubierto que nuestro potencial terapéutico des-

cansa en el grado de confianza que existe dentro del sistema que conformamos. Más que confiar en el otro, confiamos en la relación con el otro.

### B) Aprendizaje:

La función terapéutica nos implica un esfuerzo de ruptura de nuestros propios esquemas perceptuales, ya que la elección de la actitud terapéutica no es fruto de una visión subjetiva sino que pertenece a la elaboración grupal. Este es el *qué* de la tarea (qué hacer).

El terapeuta que está con la familia en la sesión, es una función de un sistema más amplio que lo contiene —su grupo—; él representa al equipo.

A pesar de ello, el terapeuta tiene libertad para implementar, según su propio estilo personal, la línea terapéutica elaborada por su equipo. Este es el *cómo*, y en el *cómo* está implícita la relación que es la que clasifica los contenidos comunicacionales y permite el proceso de cambio.

El grado de coherencia con que el terapeuta es visualizado, por la familia, en interacción con su equipo —a través de las llamadas, las entradas y salidas a la sesión, la forma en que recibe los mensajes y los retransmite—, da a ésta un modelo relacional que marca una diferencia con respecto al estilo disfuncional que sustentan. Y esto es lo que les permite reconocerse en sus características en esta especie de insight analógico.

Trabajar en equipo, y más siendo de características heterosexuales como el nuestro, rompe ciertos mitos de poderoso arraigo.

La ruptura de ciertos estereotipos culturales con respecto al sexo y al poder de los roles masculino y femenino se manifiestan en la práctica diaria. La mujer que hace terapia sistémica, visualizada *down*, según el mito, debe acostumbrarse al manejo de situaciones de poder y no sólo de situaciones emocionales de simpatía o antipatía.

El mito del héroe —que la familia trata de poner en el terapeuta o viceversa, que el terapeuta trata de imponer en la relación con la familia—, no puede desarrollarse cuando hay

una situación compartida. El terapeuta no puede ser el salvador omnipotente, no puede decir: “Yo curé, yo solucioné, yo hice...”, alimentando su narcisismo. Tampoco puede decir “yo fracasé”, que es una forma complementaria de expresar la misma concepción sobre el poder.

No sólo no puede decir “fracasé” considerándose en aislamiento, sino que tampoco puede hacerlo diciendo: “... Fracasamos”.

No existe posibilidad de fracaso según nuestra concepción ya que no hay deseo de afirmar un modelo de cambio que pueda ser codificado como éxito. Nuestras acciones o input para el sistema consisten en ponerlo en movimiento para que pueda seguir recorriendo *su propio ciclo evolutivo*. La familia es la que debe, luego, mostrar sus propias posibilidades de cambio a través de las respuestas que da a sus intervenciones terapéuticas.

El aprendizaje del terapeuta se da por ensayo y error, como la rata que busca su alimento en el laberinto. Las retroacciones a sus intentos erróneos son utilizadas como aprendizaje para no volver a repetirlos. De no existir la información sobre el error, le llevaría mucho tiempo —según Selvini— llegar a su meta, o no llegaría nunca. Y la meta de todo terapeuta que se precie de sistémico, debería ser aprender a aprender.

Por ello, el terapeuta debe tener una línea de pensamiento que le ayude a integrar un orden sistémico que desconoce. La hipótesis es el instrumento exploratorio frente a la realidad desconocida. La verificación de la misma en un paso posterior, con la familia, nos da la información sobre si es correcta o no. Así, palmo a palmo —por ensayo y error—, podemos ir reconociendo el sistema que investigamos.

A través de la hipótesis grupal de presesión inferimos la estructura relacional disfuncional de cada familia para asentar sobre ellas nuestra acción.

En el trabajo sistémico no interesa trabajar con la contra-transferencia, aunque exista como manifestación de las emociones del terapeuta frente al sistema que consulta.

El terapeuta sistémico no se maneja por lo que siente —por

su contratransferencia—; trata de verificar una hipótesis que es fruto del trabajo del equipo frente a la información recibida.

El equipo organiza la transferencia del terapeuta como información sobre la relación del sistema terapéutico (terapeuta-familia) dándole una utilidad básicamente destinada a cotejar la hipótesis de trabajo formulada previamente.

La contratransferencia puede ser utilizada, entonces, como un síntoma o información que nos permite detectar —como la rata— que estamos en un error.

El terapeuta sistémico puede salir de la sesión al percibirse involucrado o puede ser llamado por el equipo que lo visualiza hipnotizado o trabando en el juego familiar.

En uno u otro caso, la salida de la sesión produce un mecanismo de desimplicación o desenganche del terapeuta que afirma la presencia intangible, y por lo tanto muy poderosa, de la función terapéutica del equipo.

Al volver a la sesión, el terapeuta ya posee una recodificación de sus emociones y una información muy valiosa sobre su relación con la familia.

Si en el idioma de las ratas, el experimentador pudiese extraer el animal del laberinto e indicarle por dónde *no debe ir*, ésta ahorraría energía y tiempo en su tarea.

Si bien el terapeuta como individuo en relación, que desempeña, globalmente, múltiples funciones, puede tener escotomas propios, nuestra acción como equipo va más allá de estos escotomas.

Pero, repetimos, como no estudiamos al ser en aislamiento sino en relación, el terapeuta puede saltar por sobre su escotoma en virtud de la presencia del equipo tras el espejo, que puede rescatar y redefinir el rol terapéutico en los momentos en que la relación terapéutica entre el profesional y la familia deja de serlo.

Luego, en el trabajo grupal sobre la familia interna, su desempeño asistencial lo esclarece enriqueciendo su conocimiento sobre sí mismo —fundamentalmente las limitaciones.

No propugnamos, indudablemente, la “salud” del terapeuta sino su grado de eficiencia técnica, su capacidad para mantener-

se como observador objetivo y lograr, en el proceso terapéutico, el máximo de neutralidad posible para que su acción no distorsione la información proveniente de la familia, que debemos computar para asistirla.

Nuestro intento se basa en poner en movimiento el proceso del ciclo evolutivo que se ha detenido; no comparamos el sistema familiar que nos ocupa con ningún otro modelo considerado normal.

Esto importa un desafío y una lucha permanente entre estas propuestas ideales y los elementos de culturización aprendidos que interfieren, no pocas veces, la coherencia de nuestra acción, ya que, ciertamente, cada uno de nosotros tiene incorporado un esquema de normalidad.

### Secuencias del proceso terapéutico

a) *Entrevista telefónica*: Coincidimos con la escuela de Milán en que la entrevista telefónica es muy importante como primer paso del proceso terapéutico, ya que permite la recolección de la mayor cantidad de datos lineales posibles y de contenidos emocionales, que, vertidos a través de una comunicación a distancia, impiden las alianzas o coaliciones con el terapeuta.

La consecuencia inmediata de este hecho es la afirmación de la neutralidad terapéutica desde el primer contacto.

Por nuestra experiencia, aquel que llama o “hace llamar”, es el miembro de la familia que detenta el mayor tenor homeostático del sistema, ya que por su intermedio éste solicita la designación de un miembro que cristalice la percepción lineal-causalista de su realidad.

Esta es un dato significativo en la comprensión de las relaciones familiares, al igual que el modo en que se vierte la información a través del teléfono.

La entrevista telefónica obra como una catarsis y es, generalmente, agradecida como demostración de interés y afecto por parte del terapeuta.

Hemos hallado que este modo de operar, no provoca ningún tipo de resistencia en la persona que llama, siempre y

cuando se esclarezca como parte del contexto terapéutico desde el primer instante.

Se comunica a la persona que llama que le serán dados dos turnos: uno, para la entrevista telefónica —advirtiéndosele que debe disponer de, por lo menos, media hora— y otro, para la entrevista en consultorio, siendo esta información posterior a la recolección de datos. De esta manera, y a medida que el terapeuta recoge la información lineal, se va formando una idea de quiénes son los miembros que le interesa que estén presentes en la sesión en consultorio.

La entrevista telefónica puede ser realizada por cualquier miembro del equipo (y hasta por una secretaria eficiente) con cualquiera de los miembros de la familia.

Cumplido de esta forma, el primer contacto con la familia, el terapeuta ahorra tiempo y energías, evitando la prolongada sucesión de detalles que los familiares generalmente, están dispuestos a comunicar con respecto al paciente designado y al síntoma. De este modo, y con una hipótesis sobre el sistema que va a investigar a su disposición, el terapeuta puede, rápidamente, abrir el juego sistémico.

b) **Formulación de hipótesis:** Todos los datos lineales son procesados en una reunión de pre-sesión con el equipo terapéutico, de la cual emerge una hipótesis sistémica de trabajo en la que se encuentran integradas las conductas de todos los miembros de la familia —en términos de función del síntoma y pautas de mantenimiento.

Acto seguido, se diseñan todas las preguntas que deberán ser realizadas, por el terapeuta interviniente, a la familia, interrogando en circularidad, mientras el resto del equipo observa tras el vidrio de visión unidireccional.

Si la hipótesis no funciona, el terapeuta vuelve a reunirse con su equipo, mientras la familia espera, para reformular la hipótesis adecuada y volver a diseñar las preguntas básicas para su verificación, a través del interrogatorio en circularidad.

El interrogatorio en circularidad sostiene la neutralidad terapéutica, ya que se limita a la recolección de información sin fórmulas interpretativas de la interacción, produciendo gran

movilización relacional, que arroja, a su vez, mayor información.

Los escotomas del terapeuta pueden visualizarse en esta etapa como olvidos, intervenciones interpretativas o didácticas, situaciones que son prontamente neutralizadas por el equipo terapéutico a través del timbre o solicitando la presencia del terapeuta tras el vidrio.

Una de las evaluaciones fundamentales que realizamos en la pre-sesión es la del momento del *ciclo vital* en el que se encuentra la familia.

En general, todas las disfunciones y situaciones de crisis se dan cuando hay una disfunción en el ciclo evolutivo familiar. Estas disfunciones aparecen por la resistencia interna de la familia a aceptar que *tiene* que producir un cambio.

Como otras escuelas lo hacen, utilizamos la crisis que trae la familia —*crisis emergente*—, no para volver a la situación anterior, potenciando la regulación homeostática del sistema, sino, produciendo, a través de nuestra intervención, una ampliación de la desviación.

#### Prescripción de apertura. Prescripción final.

Aunque no es obligatoria la formulación de la prescripción de apertura, ya que está expresamente indicada en casos donde aparece la resistencia del sistema en forma manifiesta, aconsejamos su realización, de rutina, para poder cubrir prescriptivamente situaciones posibles de resistencia en otro momento del proceso.

En el trabajo con parejas es siempre necesario hacerlo ya que las posibilidades de evitación o compensación funcional que ofrece el sistema familiar en interacción se ven limitadas cuando trabajamos sólo con la díada.

De hecho, la resistencia es mucho mayor en esta última situación pues ambos cónyuges se ven compelidos, por el diseño terapéutico, a enfrentar el cambio.

La fórmula es: "... hay muchas cosas que van a poder cambiar y otras que no ..." (se enuncian los aspectos estereotipados de la relación que aparecen como síntomas en la

interacción) . . . en la terapia van a poder comprender mucho más claramente aquellas que no van a poder cambiar”.

De acuerdo a cada caso, la actitud del equipo varía con respecto a la prescripción:

1) Si el equipo elige trabajar con todo el sistema y no requiere una nueva entrevista familiar para redondear la hipótesis, formula la prescripción final. Toda la información detectada a través del interrogatorio en circularidad es organizada a través de una conclusión que consiste en una reestructuración de la realidad lineal que muestra la familia. Traducida al pensamiento sistémico, la causalidad circular integra las conductas de todos los miembros participantes (ausentes o presentes) de la familia, en la situación conflictiva.

2) Si el equipo elige trabajar con la pareja, puede leer la prescripción a toda la familia, expresando al final de la misma: “... por todo esto, se hará terapia familiar, para lo cual vendrán a la próxima sesión, solamente Fulana y Zutano (nombres de los cónyuges)”.

En ambos casos, el terapeuta debe acordar el día y la hora de la próxima entrevista —haciendo participar a todos en esta tarea, aun cuando sepa que va a trabajar sólo con la díada conyugal—, antes de la lectura de la conclusión del equipo. Después de realizado este paso, comunica a la familia que: “el equipo ha llegado a una conclusión que yo mismo voy a leerles ahora, después de la cual no habrá ningún tipo de comentarios y deberán despedirse en silencio”. Vuelve a preguntar si hay algún tema que haya quedado pendiente o alguna duda antes de comenzar a leer (recorre con la mirada a todos los integrantes de la familia buscando una respuesta, verbal y/o analógica, concreta). Luego lee, pausada y firmemente la prescripción y se despide rápidamente de la familia.

Todo este ritual tiene el sentido de crear expectativa y cierto ambiente hipnótico, que facilite la introyección de la prescripción. La rápida salida del terapeuta evita su descalificación por la familia.

En el caso de la pareja que el equipo decide discriminar de la familia, no debe olvidar el terapeuta de agradecer calurosamente

la participación y ayuda que ha recibido de ellos. Esta maniobra donde el terapeuta, delicadamente, divide el sistema debe realizarse con un gran respaldo afectivo de su parte, para evitar toda posible reacción de dichos miembros frente a la exclusión, creando un clima hostil y adverso al nuevo contexto.

La *prescripción de apertura*, que actúa sobre la resistencia, puede o no coincidir con la prescripción final. El equipo elabora esta prescripción basándose en la interacción observada; es más pronta y superficial, ya que se da al inicio de la terapia, donde la calidad de la información sobre la estructura que se asiste, no siempre permite, a esa altura, la detección de las reglas fundamentales de la relación.

La *prescripción final*, exige un trabajo más meduloso del equipo. Es difícil establecer un criterio para el contenido del mensaje final; éste no es arbitrario sino que debe surgir de los datos que arroja el interrogatorio en circularidad y de la interacción analógica de la familia.

Allí se pone a prueba la capacidad de observación del equipo, así como su sentido creativo. Debe respetar el clima de la sesión, la afectividad de la familia y las características de sus miembros.

El mensaje debe ser emitido con seguridad y convencimiento del terapeuta, situación que es posible a través de una profunda verificación de lo observado con el equipo.

### Paradoja central

La captación de la paradoja central es un punto fundamental al que se dirigen los esfuerzos del equipo.

Según Bateson, todo aprendizaje mayor a cero debe conducirse con las características de ensayo y error. Es a través de la confección y posterior verificación de la hipótesis, que el equipo puede llegar a captar la paradoja central.

Selvini llama a esta circunstancia, *punto nodal*. Nosotros manejamos el concepto de *paradoja central*. Este sería un punto que resume la situación paradójal que vive el sistema.

La importancia de detectar esta estructura relacional reside

en que actuando técnicamente sobre la situación paradójica puede lograrse, con un mínimo de esfuerzo, un máximo de cambio.

La paradoja central es la hipótesis confirmada, que capta el o uno de los ejes de la relación disfuncional (que es la que hace reverberar al sistema en sus reglas rígidas y redundantes).

### Cuando actúa el supervisor

El estilo terapéutico es respetado en tanto no sucedan las siguientes situaciones:

- Cuando el interrogatorio en circularidad no es eficaz.
- Cuando el terapeuta habla mucho, o adopta una posición educativa en detrimento de la interacción familiar.
- Cuando está errado el foco sobre el que actúa el terapeuta.
- Cuando la intervención es buena pero traída a destiempo.
- Cuando la intervención es buena pero necesita más intensidad.
- Cuando el terapeuta no respeta el sistema de creencias de la familia.
- Cuando surgen escotomas del terapeuta, que el supervisor reconoce por el trabajo en familia interna y el estilo personal del supervisado.
- Cuando debe cambiarse la hipótesis.
- Para producir *desbalance*, emitiendo mensajes, ya no al sistema familiar, sino al sistema terapéutico, que incluye a la familia y al terapeuta; no para empujar a la familia hacia una pauta de normalidad que se tiene como meta, sino al cambio que, potencialmente, puede hacer el sistema y que el equipo valora —fundamentalmente— a través de la hipótesis.

Dentro de las situaciones de desbalance, el supervisor puede utilizar los errores del terapeuta para oponerse manifiestamente a él y pidiéndole, a través del teléfono que comunique a la familia que "... el equipo no está de acuerdo con (tal acción o tal forma de pensar)", generando así una triangulación: supervi-

sor - terapeuta - familia, que crea un inductor paradójico en el sistema.

Otra situación de desbalance es la entrada del supervisor a la sesión, que promueve una situación de crisis dentro del sistema terapéutico, ya que utilizando su mayor poder, puede aumentar la retroacción para producir amplificación de la desviación, que lleva al cambio inesperado. Los mensajes del supervisor, en este caso, pueden referirse a la interacción de sus miembros, a su sistema de creencias o a las reglas de la relación.

En la supervisión predomina la diferencia en las relaciones terapéuticas, no así en la coterapia donde existe la igualdad. La diferencia se basa en un nivel de capacitación técnica e integración mayores que el que posee el supervisado, y éste debe reconocerlo así para que la definición de la relación sea inequívoca y fructífera la acción.

El grupo se forma en estrecha unión con el supervisor, de modo que éste puede serlo en función de lo que el grupo le da. El supervisor hace al equipo tanto como el conjunto de sus miembros hace al supervisor.

En el área supervisor-terapeuta, el cambio es la adquisición de mayor objetividad, neutralidad y disponibilidad terapéuticas, aumentando el espectro de sus posibilidades de acción en el abordaje familiar; en el área terapeuta-familia, el cambio es un aumento de la capacidad de autorregulación del sistema, que le permita dictar nuevas reglas o metarreglas que la pongan en condiciones de enfrentar los problemas de cambio en su ciclo vital.

Vamos a relatar brevemente un caso clínico a través del cual señalaremos la aplicación de las técnicas antes descriptas:

**1er. Paso: Entrevista telefónica:** con la consultante, mujer de 41 años con síntomas de depresión, importantes somatizaciones (trastornos digestivos, náuseas), crisis de llanto, aislamiento del medio.

**Familia nuclear:** constituida por esposo de 43 años, hija de

20 años. En el mismo piso, en otro departamento, vive su madre, viuda.

*Familia de origen de la paciente designada:* hija única, padre fallecido hace 10 años; carácter del padre, autoritario, dominante; madre, conciliadora.

*Familia de origen de él:* familia desligada con 4 hijos, padre ausente y madre inoperante. Se aleja de la familia. Mayor unión con la familia de ella.

*Carácter del esposo:* muy tranquilo, sociable, se relaciona bien con el medio, actuación social en cooperadoras muy intensa, apreciado.

*Carácter de la hija:* universitaria, independiente, tiene novio y grupo de pertenencia, su funcionamiento es adecuado.

*Situación histórica de la pareja:* un dato importante es la relación extramatrimonial de ella a los 5 años de casada. Ella vive muy culposamente esta relación e informa a su esposo sobre esta experiencia. El no se inquieta demasiado y en poco tiempo parece elaborar el problema.

*Nivel de estudios:* él es empleado, ella se recibe de estadística después de casada, pero nunca ejerce.

*Tratamientos anteriores:* psicoterapia periódica desde los 15 años, espaciada. Tratamiento psicofarmacológico, algunas sesiones le acompaña su esposo al atravesar su problema de pareja. Los síntomas de ella se agudizan últimamente y aparecen verbalizaciones de ideas de autodestrucción.

**2do. Paso: Formulación de hipótesis:** se realiza en una sesión del equipo donde son leídos los datos de la historia lineal; esto lo consideramos como la presesión en donde se evalúan diferentes hipótesis. La que elegimos para trabajar es que ella, con su depresión, autosancionándose, a través de tantos años, como enferma, ayuda a que su esposo aparezca con posibilidades, a que su hija sea independiente y que su madre tenga, a esta altura de su vida, una preocupación que la ayude a vivir.

Se jerarquiza la situación de la infidelidad de ella como un motor importante de la estructuración de la sintomatología

actual, y desde ese momento ella va a sancionarse para que su esposo sea el fuerte y va a tratar que su hija se relacione más con el padre, declarándose inoperante como madre.

Estructuramos, luego, las preguntas que nos parecen significativas, a través del interrogatorio en circularidad de la familia. Son citados: la paciente designada, su esposo, su hija y su madre.

En cuanto al modo de trabajo, se decide que uno de los miembros del equipo va a realizar la entrevista con el grupo familiar, se trabajará con supervisión, el resto del equipo actuará de observador por detrás del vidrio de visión unidireccional, decidiéndose que la devolución va a ser confeccionada en conjunto.

**3er. Paso: Primera entrevista:** Al comenzar la entrevista el terapeuta interviniente dice a la familia que a través de la historia relatada por A (paciente designada), conoce la problemática de esta familia. Esto nos parece fundamental porque de esa manera no quedamos involucrados en el relato de los síntomas de la paciente pudiendo comenzar a trabajar interrogando en circularidad.

A través del interrogatorio la hipótesis tentativa que habíamos elaborado se ve corroborada, ya que el marido aparece siempre como muy activo, como el *sano*, permaneciendo A. silenciosa en su sindicación como paciente, enferma, inútil. Se confirma la alianza entre padre e hija, siendo ambos descalificadores de la sintomatología de A., apareciendo entonces la madre de la paciente como la más preocupada por la situación de su hija.

Con esta sintomatología, aleja a su hija de la casa y convierte a su madre en alguien todavía muy vital, que se hace cargo de ella.

Una de las características fundamentales es que a lo largo de toda la sesión sólo se hacen preguntas en circularidad, evitando cualquier señalamiento. A través de la supervisión el terapeuta se rescata para conservar la neutralidad, respecto de cada miembro de la familia. La posibilidad que tiene la familia

de escuchar los datos que ellos mismos aportan es una situación potencialmente terapéutica.

El terapeuta interviniente abandona la sesión y se integra al equipo, que, junto con el supervisor, elaboran la siguiente prescripción:

**4to. Paso: Prescripción:** "A través de esta entrevista nos damos cuenta de la importancia que tienen los síntomas de A. para la familia, ya que al llevarla a vivir en soledad le comunica a cada uno lo siguiente:

*A su esposo*, lo ayuda a definir su personalidad social y su eficacia como padre, ya que lo convierte en un padre comprensivo, muy diferente al que ella tuvo.

*A la hija*, la lleva a que afirme su independencia y que vea claro cuál es el camino que debe seguir, desprendiéndola con amor de ella, ya que cuanto más síntomas tiene la mamá, más ella comprende qué es lo que no tiene que hacer y organizar su vida en forma diferente, alejándose del fracaso y del sufrimiento.

*A su madre*, le muestra, a esta altura de su vida, cómo tiene que autoabastecerse y cómo debe tolerar su soledad, ya que A. aún acompañada está sola, cosa que no le pasa a su madre, que puede evitarlo gracias a que A. funciona como si estuviera enferma.

Por todo esto pensamos que todo lo que le pasa a A. es consecuencia de su sacrificio voluntario como contribución a que se siga manteniendo el equilibrio que han logrado hasta ahora, que, por otra parte, sería muy peligroso modificar.

Debemos hacer terapia familiar para que todos comprendan la importancia de la función que cumple A.

En la post-sesión se trabajó sobre los siguientes puntos: ciclo evolutivo, paradoja central, e intervención terapéutica.

a) **Ciclo evolutivo:** Esta familia está detenida en su ciclo evolutivo, ya que A. se infantiliza a través de sus síntomas haciendo que la madre se haga cargo de ella, no pudiendo hacerlo ella misma con su propia familia. Esto le sirve al

marido ya que al pertenecer a una familia desligada, no había sido suficientemente confirmado por su madre como lo es actualmente por su suegra. A la hija le sirve porque de esta manera centra sobre ella la atención de todos, siendo la única mujer de la casa al ser su madre inoperante, tener una abuela que actúa de madre, y un padre que se transforma en amigo. A la abuela le sirve para evitar el enfrentamiento con la última etapa de su vida.

No existe un límite preciso entre la familia de origen y la familia nuclear.

b) **Paradoja central e intervención terapéutica:** El equipo llegó a un acuerdo sobre la paradoja central de este sistema, que se formuló de la siguiente manera:

Ella dice: "Si me valoro lo destruyo".

El dice: "Si te valoro me destruyo".

Al detectar la paradoja central, podemos organizar la intervención terapéutica. En este caso, la prescripción de apertura no es explicitada al inicio y coincide con la prescripción al final de la sesión, en la cual tomamos los elementos del interrogatorio en circularidad, utilizándolos prescriptivamente, guiados por la paradoja central de este sistema.

## Resumen

Este trabajo intenta un acercamiento a nuestra experiencia como equipo terapéutico que opera liderado por un supervisor. Característica de nuestro equipo consolidado a través de un aprendizaje previo conjunto y nuestra labor grupal intensiva a través de cuatro años.

Se describen las características fundamentales de nuestro estilo de trabajo basadas en la epistemología sistémica estratégica considerando la producción de cambios inesperados y no trabajando en función de un concepto predeterminado de normalidad.

Se describen las técnicas a través de las cuales intentamos provocar dicho cambio como: la prescripción de apertura, modo fundamental de

enfrentar la resistencia del sistema familiar, la captación de la paradoja central del sistema, la utilización del terapeuta como inductor paradójico.

Se describen las modalidades de los mensajes emitidos por el supervisor. Ejemplificación de nuestro modelo de trabajo con un ejemplo clínico.

## Summary

This paper attempts an approach to our experience as a therapeutic team which operates under the leadership of a supervisor. A characteristic of our team which was consolidated through previous learning experience in common and through our intensive group work throughout four years.

We describe the basic characteristics of our style of work, based on the strategic systemic epistemology, taking into account the production of unexpected changes rather than working in function of a predetermined concept of normality.

We describe the techniques through which we attempt to provoke this change, such as: the opening prescription; the basic manner of handling the resistance of the family system; the discovery of the system's central paradox; the utilization of the therapist as a paradoxical inductor.

We describe the nature of the messages emitted by the supervisor. Illustration of our model of work with a clinical example.

## Bibliografía

1. BATESON, GREGORY: *Pasos hacia una ecología de la mente*.
2. BATESON, GREGORY: *Mind and Nature*.
3. SELVINI PALAZZOLI, MARA, y otros: *Paradoja y Contraparadoja*.
4. SELVINI PALAZZOLI, MARA, y otros: "Formulación de Hipótesis - Circularidad - Neutralidad. Tres guías para el conductor de la sesión". *Revista Terapia Familiar*. No. 7, Junio de 1980.
5. LEBENSOHN, FIDEL: "La 'Prescripción de Apertura' como implementación de la morfogénesis en Terapia Familiar Sistémica". En *Terapia Familiar*, Vol. 3, No. 5, pág. 71, 1980.
6. "Ateneo Clínico" En *Terapia Familiar*, Vol. IV, No. 7-8, pág. 249, 1981.

---

## Reflexiones acerca de la selección de los miembros en la terapia familiar

---

Dra. LAURA GRINBERG DE OTTADO, Lic. ALICIA BETRIA DE PALOU y Lic. RINA PALENQUE DE SEINELDIN

---

Paraguay 950 - 2000 Rosario - Prov. de Santa Fe - Argentina

---

Con bastante frecuencia llegan a la consulta familias cuyo subsistema conyugal atraviesa una crisis, enfrentando la posibilidad de su disolución o habiéndose ya disuelto.

Este hecho hizo que nos abocásemos al estudio teórico y técnico que se plantea en estos casos específicos.

El presente trabajo tiene la intención de dar a conocer algunas consideraciones sobre la inconveniencia de aplicar reglas generales que son válidas para la mayoría de los grupos familiares, a estos sistemas particulares.

Dentro del material estudiado nos referiremos primero a aquellos casos que están en proceso de disolución, analizando las siguientes modalidades:

a) cuando se manifiestan severas dificultades para la convivencia, a la vez que se plantean amenazas de separación.

b) cuando ya se ha iniciado formalmente el proceso de separación.

En los casos donde el subsistema parental ya se ha disuelto podemos observar estas características:

1) cuando continúan interaccionando como subsistema parental único.

2) cuando uno o ambos padres forman parte de otro sistema conyugal o familiar.

La diferencia que existe entre ambas situaciones es que en la primera el subsistema parental convive con el subsistema filial, no ocurriendo esto cuando la separación ya se ha producido.

Según el modelo de ciclo de vida, desarrollado por Erickson, Minuchin, y otros autores, se observa que es en la transición de un momento evolutivo al otro, cuando se producen con mayor frecuencia problemas que determinan la consulta.

Ello es así porque la familia no cuenta con reglas para enfrentar las nuevas situaciones, o debe modificar las que ya tiene. El sistema tiende a restablecer la homeostasis anterior a la crisis, la que determinó su emergencia, porque utiliza las mismas reglas.

Si bien estas características están presentes en los grupos familiares que estamos considerando, ellos son diferentes en dos aspectos fundamentales:

- 1) Deben enfrentar la fractura de uno de sus subsistemas.
- 2) Aparece una menor cantidad de intentos manifiestos de aplicar las reglas anteriores.

El sistema se presenta buscando reglas que le permitan enfrentar la nueva homeostasis a la que deberán arribar y que habrá de conseguirse sobre una estructura diferente.

Nos hemos encontrado en varias oportunidades frente a fracasos terapéuticos en familias que, habiendo ya hecho un tratamiento previo, solicitaban nuevamente ayuda por el mismo problema. Su estudio nos llevó a la conclusión de que la modalidad de abordaje, que habían empleado los terapeutas anteriores, no sólo dificultaba la solución del problema sino que se constituía muchas veces en una situación iatrogénica. Al decir de Paul Watzlawick: "La solución constituía aquí el problema".

Hemos seleccionado algunos ejemplos que pensamos son los más ilustrativos, en los que la terapia con todo el grupo

familiar presente, en nuestra experiencia, no sería la de elección.

Virginia, de 14 años de edad, hija mayor de tres hermanos de 12 y 10 años respectivamente, es derivada por el médico clínico mientras realizaba una terapia de familia, al comprobar éste el agravamiento del cuadro de anorexia nerviosa que padece.

Ha perdido 15 kg de peso en los últimos 4 meses, pesando actualmente 29 kg y teniendo una altura de 1,70 m.

En la primera entrevista del grupo familiar la madre, después de relatar la sintomatología de Virginia, acusa descontroladamente al padre de sus infidelidades, ahondando en detalles donde se manifestaba un monto excesivo de agresión del sistema conyugal que obstaculizaba el manejo dentro de la situación terapéutica. Debido a la gravedad del cuadro, que implicaba riesgo de muerte para la paciente se decidió trabajar con los subsistemas conyugal y filial por separado, ya que cuando se intentó lo contrario el clima emocional era de tanta violencia que resultó perjudicial para la paciente.

Marcelo, de 7 años, hijo único, inicia una terapia familiar hace 5 meses. El grupo lo integran además la madre y el padre, quienes desde hace un año y medio están separados.

El motivo por el cual consultaron era inhibición marcada de la conducta, dificultades de integración con los otros niños, falta de respuesta frente a las agresiones físicas.

Durante el período de separación, ambos padres han iniciado relaciones de pareja temporarias. Además se ven periódicamente, siendo esta situación conocida por Marcelo y otras veces ocultada, reuniéndose después que el niño se ha dormido. Marcelo pide explícitamente a sus padres que vuelvan a vivir juntos.

Luego de haber iniciado la terapia de familia, el niño hace un cuadro de hipertermia severa con resistencia a la medicación específica que le produce reacciones de tipo alérgico (sin la existencia de antecedentes alérgicos previos), que lo llevaron a una internación, no pudiendo los pediatras consultados dar un diagnóstico del cuadro que se prolongó por 72 horas. A través

de su enfermedad Marcelo consigue un mayor acercamiento de sus padres que comparten junto a él estos días de internación y los días subsiguientes, situación que los llevaba a permanentes replanteos sintiéndose entrampados por la severidad de la crisis del niño. El que a su vez en las sesiones familiares aumentaba sus intentos de reunión de la pareja de padres.

La indicación en este caso fue el tratamiento de la pareja.

Alejandra, de 9 años, hija única, es traída a la consulta por presentar una enuresis secundaria, diurna y nocturna, dificultades en el sueño, pesadillas, y temores nocturnos.

Sus padres están separados desde hace 3 años, momento en que aparece la sintomatología anteriormente descripta.

Su padre vuelve a formar pareja, simultáneamente a la separación, unión de la que nace un niño que en ese momento tiene seis meses. El nacimiento del hermano ha agravado notablemente su síntoma.

Coincidiendo con este nacimiento, inician una terapia de familia combinada, en que semanalmente es atendida la madre y la hija por un lado, y en otras entrevistas también semanales la niña, el padre, su pareja y el bebé.

A partir de estas entrevistas, se muestra excitada, con francas manifestaciones de ansiedad, sin modificación de su sintomatología, y con dificultades actualmente en el aprendizaje.

La indicación fue terapia conjunta de la niña con la madre, y paralelamente se efectúan sesiones con el padre, con el objetivo de modificar las reglas que mantienen el síntoma.

Estos casos, habían sido tratados de acuerdo a principios que en general compartimos, aceptados por la mayoría de los terapeutas familiares, y que se refieren a que la entrevista con toda la familia presente, permite considerar una mayor cantidad de indicadores para reconstruir la espiral de interacción, y posibilita contar con más alternativas para efectuar intervenciones.

De nuestra casuística se desprende que el tratamiento con toda la familia presente, puede resultar inadecuado, especialmente cuando el subsistema conyugal está en crisis, ya se ha

disuelto, o cuando uno o ambos de los cónyuges ha constituido otra familia.

En este último caso existiría una mayor contraindicación, cuando el paciente identificado hijo no convive con el progenitor que ha formado una nueva familia.

Otro indicador a tener en cuenta es el momento en que aparece el problema, es decir con anterioridad, durante, o con posterioridad a la crisis del subsistema conyugal.

Consideramos que se puede operar sin el miembro que no convive con el niño, pues si bien él puede haber estado presente cuando comenzó el problema, el hecho de que persista después del cambio de la estructura del sistema, indica, como dice Sluzki, que "el sistema aprendió a usar los síntomas para resolver no un problema que ya puede haber desaparecido, sino un tipo de problemas, es decir que el sistema aprendió a usar los síntomas para resolver problemas".

En este caso puede operarse sólo con los miembros más implicados en las reglas que mantienen los circuitos disfuncionales de la interacción.

Cuando la crisis matrimonial está en proceso hemos comprobado que puede obtenerse mayor éxito si se trabaja sólo con este subsistema. Las reglas pueden modificarse sin incluir al hijo.

La búsqueda de una mayor precisión en los criterios para seleccionar los miembros con los cuales trabajar, y que son necesarios para modificar los circuitos de interacción no está agotada, por el contrario creemos está recién en el comienzo.

Pensamos que ella debe tender a seleccionar adecuadamente a los miembros que están involucrados en los circuitos disfuncionantes de la espiral de interacción.

Creemos que estas consideraciones no quedarán limitadas sólo a familias que presentan esta fractura, sino que podrán servir de punto de partida para otros grupos familiares en que no sea posible trabajar con la totalidad de sus miembros.

### Resumen

Se analizan distintas situaciones que se presentan en la práctica de la Terapia Familiar, en las que el terapeuta debe decidir con cuáles miembros de la familia va a operar.

Mediante la presentación de casos clínicos referidos a grupos familiares en los que el subsistema parental está en proceso de disolución, o ya lo ha completado, se describen estrategias inadecuadas de selección, que producen por sí mismas el reforzamiento de los problemas que motivaron la consulta.

La finalidad del trabajo es llegar a establecer criterios que permitan un abordaje adecuado, para no provocar situaciones que puedan tornarse "iatrogénicas".

### Summary

We analyze diverse situations which come up in the practice of Family Therapy when the therapist must decide with which of the family members he is going to work.

Through the presentation of clinical cases referring to family groups in which the parental subsystem is in the process of dissolving or already has done so, we describe inadequate selection strategies which in themselves reinforce the problems which motivated the consultation.

The objective of our paper is to establish criteria which allow an adequate approach in order to avoid provoking situations which may become "iatrogenic".

### Bibliografía

- ACKERMAN, NATHAN W.: *Psicoterapia de la familia neurótica*. Ediciones Hormé, Buenos Aires, 1969.  
BATESON, GREGORY, y otros: *Interacción Familiar*. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1974.

### SELECCION DE LOS MIEMBROS EN LA TERAPIA FAMILIAR

- GRINBERG DE OTTADO, L. y PALENQUE DE SEINELDIN, RINA. *Reflexiones acerca de la terapia familiar con niños*. Actas del Segundo Congreso Argentino de Psiquiatría Infantil, Buenos Aires, Noviembre, 1979.  
HALEY, Jay: *Terapia no convencional. Las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson*. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1980.  
MINUCHIN, SALVADOR. *Familias y Terapia familiar*. Granica Editor, S.A., Barcelona, 1977.  
SLUZKI, CARLOS (compilador). *Psicopatología y Psicoterapia de la pareja*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.  
SOIFER, RAQUEL. *Psicodinamismos de la familia con niños*. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1980.  
WALROND-SKINNER, SUE. *Terapia familiar*. Edit. Crea, Colección Anesa. Bs. As., 1978.  
WATZLAWICK, PAUL. *El lenguaje del cambio*. Editorial Herder, Barcelona, 1980.

---

Familia. Una novela . . . familiar

---

Lic. ESTELA S. DE GURMAN

---

*Viamonte 2660, 7º, A. 1056 Buenos Aires, Argentina.*

---

*Vale decir, pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo.*

S. Freud  
*El poeta y el fantaseo*

Si una de las tareas del ser humano en crecimiento, consiste en el desasimio de la autoridad parental, y como condición para el progreso de la sociedad se hace evidente la necesidad del enfrentamiento generacional, evidentemente el campo de batalla en que confluyen ambas situaciones es el ocupado por el espacio llamado familia . . .

Para Levy-Strauss la existencia de la familia es al mismo tiempo, la condición y la negación de la sociedad<sup>1</sup>.

Desde otra perspectiva podríamos decir que es el espacio donde el deseo transita y donde al mismo tiempo encuentra su limitación. En tanto transitar irá enhebrando un collar en el tiempo. Tiempo que adquiere las más de las veces la cualidad del tiempo mítico, y deseo que suele cristalizarse y detenerse en el síntoma y la enfermedad. Situaciones que no hacen sino poner de relieve aquello que existe en todos, pero de lo cual tomamos conocimiento cuando realizamos una lectura detenida de la llamada "novela familiar . . ."

Dice Freud: "...quien conozca la vida anímica del hombre, sabe que no hay cosa más difícil para él que la renuncia a un placer que conoció. En verdad no podemos renunciar a nada; sólo permutamos una cosa por otra; lo que parece ser una renuncia es en realidad una formación de sustituto o subrogado..."<sup>2</sup> Como de sustitutos se trata recordemos lo que se plantea precisamente en *La novela familiar del neurótico*...<sup>3</sup>

Luego de un período de intensa idealización de los padres, período en que, amén de considerarlos como los mejores, y como "fuente de toda autoridad y creencia", el niño o la niña entran en un período de desilusión, a causa precisamente de que los deseos infantiles más intensos sufren una serie de derrotas (presencia de hermanos que hacen realidad la vida sexual de los padres y comparación o establecimiento de diferencias con otros padres).

De esta desilusión surgirá una creación que contendrá precisamente los elementos que hacen a la expresión de una moción desiderativa rectificadora de la realidad vivida.

Moción desiderativa, actividad de fantaseo mediante, que incluye ahora a dos tipos de padres, los verdaderos y los que no lo son. Verdaderos no en función de una realidad material, sino de un deseo; padres de alta alcurnia, omnipotentes, etc. (como los que se ilusionó) y padres degradados, de baja condición, etc., como los que se "conoció", padres adoptivos los primeros y padres abandonantes estos últimos.

Podríamos decir padres que "nos eligieron", "nos desearon", para quienes fuimos el príncipe esperado o la princesita anhelada... Hijos del narcisismo...

Y de esto precisamente se trata cuando invertimos la situación y la miramos desde la perspectiva paterna y materna...

"El niño debe tener mejor suerte que sus padres, no debe estar sometido a esas necesidades objetivas cuyo imperio en la vida hubo de reconocerse. Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no han de tener vigencia para el niño, ... "His Majesty the Baby", como una vez nos

creímos. Debe cumplir los sueños, irrealizados deseos de sus padres...<sup>4</sup>

En una situación totalmente especular, nos encontramos con aquellos padres que una vez niños ilusionan tener a su vez padres todopoderosos y quienes con la vuelta de la vida, ven o buscan en sus hijos, la grandeza no realizada sino en sueños, de aquel deseo permanentemente insatisfecho.

Como si la fuerza de un ideal circulara sin término de generación en generación...

Por otra parte sabemos que amén de la búsqueda añorada de una perfección ligada a las vivencias infantiles, donde la exaltación de los padres, pudo provenir en parte de la situación de indefensión del niño, también en la sustitución que marca el intento de regreso a esa situación, se encuentran elementos propios de la situación edípica: rivalidad, búsqueda de un modelo, amores en conflicto.

Dos familias: la de la primera infancia y la familia de la desilusión.

Dice Freud: partamos de las dos familias entre las cuales la saga hace jugar el destino del hijo<sup>5</sup>. ¿A qué dos familias se refiere Freud aquí?, ¿a las dos familias de la novela familiar, la degradada y la enaltecida; a la de la saga (historia del héroe nacido en alguna situación extraordinaria y luego recogido o albergado por padres nobles)?

O a aquellas dos familias, de las cuales habla en *Psicología de las masas y análisis del Yo*, diciendo: Toda vez que dos familias se alían por matrimonio, cada una se juzga la mejor o la más aristocrática a expensas de la otra... (Narcisismo de las pequeñas diferencias)<sup>6</sup>.

Por eso podríamos plantearnos: ¿por dónde pasan las diferencias? ¿Se tratará de que alguien es diferente al Ideal sustentado desde la época primigenia, en que la Perfección era reina? ¿No ha nacido el príncipe azul, o la princesa maravillosa? ¿O alguien es diferente porque hace presentes esas diferencias que marcan una alianza?...

Cuando una familia consulta por un niño casi inmediatamente surgen (en forma de reproches generalmente) "se parece

ESTELA S. DE GURMAN

a...”, “es como el padre”, o “es como alguien de la familia de la madre”... Habitualmente lo que se asigna es que este niño aporta algo diferente a lo esperado, resulta “extraño”. Al ser como alguien suele marcar a su vez una desilusión (para alguno de los padres) en el sentido que no lo es en relación a algún otro modelo...

El destino del hijo se juega en la conflictiva historia de los deseos no satisfechos, de estos padres que son remitidos a su propia infancia y que buscaron en este campo de batalla dirimir la irresuelta situación de la familia noble y la familia degradada. Como en los cuentos de príncipes y princesas el sexo no existe. O si la sexualidad existe, deviene la degradación, el reino de la felicidad es invadido por los “bárbaros pueblos primitivos” o culturalmente inferiores, que al igual que los hermanos, advinieron para desalojar al principito de su cuna de oro, e imponer la violencia de una lucha donde la sexualidad va ganando dominio.

Sexualidad que remite a establecimiento de las diferencias sexuales (complejo de castración mediante) y que puede subsumirse en un subrogado donde las diferencias se planteen en términos del tener o no tener, en planos tan disímiles como los que pueden embanderar a una familia como mejor que otra (ya sea porque económicamente tiene, o tiene salud mental, o tiene abolengo, o tiene cultura).

La alternativa estafa dada por el tener o no tener. Por lo tanto si esta situación se convierte en lucha, uno de los términos del conflicto tendrá que quedar marcado por la impotencia del no tener para que el otro pueda aparecer teniendo.

Vayamos ahora a un caso, que por su dramaticidad plantea casi como una caricatura algunas de estas situaciones que he señalado. Podríamos casi leer este material como un fragmento de una novela, ya que las determinaciones productos de la fantasía y del deseo, pueden llegar a tener una fuerza, que erróneamente solemos adjudicar tan sólo a la supuesta irrealidad de la producción literaria.

Vienen a la consulta una pareja de padres a quienes la

dirección del Jardín de Infantes al que asiste su hijo Nicolás, de 5 años, les ha pedido un psicodiagnóstico a los fines de poder *prever* cómo funcionará este niño en primer grado, ya que su comportamiento les despierta preocupación (a la autoridad escolar).

En la primera entrevista la terapeuta toma conocimiento de que Nicolás es el mayor de tres hijos adoptivos, siendo que el del medio, Santiago, falleció el año anterior ahogado en una pileta de la casa que habitaban, y que el menor, que a la fecha de la consulta tiene 5 meses, fue adoptado por una decisión tomada antes del accidente.

En lo que hace a los motivos de la consulta, los referidos a la actividad escolar tienen que ver con presuntas dificultades en la motricidad fina, el no dibujar la figura humana, dificultades en los planos (...?), etc., y también falta de atención, dispersión y actitudes desafiantes con la maestra (subirse a una mesa y amenazar con tirarse, etc.). Aclaro que respecto a los primeros motivos, la mamá, quien se considera una persona experta en enseñar actividades plásticas a niños, parece sentir una especial preocupación (ofensa), dado que parece marcarle a ella que hay algo que no puede o que no le salió bien.

Desde otra perspectiva también les resulta afligente que Nicolás (aun en momentos denominados “los más felices de la familia”) comience a decir: “estoy solo, yo lo quiero a Santiago”, etc., o que llore por insignificancias (es decir, Nicolás hace presente una falta...).

No obstante, la mamá especialmente parece aceptar la pérdida con *resignación*, ya que dice que fue designio de Dios..., por lo tanto nada debía cuestionarse.

Aclaro que la descripción del accidente no deja dudas de que hubo serios descuidos y falta de atención sobre Santiago, quien por otra parte parecía estar signado desde el vamos y en palabras de un médico eminente, como “la cruz con la que deberían vivir siempre”. (Se trataba de un chico débil, con problemas para alimentarse, y otros). Marta, la mamá, llega a decir: “Yo tuve que criar dos hijos muy diferentes, uno fuerte y otro endeble”. En nuestro términos uno parecía marcar el

poder o tener y otro no, situación que llevada al extremo podría plantearse en términos de vida y muerte (si uno puede, el otro no).

Significativamente, las adopciones de estos tres niños, vinieron signadas por una fantasía previa a la comprobación de una esterilidad sin bases orgánicas y que pre-existe al matrimonio mismo.

Marta recuerda que estando de novios, tuvo una conversación con el que sería su marido, acerca de qué ocurriría si no pudieran tener hijos. Y recuerda un episodio donde al ver una película acerca de los campos de concentración y la muerte de chicos judíos, ella planteó que *agarraría* cualquier chico ya que no entendía cómo alguien podía matarlos... Podríamos decir aquí que si el designio acerca de la vida y de la muerte proviene de Dios, la constelación fantástica sobre la que se edifica esta historia familiar, parece estar imbuida de ideas omnipotentes, ya que incluso la biología misma se relativiza y niega, puesto que estos hijos, productos de "embarazos mentales" (tal como ellos lo dicen), son asimilados sin marcar diferencias a los hijos engendrados biológicamente: no eligen sexo, y toman al que viene como el recién nacido que han engendrado en conversaciones mantenidas entre ellos y con sus familias.

Precisamente estas familias (las de ambos), tienen ciertas peculiaridades: los respectivos padres se han separado, y vuelto a casar (en más de una ocasión alguno de ellos), lo que multiplica la presencia de hermanos y medio-hermanos postizos. Ellos dicen que "sus hijos" tienen actualmente por lo menos ocho abuelos. Una de las media-hermanas de Marta fallece a los 15 años, cuando ésta tenía 28; y uno de los medio-hermanos de él, fallece de muy pequeño...

Por supuesto el material expuesto es muy sucinto y tiene carencias, no obstante podemos replantearnos qué precede a la constitución de una familia, y en qué medida, adopciones reales o no, la situación que lleva al planteo del origen (novela familiar) incluye una elaboración mítica que se halla en el seno de nuestra cultura. Elaboración que trata de resolver contradic-

ciones, aunque en realidad éstas aparezcan como opuestos difíciles de dialectizar, ya que se trata en realidad de oponer diferencias que ponen sobre el tapete la incompletud del sujeto humano y su finitud.

La herida narcisista busca ser restaurada, los hijos ofrecen un camino, las creencias también, la ilusión señorea, y el malestar de la cultura nos vuelve inermes, tanto como el niño que ahora tener padres todopoderosos y derrotar allí al dolor...

### Resumen

En este trabajo se trata de mostrar algunos aspectos del interjuego fantasioso estudiado por Freud en *La novela familiar del neurótico*, y que se hallarían en la base de la constitución de cualquier familia.

Se trata en otros términos de la problemática que gira en torno a la idealización infantil de los padres, al proceso de desidealización, y a los procesos de investidura narcisista que pone en juego la idea del hijo.

Se desarrolla el tema ilustrándolo con un material clínico.

### Summary

This paper attempts to show some aspects of the phantasmatic interplay studied by Freud in "Family Romances", and which may be found in the basis of the constitution of any family.

It deals with questions that involve infantile idealization of the parents, the process of disidealization, and the processes of narcissistic cathexis which the idea of the child puts into play.

The subject is illustrated with clinical material.

### Bibliografía

1. LEVI-STRAUSS, C., *La familia*, "Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia", Ed. Anagrama.
2. FREUD, S., "El creador literario y el fantaseo", *O.C.*, T. IX, Ed. Amorrortu.
3. — "La novela familiar del neurótico", *O.C.*, T. IX.
4. — "Introducción del narcisismo", *O.C.*, T. XIV.
5. — "Moisés y la religión monoteísta", *O.C.*, T. XXIII.
6. — "Psicología de las masas y análisis del Yo", *O.C.*, T. XVIII.

---

### El enfermo orgánico: de la relación médico-paciente a la terapia familiar.

---

Dr. SAUL KAROL

---

3 de Febrero 1729 - 1426 Buenos Aires.

---

Me propongo en este trabajo mostrar a través de la observación y la propia experiencia, de cómo se pudo encontrar a la familia desde distintos desarrollos profesionales. Nos planteamos vertientes que si bien no agotan las vías de acceso a la problemática, las juzgamos abarcativas de situaciones tipos. Lo pensamos entonces arribando desde, por ejemplo,

- el tratamiento de la psicosis
- el abordaje de problemas de pediatría
- el enfoque comunitario o social
- en el poder observar déficit o posibilidad de enriquecimiento de la terapia individual
- la limitación operativa frente a conflictos aparentemente individuales pero que involucren básicamente una situación vincular
- desde el approach a la enfermedad orgánica.

En mi caso me propongo exponer sobre este último punto, con el agregado que esa aproximación, prefiero hacerla desde

un campo específico que como médico me corresponde, el de la institución hospitalaria, en donde mi experiencia aun en mis años de estudiante primero, practicante y médico interno en guardia después, y sobre todo, como interconsultor de un servicio psiquiátrico pionero incluido en un Hospital General. Compartiré con Uds. la experiencia y esfuerzos de esos maestros y colegas a quienes reverencio.

Es justamente desde ese rol donde nuestra formación psicológica sufre el embate de experiencias que en realidad no nos eran novedosas como médicos, pero sí que al ser nuevamente sujetos privilegiados, en tanto actores y observadores de conductas, nos obligó a leer datos que no eran en lo científico o técnico lo suficientemente interpretados hasta ese momento; hablo de los primeros años de la década del sesenta, entre 1960 y 1967. Ya en un trabajo de esa época presentado al IV Congreso Argentino de Psiquiatría con la colaboración en el aspecto metodológico del Dr. Carlos Sluzki definíamos nuestra tarea como la de ponernos en contacto con lo que bautizamos "situación enferma" y al paciente como emergente de una situación familiar enferma. Esto implicó el pasaje del enfoque de la relación médico paciente tradicional, bipersonal y excluyente, a objetivar un campo donde se encuentra el cuadro patológico ocupando el centro y luego en círculos concéntricos y progresivos, el del paciente, el de la familia y el del entorno técnico, incluido en el mayor y abarcativo de la propia institución. Este concepto de situación nos ubicó en una realidad que arrastrábamos de los faldones de nuestros guardapolvos: los familiares que estaban o junto con el paciente o en el pasillo por lo general. Hasta ese instante, habían sido *datos* sobre los que inquiríamos al paciente en la entrevista, y ya era una audacia frente a una medicina que solía moverse sólo en el círculo más pequeño, el del caso en sí. Indagar sobre la composición del grupo familiar, sus características, sus conflictos, la repercusión de la enfermedad sobre ellos salía del canon clásico.

Hicimos el pasaje que Epstein describe en 1971 desde Canadá en su propia evolución como terapeuta familiar en tres

etapas: una fase intrapsíquica en que lo fundamental es esa dinámica individual, y los miembros de la familia son como una constelación de fantasías o imágenes a su alrededor, pero siendo siempre el enfermo un paciente designado, un chivo emisario.

La que le continúa es una fase interaccional que es aún sólo un juego de interrelaciones individuales. Y por último la fase más avanzada es aquella en que ya superados los aspectos intrapsíquicos e individuales, aun tratados como sistema, se da paso a la consideración de la estructura, de la organización y de los patrones interaccionales de la familia como determinantes del funcionamiento del sistema y afectando al comportamiento de los individuos que componen ese sistema.

En nuestra experiencia nacional lo vemos como el pasaje de cuando el psicólogo abandona la seguridad del setting conocido y va a otros campos. Pero que a la vez consideramos como el desarrollo ideal de ese psicólogo: primero en el consultorio, luego en la institución y finalmente en el campo del objeto.

Las ideas de Michael y Enid Balint, que tomábamos de sus obras *El médico, el paciente y la enfermedad*, *Las técnicas psicoterapéuticas en medicina* e incluso visitas de algunos de nosotros a la Clínica Tavistock, amén de nuestras experiencias en grupos de reflexión de su inspiración, y que acá los trabajamos con su pionero en nuestro país, el Dr. Isaac Luchina y su grupo de estudio de Perspectivas Médicas, no nos daban todavía respuestas y no eran claros los interrogantes a plantear a esas familias ni el esquema teórico con que operar. Pero no era sólo nuestro déficit, el mundo médico veía, intuía la problemática pero no tenía tampoco instrumentos diestros.

Por ejemplo, el Dr. Tumulty en 1970 publica en el *New English Journal of Medicine* que "todo médico clínico es un médico de familia", pero en ese mismo artículo dice que en su sitio de trabajo, la John Hopkins University School of Medicine, nada menos que la famosa John Hopkins, no hay sino un pequeño salón utilizable para charlas con familiares. La institución por ende no daba respuestas.

Balint mismo en un capítulo llamado "el enfermo presente y ausente", dice que al consultar al médico los enfermos

informan con frecuencia de dificultades con otras personas, especialmente con los familiares más próximos, y en muchos casos estas dificultades parecen constituir la mayor parte, si no la esencia, de la etiología de sus padecimientos. En muchos de los casos clínicos por él descritos, sobre todo cuando el clínico va a domicilio y se encuentra con los parientes y paciente en su casa, se evidencia que muchas de esas visitas son de elucidación de mecanismos y disfunciones familiares.

Y así lo observábamos en nuestro hospital: una vez superado el primer impacto de la aparición de la enfermedad, con su cohorte de animismo, cargado de culpa, magia, búsqueda de depositarios, ya estando abocados a la tarea de "organizar la enfermedad", cuando el paciente y su entorno tienen que empezar el período de cronicidad o rehabilitación, quizás de agonía también, y a encontrar transacciones entre sus costumbres habituales y las exigencias de la enfermedad, nosotros movilizamos todos los recursos disponibles, distribuimos roles, adjudicamos tareas (guardias, prescripción de medicamentos, dar esparcimientos y otros), recomendamos derivaciones o las vetamos, aconsejamos cambio de residencia, dentro o fuera de la casa (muchas veces la internación es sólo eso).

En esta tarea de organizar la enfermedad en realidad nos comportamos fundamentalmente como reubicadores del ambiente familiar y de la red social; terapeutas familiares, en fin. Lo que sucede es que así como el buen médico hace psicoterapia médica sin saberlo a veces, así hicimos y otros hacían y harán terapia familiar médica. Quiero hacer notar la ventaja que en el acceso al hogar y a la familia tienen sobre nosotros el pediatra, el clínico, el obstetra, el cardiólogo: su entrada a ese hogar, donde encuentra a la familia "a punto" es un honor y una invitación que a nosotros nos cuesta mucho lograr. Por esto actualmente estamos abocados a la conceptualización de datos y reflexión en donde nosotros prestaremos nuestra experiencia y formación como terapeutas familiares para lo que ya en EE.UU. es una especialidad, la de General Practitioner y que acá será su simil, la del médico de familia.

#### EL ENFERMO ORGANICO: DE MEDICO-PACIENTE A TERAPIA FAMILIAR

Para ello pensamos que se debe estudiar y trabajar sobre tres pilotes:

- Psicología institucional
- Aspectos y problemática del encuadre
- Terapia familiar.

Sabemos que una institución, por definición (acá tomamos la idea del Dr. Ulloa), es un organismo regulado por códigos y normas explícitas e implícitas, con una geografía dada y una ordenación del tiempo y de las responsabilidades, con objetivos para alcanzar y medios adecuados a tal fin. Que la institución hospitalaria es una institución regresiva que se ocupa del hombre enfermo y disminuido, con movimientos, articulaciones y fracturas que favorecen depositaciones proyectivas de aspectos fragmentados del self, transformándose así en pantalla receptora de objetos internos, ligados a primitivas ansiedades paranoicas y depresivas, bajo una modalidad confusional de cuya reintroyección tratan de defenderse los miembros de la institución.

Esta amplia definición, hasta quizás asustante, explica la cantidad de fenómenos que en un hospital se producen, el respeto con que se debe entrar a él y el tino con el que se debe transitar por ese lugar donde se dan las situaciones límites de enfermedad, muerte y locura. El terapeuta familiar (médico en el sentido más abarcativo), o psicológico, debe conocer las leyes del campo y manejarlas como un cirujano en un despegue de planos anatómicos comprometidos y para ello, también como un buen cirujano, debe releer su operación constantemente, ser el más entrenado y respetar las resistencias, para no lesionar de balde el delicado tejido institucional. Valgan estas aclaraciones para definir que la familia del paciente, y por ende la familia-paciente que provoca y sufre, debe ser leída en estos casos también a la luz de las leyes psicológicas de la institución.

En cuanto al encuadre, nos son rectoras las ideas del Dr. Bleger en *Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico* expuestas en un artículo de 1967. Su diferenciación entre encuadre y pro-

ceso, su concepto de que por éste discurren las variables nos sirve para sostener teóricamente nuestra experiencia de Hospital y de práctica privada con el enfermo somático.

De que aceptando a la familia del paciente permitimos un carácter procesal, "una situación enferma" de mayor movilidad a la que le estimulamos expresarse más para integrarla y brindar así un diagnóstico más abarcativo y soluciones terapéuticas más totalizadoras.

Toda institución, acorde con la definición anterior, teme a la disgregación que la pueda distraer de sus objetivos previstos con sus normas y códigos. Es de suponer que se pudo vivir a la familia del enfermo, que traía lo que tenía, con su propia desorganización (que suele ser su forma de organización en esos momentos) como un factor de perturbación y de ataque al encuadre hospitalario.

Pero entendiéndola, dándole un "holding" adecuado, no siendo vista como en las series norteamericanas en los pasillos, brindaremos a la enfermedad (que por ser individual y familiar) un marco referencial más amplio, una comprensión familiar más rica, que involucra otro modo de comprensión del ser, de la enfermedad, de la fantasía de enfermedad y curación e incluso de la muerte misma.

Finalmente, si existiese así aislada, la terapia familiar propiamente dicha ha enriquecido humana y teóricamente este acceso al acontecer humano. Se supondría que una familia que busca mostrar que nada pasa en ella tendría una actitud negadora frente a la enfermedad, comprometiendo el pronóstico mediante saboteos a la acción médica, ocultamientos conscientes o inconscientes de síntomas y quizás hasta complicidades que así comprometan la vida del paciente. El trabajar sobre estaseudomutualidad lo sabemos hacer.

Otra familia que se maneje con depositaciones destructivas en un miembro, bien poco podría desear vivamente la rehabilitación de un discapacitado. En una pareja con cisma marital, en que uno de los integrantes sufra un infarto de miocardio, seguramente el miembro no afectado cardiológicamente tendría dificultades para vencer su clásico menosprecio y desconfianza

por el otro; el llamado doloroso de la angina será poco tomado en cuenta por ejemplo.

¿Y la importancia de una familia que conocemos en la que vemos un duelo importante no elaborado? Es de suponer que mira al miembro enfermo de la familia con los ojos de todos los duelos anteriores pendientes; flaco favor para quien, siempre muy regresivo por su padecimiento, busca en sus allegados la esperanza.

Otras familias, endebles y con expectativas muy mágicas, pueden sabotear también a correctos profesionales y a justos procedimientos buscando y pidiendo consulta tras consulta confundiendo todo un cuadro y al mismo paciente, y mediante mecanismos constantes de feedback negativo a todos los agentes de salud.

¿Y un suicida frustrado? ¿Cuántas veces veíamos en el hospital que su recuperación, cuando eso ya estaba en curso, dependía casi exclusivamente de que un miembro caracterizado del grupo familiar, con frecuencia hacia el cual más ambivalencia se tenía, lo despertase con su presencia cálida y no culpógena?

Además, autores expertos en terapia familiar, han descripto tipos de familia que por su dinámica favorecen al desarrollo de enfermedades crónicas somáticas: Jackson habla de "familias restringidas" que como características presentan una reducción cuali y cuantitativa de las formas de comunicación, reducción del contacto con el mundo exterior y en el mismo seno del grupo familiar, donde lo escaso que se habla es claro e inequívoco, pero con poca carga emotiva y refiriéndose poco al interlocutor.

Salvador Minuchin también describe en ese sentido de favorecedor de enfermedades orgánicas la "homeostasis rígida" de esas familias, con poca adaptación y una restringida capacidad de los familiares para resolver los conflictos. Ellos están entrelazados por un destino común, donde cada uno invade el ámbito del otro, por lo tanto con límites interpersonales quebradizos y donde las barreras generacionales en parte están suprimidas; por esto la poca individuación hace que el compañero de relación

tenga que estar siempre disponible. Es notorio en ellos la escasísima capacidad de resignación frente a pérdidas, de hacer duelos. Su ligazón es extrema y está estancado el saldo de las cuentas de culpas y méritos.

La técnica de aproximación a la familia con un miembro ya somáticamente enfermo tendrá que ser harto cuidadosa, se debe aceptar la "oferta" de ellos, del tipo "nuestro único problema es que él está enfermo".

Así Stierlin dice, y esa es también nuestra experiencia, que se debe permitir la narración casi obsesiva del curso y anécdotas del padecimiento. Pero en un momento dado una formulación del tipo ¿qué pasaba en aquel entonces cuando se declaró la enfermedad? permite por lo menos crear un paralelismo y desplazar así el foco de atención del cuerpo y sus vicisitudes a acontecimientos que afectan a todos los integrantes. No se debe entonces relacionar tempranamente conflictos familiares con las enfermedades somáticas, porque los montos de vergüenza y culpabilidad subyacentes (en donde se mueven interrogantes del tipo de: ¿por qué alguien se enfermó? o si uno ha enfermado al otro) pueden ser catastróficos al movilizarse bruscamente: debe uno incluirse en el ámbito, en el clima emocional circundante, comprenderlo y desde ahí instrumentar el cuándo de la interpretación, el señalamiento o la técnica que el operador elija.

La familia con un miembro así enfermo es como un bloque de hielo, aparentemente impenetrable, liso y quizás frío, donde la vida interior aparece como nula. Pero ¡cuidado!, ese hielo si el terapeuta pone mucho calor se derrite y disuelve, o si se sacude muy fuerte se resquebraja.

La técnica que más resultado le dio a Stierlin, con quien decimos que coincidimos, es que no se debe ayudar recortando a cada integrante de su hielo y darle mayor identidad.

Quise con esta comunicación no transmitir sólo un punto de arranque; lo que sí pretendo es transmitir la evolución del pensamiento psicológico frente a la enfermedad de manifestación prevalentemente orgánica, teniendo siempre en cuenta que

en toda tarea, en este caso la nuestra de terapeuta familiar, no se debe comenzar inventando sino recordando.

Ubicar que la institución hospitalaria o sanatorial siempre existe en la enfermedad, aunque sea en el paso por un laboratorio de análisis clínicos, de tomografía computada, de radiología y que como tal presta distintos sentidos a la enfermedad.

Que la problemática familiar y el carácter procesal del encuadre, permite discurrir al padecimiento por un derrotero distinto, y que recordando a Balint: "hasta en la génesis de las enfermedades más inaparentes, suele existir siempre una disfunción del grupo familiar, en su origen primero y en sus consecuencias luego".

Y que nuestro adiestramiento en ellos y en redes sociales, nos permitirá ser consultores privilegiados de médicos, instituciones, personal auxiliar, lógicamente de la familia, y organizar la enfermedad, la vida y la muerte, y aun en este caso extremo preservar a todos y ayudar a bien morir y bien vivir a los supérstites, elaborando duelos y culpas.

## Resumen

El autor se propone mostrar cómo desde diversos campos de la psicoterapia se pudo encontrar a la familia.

En su caso lo hizo como miembro de un equipo de interconsulta médico-psicológica, a su vez perteneciente a un importante servicio de Psicopatología incluido en un hospital general.

Señala que en su tarea institucional, basada sobre todo en los conceptos de Michael y Enid Balint acerca de la relación médico-paciente, la familia de este último era generalmente sólo tomada en cuenta como un dato de la historia clínica, a lo más para explicarse psicodinamismos o ansiedades; que esa carencia no se daba solamente en el país, citando al respecto alguna comunicación de exterior demostrativa, que en su práctica hospitalaria, a través de indicaciones terapéuticas, plan de cuidados y administración de otras medidas y recursos, sobre todo cuando el paciente ya pasa a su hogar, se "organiza" la enfermedad y con ello se actúa sobre el medio familiar, aun sin proponérselo conscientemente.

Luego, los conceptos del doctor Bleger con respecto al encuadre

psicoanalítico y la patología de su rigidez cuando ella se presenta, los del doctor Ulloa referentes a la psicología institucional y a los fenómenos que se producen en toda institución que comúnmente se liga a la enfermedad y por último los desarrollos propios de la terapia familiar, que aún a los clásicos de psicopatología, psicoanálisis, psicofarmacología, enriquecen un modo más abarcativo, comprensivo y humano de entender al enfermo y su entorno familiar, así como a la psicogénesis de muchas manifestaciones patológicas.

Enumera luego algunos conceptos que juzga muy significativos de terapeutas familiares de renombre: Stierlin, Jackson, Minuchin. Agrega datos de su propia experiencia, y un cierto número de situaciones que ejemplifican la importancia de los conceptos aprendidos de la terapia familiar para la comprensión y tratamiento de familias con un miembro orgánicamente enfermo.

### Summary

The author intends to show how the family was niet with, working from diverse fields of psychotherapy. In his case, he did so as a member of a team for medico-psychological interconsultations within a large Psychopathology Department in a general hospital.

He points out that in his work in the institution, based mainly on one concepts of Michael and Enid Balint on the doctor-patient relationship. The family of one patient was generally taken into account only as a fact of the clinical history or at the most as an explanation of psychodynamics or anxieties; this deficit existed not only in his country, quoting a foreign text demonstrating this to be so; in his hospital practice, through therapeutic prescriptions, care plans and the administration of other measures and resources, especially when the patient goes home, the illness becomes "organized" and in this way the patient acts upon the family milieu even without meaning to do so consciously.

Later, Dr. Bleger's concepts on the psychoanalytic setting and the pathology of its rigidity when present, those of Dr. Ulloa referring to institutional psychology and to the phenomena occurring in all institutions, commonly linked with the illness, and finally, the developments of family therapy itself which write the classics of psychopathology, psychoanalysis, psychopharmacology, enrich a far-reaching, more com-

prehensive and humanitarian manner of reading the patient and his family, as well as the psychogenesis of many pathological manifestations.

The author then enumerates some very meaningful concepts of family therapists of reknown: Stierlin, Jackson, Minuchin. He adds facts from his own experience, and a member of situations which exemplify the importance of one concepts taught by family therapy for one understanding and treatment of families with an organically ill member.

### Bibliografía

- BALINT, ENID y MICHAEL. *El médico, el paciente y la enfermedad*. Ed. Libros Básicos.
- BALINT, ENID y MICHAEL. *Técnicas psicoterapéuticas en medicina*. Siglo XX.
- BALINT, ENID; NORELL, J. S. *Six minutes par patient*. Paris, Payot. Colección Ciencias del hombre.
- VALABREGA, JEAN PAUL' *La relation thérapeutique: malade et médecin*. París, Flammarion.
- La integración de la asistencia psiquiátrica en los servicios de un Hospital General: la función consulta. Comunicación presentada al IV Congreso Argentino de Psiquiatría realizado en Mar del Plata y coordinado por el Dr. Carlos Sluzki en colaboración con el departamento interconsultor del servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico Aráoz Alfaro.
- PICHON - RIVIERE, ENRIQUE. *Conceptos básicos en medicina psicosomática*.
- ULLOA, FERNANDO. "Psicología de las instituciones". En: *Rev. de Psicoanálisis*, V. XXVI, No. 1, 1969.
- MENZIES, ISABEL E.; JAQUES, ELLIOT. *Los sistemas sociales como defensa contra la ansiedad*. Hormé, Psicología de Hoy.
- BLEGER, JOSE. "Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico". En: *Rev. de Psicoanálisis*, V. XXIV, No. 2, 1967.
- JACKSON, D. D. y YALOM. *Family research on the problem of ulcerative colitis*.
- MINUCHIN, SALVADOR. *A conceptual model of psychosomatic illness in children. Family organization and family therapy*.
- STIERLIN, HELM; WETZEL; RUCHER-EMBDEN, WETZEL. *Terapia de familia. La primera entrevista*.

---

Abordaje de la familia con un "paciente orgánico" crónico

---

Dra. ANALIA KORNBLIT\*, Dra. SILVIA WASERTREGUER\*\*  
y Lic. JAIME SZWARSTEIN\*\*\*

---

*\* Moldes 1243, 1426 Buenos Aires; \*\* Rawson 3753, 1636 La Lucila, Prov. de Buenos Aires; \*\*\* Aráoz 2471, 1º, 4, 1425 Buenos Aires.*

---

Describiremos un modelo de abordaje médico-psicológico de familias con un miembro diabético, si bien pensamos que el planteo es extensible a otras enfermedades crónicas, independientemente de su etiología.

La necesidad de incluir un abordaje psicológico en estos casos surgió a partir de la evidencia, a lo largo de reiteradas experiencias con este tipo de pacientes, de que la enfermedad crónica produce efectos emocionales en la familia como sistema afectado por la enfermedad de uno de sus miembros, que interfieren en el aprovechamiento de la consulta médica y en el manejo adecuado de la enfermedad.

Se verifican así distorsiones en lo cognitivo, al nivel de la información suministrada por el médico, o se evidencian oscilaciones en el curso de la enfermedad, no atribuibles a la afección en sí misma.

La contribución de la psicología médica al abordaje de estas situaciones se verifica pues en dos áreas:

a) en el área de lo *cognitivo* vinculado a la enfermedad: se trata de que surjan y aclaren las distorsiones en la información

que el grupo familiar maneja acerca de la enfermedad. Esto es de particular importancia en el caso de la diabetes infantil, en la que se requiere una actividad de "co-médicos" de parte de los padres. Estas distorsiones están ligadas a las creencias relativas a la enfermedad, que se manejan en la mayoría de los casos de un modo acrítico, al estilo de lo que en terapia cognitiva se denominan "pensamientos automáticos", vale decir, representaciones de la realidad o del sí mismo que no son cuestionadas y que surgen espontáneamente, variando en cada sujeto.

Las creencias primitivas, muchas veces transmitidas a través de mitos populares y familiares, son responsables de la distorsión involuntaria de la información dada por el médico, y consecuentemente pueden llevar a conductas no coherentes en el manejo de una enfermedad de por sí lábil como la diabetes, que exige una sistematización rigurosa para su control.

Puede definirse a las creencias como el elemento cognitivo de las actitudes de una persona, aquello que lo llevará a actuar de un modo u otro. En el caso específico de una enfermedad, en este caso la diabetes, las creencias acerca de ella imperantes en una familia determinada, tendrán un doble origen. Existe por un lado un aspecto consensual acerca de la enfermedad, que está determinado histórica y culturalmente, como lo prueban más drásticamente las imágenes populares sobre la lepra, la locura, etc. Junto a este acervo de imágenes provisto por la cultura en un momento determinado, están las ideas provenientes del núcleo familiar específico de que se trate, para el que la enfermedad representará aspectos emocionales determinados, ligados en general a su historia.

En el caso de la diabetes, el supuesto factor hereditario, por ejemplo, hará que se busquen coincidencias con los antecesores portadores de la enfermedad, si es que existen.

Se crea así una verdadera mitología en torno a la enfermedad, que cada familia toma como incuestionables, y contra la que muchas veces se estrella la información provista por el médico.

Nuestro *modus operandi* con estas familias incluye el

análisis detallado de dicha mitología, vale decir, no rechazarla de plano y en primera instancia, sino meterse en ella remontando sus orígenes para encontrar su sentido y eventualmente sus contradicciones.

Pensamos que el provocar la emergencia de las creencias primitivas acerca de la enfermedad es una valiosa herramienta en la tarea de su cuestionamiento y corrección, con miras a una mayor eficiencia en la conducta vinculada al control de la enfermedad.

Esta tarea puede llevarse a cabo con una familia o con un grupo, por ejemplo de padres. En este último caso el grupo es un importante factor en cuanto a la posibilidad de cotejo de creencias e información, y de visualizar otras alternativas que las propias en el procesamiento del impacto de la enfermedad. El grupo facilita, pues, la elaboración de la información pertinente, como momento posterior a la emergencia de las diferentes versiones que cada pareja trae a la reunión.

A título de ejemplo, citaremos el trabajo realizado en un grupo en torno a la posibilidad o no de que un niño de menos de cinco años sea capaz de registrar los síntomas de la hipoglucemia sin confundirlos con otros estados. Los padres que sostenían la creencia de que no era posible, no tuvieron más remedio que revisarla, frente a experiencias contrarias a las suyas aportadas por otras parejas, y comenzar entonces a vislumbrar los vínculos disfuncionales presentes en su medio familiar, lo que los llevó a solicitar una consulta a un psicoterapeuta familiar, posibilidad que habían rechazado hasta ese momento, a pesar de las sugerencias en ese sentido del pediatra, quien percibía la modalidad altamente conflictiva de sus interacciones.

b) En el área de la consideración de la *dinámica familiar* ante el impacto de la enfermedad crónica.

A título de hipótesis cabe plantearse la relación existente entre el tipo de vínculos emocionales e interaccionales preexistentes en la familia y la emergencia de la enfermedad en uno de sus miembros, aun cuando la complejidad del tema hace que sólo mencionemos aquí esta relación. Lo que sí enfocaremos es

la particular configuración que adopta el sistema familiar ante la enfermedad orgánica crónica.

Si bien esta última constituye un tipo de límite que no existe en las afecciones psiquiátricas, el rol del enfermo orgánico puede ser entendido del mismo modo en que se conceptualiza el de paciente identificado como enfermo mental.

Bajo esta óptica el comportamiento sintomático debe ser descifrado en términos de qué está pasando al nivel de las relaciones entre los miembros de la familia, concebida como un sistema. El problema a enfocar estará más *entre* las personas que *en* la persona que presenta síntomas.

Todo sucede como si sobre la marca de la enfermedad orgánica se entretijera una red vincular cuya forma obedece a la particular conflictiva de la familia, que engloba el hecho de la enfermedad, sin que esta última sea su "causa", como se pretende mostrar a nivel de la ideología familiar.

Nuestro modelo de trabajo en estos casos apunta a la elaboración de técnicas específicas para cada familia, tendientes a lograr una mayor autonomía del paciente en cuanto al manejo de su enfermedad, graduada según la edad.

No es esperable, en el caso de la diabetes, que un niño de menos de diez años se administre solo insulina, pero sí que discuta con su familia la dosis a administrar, y que reconozca precozmente los signos de hipoglucemia. Si esto no sucede, podemos pensar que estamos frente a un caso en que la enfermedad orgánica ha sido tomada como blanco de interacciones disfuncionales, en un sistema que obstaculiza el libre desenvolvimiento de sus miembros como resorte para mantener un equilibrio insatisfactorio pero estable.

S. Minuchin califica a cierto tipo de diabéticos como "psicosomáticos", atendiendo a la labilidad de sus reacciones orgánicas, que encontró en correlación con una particular estructura familiar, reconocible en la generalidad de las patologías psicosomáticas. Investigando sobre estos casos pudo comprobar que en ciertos niños diabéticos se verifica en determinados momentos un clímax emocional ligado a conflictos familiares, que desemboca invariablemente en consecuencias somáti-

cas del tipo de crisis hipo o hiperglucémicas. Lo que Minuchin evaluó fueron ciertos patrones cíclicos de interacción en este tipo de familias, que a la vez mantienen y son mantenidos por el comportamiento psicosomático del niño enfermo.

Los rasgos distintivos de este tipo de familias son, según el mismo autor: indiscriminación ("enmeshment"), sobreprotección, rigidez, evitación de los conflictos, desviación de los conflictos y falta de resolución de los conflictos.

Si bien esta caracterización nos parece altamente operativa en la práctica clínica, nuestro enfoque apunta a una conceptualización algo distinta.

Se ha vinculado la aparición de desórdenes psicosomáticos crónicos, así como de enfermedad mental grave en uno de los miembros de la familia, con la complementariedad rígida como estructura relacional de la pareja parental.

La emergencia de síntomas en uno de los hijos expresa en este caso la tendencia del sistema a la búsqueda de un nuevo tipo de organización, en la medida en que el modelo complementario es recreado en la relación de uno de los padres, precisamente el ubicado en la posición "one-down" y el paciente identificado.

Este nuevo vínculo complementario equilibra de algún modo la posición del progenitor "one-down" en el sistema, dado que su alianza con el paciente identificado balancea su posición.

Frente a esta estructura es probable que el terapeuta familiar que trabaja sistémicamente se oriente hacia el empleo de alguna técnica de simetrización dirigida a la pareja paterna, con el objetivo de "liberar" al paciente identificado de su rol balanceador. Si tal intervención es efectiva es probable que se produzca un cambio drástico, capaz de provocar asombro aun en el terapeuta que lo proyectara.

Creemos que este asombro es un equivalente de una señal de alarma. En efecto, sabemos desde Bateson que cualquier cambio en un sistema debe permitir que los mecanismos reguladores continúen operando, o de lo contrario dicho cam-

bio es potencialmente patológico, probablemente en otro nivel de funcionamiento.

Estaríamos aquí frente al error epistemológico de abocarnos a un aspecto del sistema, en este caso el síntoma, sin tener en cuenta el circuito global en el que dicho síntoma se inscribe, aun cuando operemos aparentemente con intervenciones que engloben a todos los miembros de la familia.

Pretender simetrizar un subsistema parental que funciona de un modo rigidamente complementario equivaldría a pretender, en términos de Bateson, llegar a cambios en el nivel tres del aprendizaje, que es doble alcanzar en psicoterapia, según su propia apreciación, "sólo de tanto en tanto", en la medida en que implica reorganizaciones profundas de las reglas que lo rigen.

Surge aquí el interrogante de si es posible "des-triangular" en este caso al paciente psicosomático sin apuntar al cambio estructural mencionado más arriba. Nuestra idea es que esto es posible, aun sin introducir en el sistema elementos que posibiliten saltos bruscos, sino oscilaciones en un nuevo rango de funcionamiento, amplificando las fluctuaciones del sistema, de acuerdo por lo postulado por el físico belga Ilya Prigogine. En este sentido, la emergencia sintomática puede considerarse como una fluctuación a partir de la complementariedad rígida a la que apuntala. Se trata, pues, de una situación de oscilación que el terapeuta podrá capitalizar para alcanzar oscilaciones en otro nivel de funcionamiento.

Estando la oscilación centrada en torno a la complementariedad, pensamos que es sobre este tipo de relación sobre el que se debe trabajar, en una especie de "remodelamiento" del vínculo complementario, para lo que eventualmente puede recurrirse a breves incursiones en lo simetrizante.

Nuestro modelo de trabajo incluye tres esferas de acción simultáneas, en torno al objetivo anterior:

1) a nivel de la pareja parental: uso de una técnica de simetrización momentánea que aliente la reestructuración de la complementariedad a un nivel menos rígido.

2) a nivel de la pareja padre (o madre) - paciente identificado: introducción de alguna situación que lleve a la alternancia "one-down" - "one-up" entre ambos, ya sea psicodramáticamente o a través de prescripciones. Esta alternancia es postulada como teniendo un valor de deuterio-aprendizaje en relación al sistema en su conjunto.

3) a nivel del subsistema filial (si existen hermanos): explorar el tipo de relaciones existentes y fortalecerlo como subsistema, a través de prescripciones que engloben a sus miembros en un contexto diferenciador con respecto al subsistema parental.

El modelo encara también la necesidad de que se produzca en este tipo de familias lo que G. Bateson ha denominado el "tocar fondo", como paso previo a toda posibilidad de cambio.

Una familia que frente a la emergencia por ejemplo de la diabetes en un hijo (aunque consideramos que lo mismo es válido para cualquier enfermedad crónica), no atraviesa por un momento de pánico y confusión, es probable que produzca descompensaciones periódicas corporizadas orgánicamente en el enfermo, pero que pueden concebirse como vicisitudes de las interacciones familiares, que a través del descontrol mantienen circularmente un estado de indiscriminación (en el sentido en que Minuchin habla de "enmeshment").

Los episodios de hiper e hipoglucemia pueden así entenderse como *shocks* al nivel de la interacción familiar, destinados a regular el sistema mediante descargas tendientes a mantener un estado permanente de alerta y zozobra que obliga a ese peculiar estar pendiente todos de todos.

Las descompensaciones del diabético son así ofrecidas por él a su familia como medio de lograr un sentimiento de unión en torno a él, en una típica relación complementaria en la que alguien debe ser cuidado y otros se encargan de cuidarlo, sin lo cual el supuesto es que el sistema familiar podría fragmentarse.

El "tocar fondo" asume, pues, en estas familias, el doble sentido de tomar contacto con el riesgo de muerte planteado por la enfermedad y con el alto nivel tensional presente en la

relación parental, oculto por las exigencias planteadas por el cuidado del enfermo.

Frente a este panorama la estrategia terapéutica consistirá en lograr elevar la tensión en el sistema sin que éste recurra a los vaivenes de la enfermedad, que se busca que quede descentrada.

La elevación de la tensión es usada para amplificar las fluctuaciones ya presentes en el sistema. El objetivo de dicha elevación no es lograr un salto a otro tipo de estructura vincular, como sería pasar de lo complementario a lo simétrico, sino mejorar las condiciones del funcionamiento complementario.

Como es obvio esto requiere de parte del terapeuta una acabada convicción acerca de los mecanismos de adjudicación de papeles en una familia, sin lo cual no logrará introducir *inputs* de tensión capaces de revertir los canales habituales de expresión de conflictos. Sobre todo temerá que un aumento de tensión lleve a un empeoramiento en la situación del enfermo. Si bien éste es un riesgo siempre presente en sistemas altamente rígidos, la experiencia nos dice que la cronicidad, no de la diabetes, sino de los mecanismos de triangulación del enfermo, sólo puede revertirse a través de intervenciones que provoquen un reordenamiento de los elementos del sistema. Dependerá de la capacidad creativa del terapeuta el lograrlo.

El uso de la metáfora, las técnicas psicodramáticas y las intervenciones contraparádojales son para nosotros un valioso instrumento en esta tarea.

De lo anterior se desprende que planteamos el trabajo con estas familias a nivel cognitivo (individual o grupal), como un primer paso en el abordaje de los factores psicológicos.

Como es sabido, este tipo de familias se caracteriza por su dificultad en la posibilidad de simbolización de los conflictos y por el control de las emociones. Nuestra experiencia hasta ahora es que al comenzar a tratar las distorsiones en la información se abre una brecha que lleva en gran parte de los casos a poder encarar la tarea a nivel de la interacción.

De todos modos aceptamos que la disociación mente-cuerpo

es en este tipo de sistemas una defensa rígida frente a la que no caben posturas ingenuamente optimistas. Lo que sí es dable esperar, operando con plazos breves (10 sesiones para la etapa cognitiva y 10 sesiones para la etapa interaccional), es lograr un mejor control de la enfermedad en el caso de la diabetes, y avances en el sentido de una mayor discriminación a nivel de los subsistemas parental y filial y a nivel individual, así como una mayor permeabilidad en la rigidez de las relaciones complementarias presentes.

Hemos encarado también una adaptación de esta técnica de trabajo a familias del interior, que viajan con una periodicidad de alrededor de tres meses, y son atendidas cada vez en una suerte de sesiones prolongadas de dos a tres horas de duración.

En estos casos, el tiempo forzoso de elaboración en la intersección parece constituir un hecho a favor del cambio, ya señalado en otro contexto por la doctora Selvini Palazzoli.

## Resumen

En esta comunicación se describe un modelo de abordaje médico-psicológico de familias con un miembro que padece una enfermedad orgánica crónica (por ejemplo la diabetes).

El modelo propuesto se desarrolló a partir de la necesidad de actuar sobre los factores emocionales que la enfermedad produce en la familia como sistema y que interfieren en el aprovechamiento de la consulta médica y en el manejo adecuado de la enfermedad.

Dicho modelo abarca dos vertientes de trabajo:

a) el área de lo *cognitivo* vinculado a la enfermedad: en este campo se trata de que surjan y aclaren las distorsiones en la información que el grupo familiar maneja acerca de la afección. Estas distorsiones están ligadas a las *creencias*, vehiculizadas a través de los mitos populares y familiares acerca de la enfermedad.

b) el área de la *dinámica familiar* ante el impacto de la enfermedad crónica: en este campo se postula que el comportamiento sintomático "orgánico" debe ser descifrado en términos de lo que está pasando al nivel de las relaciones entre los miembros de la familia, concebida como

un sistema. El modelo apunta a la elaboración de técnicas específicas para cada familia, tendientes a lograr una mayor autonomía del paciente en cuanto al manejo de su enfermedad, graduada según la edad. Se hace referencia a la caracterización de S. Minuchin sobre este tipo de familias, que los autores amplían postulando la complementariedad rígida como estructura relacional de la pareja parental. Se afirma que dado que en estas familias la oscilación principal se centra en torno a la complementariedad, es necesario "remodelar" el vínculo complementario para llevarlo hacia un contexto colaborativo. Esta tarea incluye tres esferas de acción simultáneas:

- a) a nivel de la pareja parental: uso de una técnica de simetrización momentánea.
- b) a nivel de la pareja padre (o madre) - paciente identificado: promoción de la alternancia "one-down" - "one-up" entre ambos.
- c) a nivel del subsistema filial: prescripciones que engloben a sus miembros en un contexto diferenciador con respecto al subsistema parental.

### Summary

In this paper, a clinical-psychological approach to families with a member in a chronic condition, is described.

The main purpose is to act on the emotional factors that the disease produces in the family as a system and that interfere in the therapeutic success, at the medical level.

To operate in two areas is proposed:

a) *Cognitive*, trying to know and make clear any distorted information the family have on the disease, with especial emphasis on non-critical beliefs. To make conscious these primitive myths constitutes a valuable tool leading to their questioning and eventual correction, and consequently improving the family behavior related to the control of the disease.

b) *Family dynamics*. Chronic diseases facilitate the broadening of the pre-existing dependency links. Furthermore, if the organic disease constitutes a sort of limit not seen in psychiatric disorders, the load on the patient of other conflicts can be understood as the role played by the "identified patient" as mentally ill. The individual "marked" with an

organic disease is an adequate target to receive multiple deposits from unsolved family system conflicts, expressed through many dysfunctional interactions. The model of work above mentioned aims to specific techniques for each family to achieve a better autonomy of the patient and emphasizes the necessity for this type of families, as G. Bateson proposed, "to reach the bottom".

### Bibliografía

- BATESON, G.: *Pasos hacia una Ecología de la Mente*, Bs. As., C. Lohlé, 1972.
- BATESON, G.: *Espíritu y Naturaleza*, Bs. As. Amorrortu, 1982.
- BECK, A., RUSH, A., SHAW, B. y EMERY, G.: *Cognitive Theory of Depression*, N.Y., The Guilford Press, 1979.
- BERTALANFFY, L. VON: *Teoría General de los Sistemas*, Madrid, ed. Alianza, 1975.
- BERTALANFFY, L. VON: *Perspectivas en la Teoría General de los Sistemas*, Madrid, ed. Alianza, 1975.
- ELKAIM, M. et al: "Openness: Round-Table Discussion", *Fam. Process*, vol 21, No. 1, 1982.
- GIACOMODONATO, D. y WEISSMARK, M.: "Familias como Sistemas Adaptativos Complejos", *Ter. Familiar*, 1981, IV, 7/8.
- MADANES, C.: *Strategic Psychotherapy*, California, Jossey-Bass Inc., 1981.
- MINUCHIN, S. et al: *Psychosomatic Families*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1978.
- SLUZKI, C. y RANSOM, D. (eds.): *Double Bind: the Foundation of the Communicational Approach to the Family*, N. Y., Grune and Stratton, 1976.

---

## Indicación y contraindicación de terapia de pareja

---

Lic. STELLA MARIS MOLINA

---

*Laprida 1898, 16° P, Dto. M, Buenos Aires, Argentina*

---

La indicación de terapia familiar o de terapia de pareja depende de los criterios del entrevistador en cuanto a la necesidad o la pertinencia de abordar un sistema intersubjetivo. Generalmente se aplican ciertos criterios para evaluar las entrevistas diagnósticas en vista de la indicación terapéutica más adecuada, pero no se los especifica y menos aún se los sistematiza.

Es necesario fundamentar la elección entre alternativas terapéuticas diferentes para evitar la indicación indiscriminada de terapia familiar o de pareja. Si al abordar y estudiar el grupo familiar, se abrió un nuevo punto de vista de la psicopatología y un nuevo campo terapéutico, es menester aprovecharlo, fundamentarlo y desarrollarlo.

Intentaré hacerlo pensando acerca de la experiencia terapéutica en dos casos sucintamente presentados a los fines del tema que me propongo. Me basaré en conceptos psicoanalíticos, de la antropología estructural y de la teoría de los sistemas.

### Caso A, donde se indicó terapia de pareja

Consultaron al que había sido terapeuta individual de la

madre por un síntoma que se presentaba en uno de los hijos y fueron derivados a tratamiento familiar. El hijo mayor, un adolescente de 15 años, robaba dinero del placard. Unos años antes tuvo lugar un tratamiento familiar breve y continuaron enseguida con terapia de pareja con un resultado positivo parcial simbolizado, según ellos, en el cambio de cerradura de la casa. Con el tiempo aparecieron síntomas en el hijo mayor y eran la norma las peleas familiares. Luego de poco más de un año de terapia familiar de buena evolución en la relación y los lugares entre padres e hijos debido al análisis de los síntomas y datos fenoménicos referidos a la estructura subyacente y determinante de este grupo familiar\*, nos centramos en el tratamiento de la pareja. En la historia de la misma existió una fuerte determinación no sólo del ascendiente sino también de las condiciones que puso en la constitución del matrimonio la familia materna: el tío materno primero les prestó y luego de 9 años le regaló a la sobrina la casa donde aún viven. Pero la puso a nombre de ella "por si se separaban". Hasta hace poco tiempo no se atrevían a disponer libremente de ella ni siquiera para cambiar algún mueble.

A los 9 meses de matrimonio nace muerta una niña que llevó por nombre el de la madre y la abuela materna. Luego tienen dos hijos varones y 7 abortos, el último luego del nacimiento del hijo menor. La pareja vivió la muerte de la primera hija por separado, ella a solas y él con sus padres; la esposa llegó a creer así que el suyo era el único dolor y hace 18 años que se pelean aparentemente por tonterías, denigrándose y culpándose el uno al otro por la infelicidad del matrimonio, él más callado y olvidadizo, ella agresiva e insultante. El duelo patológico sostenido por la esposa no fue elaborado por la pareja porque no se dieron cuenta de que tenía que ver con la modalidad de consolidación de la alianza,

\* Más datos sobre este tratamiento de familia en "Acerca de la aplicación de los modelos teóricos", presentado al 1er. Congreso Metropolitano de Psicología "Sobre la teoría y la práctica", 1981.

y sobredetermina el sadomasoquismo entre ambos (culpa, acusaciones y denigración mutua).

Muchas cosas más podrían decirse acerca de este material clínico, pero creo haber logrado ya reunir y ordenar suficientes elementos que justifiquen la indicación de terapia de pareja.

### Caso B, donde se indicó psicoanálisis individual

El esposo estaba en tratamiento psicoanalítico desde hacía 3 años a raíz de accesos de angustia que luego se pudieron relacionar con la detección precoz de un cáncer de colon. Fue operado, se le aplicó quimioterapia y tiene una buena evolución. A raíz de una crisis matrimonial se les sugirió entrevistas de pareja en las que el enamoramiento de la esposa por un hombre más joven y las quejas acerca del carácter del marido, fueron interpretados como un reclamo de atención de la esposa por el encierro narcisístico desde su afección en adelante. Por ese entonces había fallecido el padre de la esposa. Meses después ella quiere separarse y para obtenerlo inicia una huelga de hambre de 4 ó 5 días. El paciente que siempre se había caracterizado por negar parcial y alternativamente su enfermedad, reacciona coercitivamente oponiéndose a separarse, nuevamente sin comprender o sin querer comprender qué ocurría. Como yo estaba al corriente del abandono del tratamiento que había iniciado hacía un tiempo la esposa y temía más actuaciones compulsivas, la cité. De entrada me dice: "Ud. ya se habrá dado cuenta que hay otra persona. Además mi marido se va a morir y yo voy a quedar sola". Más adelante, quejándose de su maltrato, agrega: "El es igual a mi padre de la cintura para abajo". A los 12 años su padre intentó violarla en dos ocasiones y un tío y un primo la hicieron objeto de seducciones sexuales. Su madre se había ido del hogar cuando era pequeña. Como entre otras cosas busca hacerme cómplice de un secreto con respecto a mi paciente, no hago referencia a su relación extramatrimonial más que como un deseo de venganza —pero, ¿de quién?— y le explico que la cité para recomendarle un terapeuta para ella porque el modo de sus

reclamos no era muy maduro y me pareció que estaba pidiendo auxilio por su situación personal.

Aunque existía una evidente problemática de pareja, pensé que sería más oportuno posponer un tratamiento conjunto para más adelante, dado el peso de las dos principales líneas conflictivas personales que se desplegaron en esa entrevista (miedo de quedar abandonada —“viuda y sola”— por la amenaza de pérdida del objeto y conflictiva edípica histórica —fantasías de seducción y culpa—) y además por el riesgo de actuaciones perversas del estilo de las mentiras, complicidades e intrigas que comprometieran la transferencia más en un nivel resistencial que elaborativo.

\*  
\* \*

Para pensar acerca de los criterios por los cuales indiqué en un caso y no en el otro la terapia de la pareja, comencé por plantearme algunos interrogantes:

***¿Es posible aplicar los mismos criterios para indicar terapia de pareja que para indicar terapia familiar?***

Revisando los criterios que propone Lyman C. Wynne en el Cap. 7 de “Terapia Familiar Intensiva” sobre indicación y contraindicación de terapia familiar<sup>9</sup>, se hace evidente la diferencia y la especificidad con respecto a la terapia de pareja. Aun cuando podría aceptarse de modo general que se indica terapia de pareja cuando la problemática “involucra inmediata y actualmente” a ambos miembros, agregaría que en el sentido de que sea predominantemente la constitución de la alianza y sus consecuencias actuales a nivel de la pareja lo que esté en juego en la mencionada problemática. Cuando la problemática excede el área de la relación de pareja y se presenta al mismo tiempo en otras (por ejemplo en el área laboral, social, comunicacional, etc.) entonces la indicación más pertinente será la del tratamiento individual; y cuando se hallen comprometidos los hijos a nivel de la sintomatología y no meramente como portavoces —como suele ocurrir con los niños pequeños cuyo aparato psíquico aún no se encuentra del todo consti-

tuido— entonces la indicación más pertinente será la de terapia familiar.

***¿El momento en que se indica la terapia de pareja puede tener que ver con su fecundidad?***

El concepto de proceso terapéutico<sup>5</sup>, permite preguntarse acerca de cuál es el momento más propicio para abordar la problemática de una pareja, para que no resulten ineficaces los recursos terapéuticos y para aprovechar mejor el potencial de cambio, desde una perspectiva intersubjetiva.

En el caso A, aunque las dificultades de la pareja se adelantaron desde las entrevistas evaluativas, no fueron abordables de manera específica hasta que por el tratamiento familiar se operaron transformaciones en los síntomas iniciales (robo, problemas de escolaridad, peleas generales) y en las sesiones surgieron claramente delineados los conflictos matrimoniales. El anterior tratamiento de pareja solamente tuvo efectos nominales a nivel de la matrilocalidad (cambio de cerradura de la casa). Tal vez tuvieron que denunciar los hijos luego la verdadera complejidad de la estructura familiar subyacente y las condiciones del establecimiento de la alianza matrimonial, al asumir el hijo mayor un lugar que lo acercaba al tío materno y a nosotros nos remite a la ley formulada por Levy-Strauss<sup>2</sup>.

En el caso B, quizás la problemática de la pareja pueda ser más eficazmente abordada cuando ambos hayan elaborado en alguna medida sus resistencias y conflictivas personales para poder entender mejor por qué se eligieron mutuamente, cómo construyeron y sostienen la relación matrimonial y cómo los estremeció a ambos de distinta manera la amenaza de muerte-pérdida-abandono.

***¿Cómo se entiende en terapia de pareja el problema de las relaciones entre los individuos y el sistema?***

Existen disfunciones sistémicas y existen conflictos personales. Un sistema como la familia o la pareja es funcional en tanto al mismo tiempo que mantiene su existencia como unidad, permite el desarrollo de sus miembros. Cualquier

sistema humano se torna disfuncional cuando por el mantenimiento del sistema se sacrifica el crecimiento o la identidad de sus miembros. Cuando el sistema se sostiene mediante la rigidez de normas y creencias está destinado a entrar en conflicto con las necesidades individuales<sup>3</sup>. En cuanto a la familia, sus disfunciones entran en contradicción con una importante condición de su existencia, que es la de permitir el surgimiento de la subjetividad y la transmisión cultural<sup>7</sup>.

A veces un individuo se encarga de poner de manifiesto la crisis por la que pasa el grupo, y otras veces un individuo puede utilizar al grupo como escenario para desplegar sus conflictos personales. Cuando alguien hace jugar todos sus conflictos alrededor de la pareja, somete a una extrema sobrecarga a una única relación intersubjetiva, la pone a su servicio y la destruye. En el caso B ambos desestiman y no desarrollan sus posibilidades de trabajo y de relaciones sociales, o bien pueden usarlas como escenario alternativo de sus querellas conyugales. Entonces lo extramarital está constituido por los amantes en lugar de un área personal de desarrollo.

\*

\* \*

Estas ideas propuestas en torno a algunos interrogantes no pretenden en absoluto agotar las inquietudes. Por el contrario nos llevan a más preguntas, a más problemas, a más dudas. Del mismo modo no pretendo encontrar ni proponer parámetros absolutos ni establecer criterios rígidos sino una afinación del pensamiento para poder elegir mejor entre alternativas terapéuticas en función de un mejor pronóstico, y en función del concepto de proceso terapéutico.

Así, para pensar este problema propongo tener en cuenta los siguientes aspectos:

— *El tipo de demanda y el lugar en que la pareja o los miembros individualmente ubican al terapeuta.* En el caso A una mujer entregada a medias a un hombre en matrimonio, y un hombre que no supo hacerla suya en varios sentidos, se lamentan de la infelicidad matrimonial. Más allá de las peleas y

recriminaciones conyugales, ambos padecen la misma situación<sup>8</sup> y desean y resisten al mismo tiempo un cambio, lo que se manifiesta en las reiteradas demandas terapéuticas. En el caso B las entrevistas fueron propuestas por la terapeuta del marido y luego la esposa fue citada. Estaría más en el deseo de los terapeutas una propuesta de terapia de pareja que en la posibilidad actual del matrimonio de llevarla a cabo. El conflicto actual se opaca ante la fuerza del conflicto edípico sin resolver. "El es igual a mi padre de la cintura para abajo" requiere una larga elaboración individual que le permita deslindar la relación matrimonial de la relación con el padre que la marcó con su deseo y la violentó sexualmente. En este caso más que un deseo de cambio en la relación matrimonial hay un deseo de confirmar al otro en el lugar del fantasma para retenerlo allí. Así el esposo la controla y asedia con la suspicacia y la esposa insiste en el maltrato físico y moral.

— *Los tipos de conflictos y de síntomas.* Es necesario discriminar cuáles pertenecen al sistema pareja y cuáles a sus integrantes. Si la pareja tiene hijos será interesante constatar en qué medida presentan sintomatología involucrada en el conflicto de los padres o si son portavoces de éste. En ambos casos denuncian, pero el compromiso psicopatológico y el abordaje terapéutico son diferentes.

— Por último será importante establecer si la determinación del síntoma o del conflicto es elaborable predominantemente a nivel de la relación intersubjetiva y de la estructura del sistema, o bien, la determinación del síntoma o del conflicto remite predominantemente a estructuras históricamente anteriores al vínculo y elaborables a nivel de la transferencia en el análisis individual. La elección de objeto se hallaría a mitad de camino entre la alianza matrimonial y el fantasma individual. El fantasma está estructurado sobre los deseos relacionados con el Complejo de Edipo, que determinan si la elección de objeto será del tipo narcisista o por oposición. Además existen factores reguladores de esta elección que la permiten y restringen al

mismo tiempo. Uno, es la prohibición del incesto (lo prohibido) que lleva a la búsqueda de un objeto exogámico. El otro, es el código de significaciones inconscientes que se aprehende en la familia de origen para el cumplimiento del deseo y las restricciones para sortear el tabú del incesto (lo prescripto)<sup>1</sup>. La elaboración terapéutica se orientaría hacia un lado o hacia el otro de la elección de objeto, eslabón entre los deseos edípicos y la consolidación de una alianza matrimonial, según la importancia de las sobredeterminaciones del conflicto actual.

## Resumen

Se intenta sistematizar los criterios acerca de la pertinencia de abordar terapéuticamente un sistema intersubjetivo, reflexionando sobre: Caso A: donde se indicó Terapia de Pareja; Caso B: donde se indicó Psicoanálisis individual.

Se plantean algunos interrogantes: ¿Es posible aplicar los mismos criterios para indicar TP que para indicar TF? Se propone TP cuando en la problemática está en juego la constitución de la alianza y sus consecuencias actuales; tratamiento individual cuando la problemática excede el área de la pareja y abarca lo social, laboral, etc.; TF cuando se hallan comprometidos los hijos a nivel de la sintomatología y no meramente como portavoces.

¿El momento en que se indica TP puede tener que ver con su fecundidad?

Se acude al concepto de proceso terapéutico.

¿Cómo se entiende en TP el problema de las relaciones entre el individuo y el sistema? Existen disfunciones sistémicas y conflictos personales. Un sistema es funcional cuando mantiene su existencia y permite el desarrollo de sus miembros. Un individuo puede denunciar la crisis de un grupo o bien utilizar al grupo como escenario para desplegar conflictos personales.

Se pretende elegir entre alternativas terapéuticas basándose en:

- El tipo de demanda y el lugar en que la pareja o los miembros ubican al terapeuta.

- Tipos de conflictos y síntomas. Discriminar cuáles pertenecen al sistema familiar, a la pareja y a sus integrantes.

— Determinar si el conflicto es elaborable predominantemente a nivel de la relación intersubjetiva y de la estructura del sistema, o bien, remite predominantemente a estructuras históricamente anteriores al vínculo y elaborables a nivel de la transferencia en psicoanálisis. La elaboración terapéutica se orientaría hacia un lado u otro de la elección de objeto, eslabón entre los deseos edípicos y la consolidación de la alianza matrimonial, según la importancia de las sobredeterminaciones del conflicto actual.

## Summary

We attempt to systematize criteria as to the pertinence of approaching an intersubjective system therapeutically by reflecting on: Case A: where Couple Therapy (CT) was prescribed; Case B: where Individual Psychoanalysis was prescribed.

Some questions are posed: Is it possible to apply the same criteria for prescribing CT as for prescribing Family Therapy (FT)? CT is proposed when the constitution of the marriage and its present consequences are involved in the problem; individual treatment when the problem goes beyond the area of the couple and includes the social, work, etc. areas. FT when the children are affected at symptomatic level and not just as spokesmen.

Can the moment in which CT is recommended have to do with its fruitfulness?

We recur to the concept of therapeutic process.

How do we understand the problem of the relations between the individual and the system in FT? Systemic dysfunctions and personal conflicts exist. A system is functional when it maintains its existence and permits the development of its members. An individual may denounce the crisis of a group or may utilize the group as a stage on which to display personal conflicts.

We intend to choose among therapeutic alternatives basing our choice on:

- The type of demand and the place in which the couple or the members situate the therapist.

- Types of conflicts and symptoms. Discriminate which belong to the family system, which to the couple and to its members.

— Determine whether the conflict may be worked-through predominantly on the level of the intersubjective relation and of the structure of the system or whether it refers predominantly to structures historically previous to the union, to be worked-through on the level of the transference in psychoanalysis. The therapeutic working-through would be oriented toward one side or the other of the object choice, a link between oedipal desires and the consolidation of the marital alliance, according to the importance of the over-determinations of the present conflict.

### Bibliografía

1. AHLIN, G. y BOTTICELLA DE LUXARDO, G. "La relación de alianza: una formación de compromiso". *Rev. Terapia Familiar*, No. 4, 1980.
2. BERENSTEIN, I. *Familia y Enfermedad Mental*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1976.
3. CAILLE, PHILIPPE. "La intervención terapéutica. Las premisas de un cambio real en la relación humana". *Rev. Terapia Familiar*, No. 7/8, 1981.
4. FREUD, S. *Obras Completas*. Ed. Alianza, Madrid, varios años.
5. GARCIA BADARACCO, J. "La familia como contexto real de todo proceso terapéutico". *Rev. Terapia Familiar*, No. 1, 1978.
6. LACAN, J. *Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis*, Barral Ed., Barcelona, 1977.
7. *-La Familia*, Ed. Homo Sapiens, Buenos Aires, 1977.
8. NOCETTI, J. C. "La organización de las relaciones familiares". *Rev. Terapia Familiar*, No. 1, Buenos Aires, 1978.
9. WYNNE, L. C. "Algunas indicaciones y contraindicaciones de la terapia familiar exploratoria". Cap. 7 de *Terapia Familiar Intensiva*, Ed. Trillas, México, 1976.

### Anorexia nerviosa

Dr. J. J. MORGAN\* y Dr. J. R. BOZZO\*\*

\* Av. Santa Fe 911, 2° Piso, 1059 Buenos Aires; \*\* Conde 1078, 1426 Buenos Aires

#### 1) Historia del conocimiento de esta enfermedad y su caracterización

Si bien parece haber descripciones muy antiguas de este padecimiento, hay acuerdo en considerar que la primera descripción detallada data de 1689, se debe a Richard Morton y se encuentra en su obra *Phthisiologia seu Et ercitationes de Phthisis*. Este autor describe la pérdida de apetito y la consunción sin fiebre ni disnea y establece sus características principales, entre las que menciona la amenorrea y la sobreactividad, llamando la atención sobre una característica "indiferencia" hacia su condición en estos casos que denominó "atrofia nerviosa"<sup>1</sup>.

En 1873, William Gull lee un escrito sobre "anorexia histérica", referido a una forma de enfermedad que prevalece en mujeres jóvenes, entre los 15 y 23 años, que describe como una inanición sin signos de enfermedad visceral. Hizo en años siguientes nuevas presentaciones, ya influidas por los trabajos de Lasègue y en una de ellas atribuye la enfermedad a un "estado mórbido mental", "una perversión del ego", que causa y determina su curso<sup>2</sup>.

Simultáneamente, Lasègue describe la misma enfermedad, causada por un peculiar estado mental, resultante de un disturbio emocional admitido o no por el paciente. Menciona tres fases: la primera caracterizada por dificultades digestivas, reducción de la ingesta y sobreactividad. La segunda está marcada por "emaciación", acompañada por una "perversión mental", reforzada por la preocupación familiar, con un enfermo obstinado que afirma no haber estado nunca mejor. La tercera fase se da con depresión, amenorrea, constipación, astenia y él la llama "caquética"<sup>1</sup>. Selvini Palazzoli critica a esta descripción el hecho de que la amenorrea se observa por lo general al comienzo de la enfermedad, lo que coincide con nuestra experiencia.

La claridad respecto de este cuadro clínico volvió a perderse luego de la descripción por Simmonds del cuadro de caquexia por atrofia del lóbulo anterior de la hipófisis en 1914. Se tendió entonces a vincular estos cuadros hasta que el avance de los métodos de diagnóstico hormonal llevó a reinstalar la delimitación de la anorexia nerviosa o mental, como ilustran los escritos de H. Meng<sup>3</sup>.

Debido a que no pretendemos una revisión completa del tema, admitimos desde ya omisiones en este panorama histórico sobre la formación del concepto de anorexia nerviosa. Con esta salvedad, queremos citar los trabajos contemporáneos de H. Crisp, Hilde Brush y M. Selvini Palazzoli.

H. Crisp<sup>4</sup> llama la atención sobre un defecto en la construcción de la autonomía e identidad, la evitación del desarrollo de la fase psicosocial de la evolución adolescente, la adaptación "complaciente" en la infancia, la mala preparación para la individualización y la escasa preparación para el conflicto.

Hilde Brush<sup>5</sup> ha llamado intensamente la atención sobre el hecho de que la anorexia nerviosa aparece en los últimos tiempos con mayor frecuencia y diferencia los casos de tiempo atrás que se producían sin un franco estímulo social y los actuales, en que los pacientes tienen amplias referencias de la enfermedad. Cita un caso propio que le contesta: "Ah, en mi clase hay dos". Atribuye algunos casos entonces a la adopción

de un rol social conocido. Otorga mucha importancia a las características premórbidas que enumera así:

- a) severos trastornos de la imagen corporal
- b) malas interpretaciones de los estímulos internos y externos, con inadecuación en el modo de experimentar hambre.
- c) un paralizante sentido de ineficacia y convicción de imposibilidad de cambiar nada de sus vidas.

También enfatiza sobre carácter desafiante y terco.

M. Selvini Palazzoli<sup>1</sup> desarrolla una amplia tarea en este tema desde 1950. Inicialmente aplicó un enfoque y concepción psicoanalíticas con el uso de la teoría de las relaciones objetales. Desde 1967 hizo el esfuerzo de aplicar con rigor metodológico el tratamiento familiar en base a la teoría general de los sistemas y refiere una mayor eficacia terapéutica.

Cabe citar el aporte en el terreno de la técnica de los trabajos de Salvador Minuchin<sup>6</sup> que ha descripto estrategias para encarar el negativismo y su apoyo en la estructura familiar.

### Caracterización clínica

Se termina así por caracterizar este trastorno por su sintomatología y psicopatología.

La enfermedad prevalece en la adolescencia, aunque hay casos en niños, adultos y ancianos. A su vez, hay mayoría de mujeres afectadas.

La sintomatología consiste en disminución de la ingesta de alimentos, o bien el vómito subsiguiente, e inclusive hiperfagia con vómito sucesivo, con pérdida progresiva de peso en grados del 30% o más del peso teórico. Su evolución puede implicar el desarrollo tardío de anemia, hipoproteinemia, úlceras tróficas, hipokalemia y el porcentaje de muertes espontáneas es elevado, si bien actualmente modificado por la terapéutica clínica más eficaz. Característicamente en las mujeres postpúberes hay ame-

norrea, desde el comienzo del trastorno y a veces hemos encontrado este síntoma en hermanas no anorécticas de la enferma.

Psiquiátricamente, se observan estados depresivos o estados paranoides, en ocasiones muy intensos o fluctuaciones de ambos. Se suele constatar sobreactividad, pero la constante más notable consiste en la indiferencia sobre su estado físico, la paradójica afirmación de estar excedido de peso, la negación de que la desnutrición pueda representar peligro alguno y una marcada tosudez y sistemático "no" a cualquier propuesta terapéutica.

Con frecuencia aparece en la evolución la conducta de cocinar para la familia y, en ocasiones, ocuparse de lograr que una hermana se alimente generosamente.

Es constante también el antecedente de buen desempeño escolar y de fracaso psicosocial antes del desarrollo del cuadro (romance frustrado, "papelón" en grupo, etc.).

Nosográfica y psicodinámicamente presenta una ubicación muy especial. Todos los casos por nosotros estudiados presentan características de organización borderline de la personalidad con intensa disociación de objeto bueno idealizado, objeto malo. En muchos momentos de algunas evoluciones se da una notoria proximidad hacia la esquizofrenia y tenemos un caso que comenzó como esquizofrenia y pasó a la curación luego de un prolongado período de anorexia nerviosa típica, en el curso de una terapia individual y familiar.

Sin presentar lesión orgánica (salvo las derivadas de desnutrición e hipokalemia), hay similitudes con las enfermedades psicosomáticas. También limita, en ocasiones con las depresiones con componente biológico y en varios casos encontramos dosajes bajos de feniletilamina en orina de 24 horas y mejorías con el uso de antidepresivos.

## 2) Explicaciones psicológicas y tratamientos intentados

La anorexia nerviosa es una condición no siempre adecuadamente reconocida por los clínicos y psicoterapeutas.

Para los episodios agudos severos con peligro de desnutrición extrema hay concordancia sobre la inevitabilidad (y aún

ventaja) de la internación y atención combinada clínica y psiquiátrica<sup>7</sup>. Generalmente, como se ve en otras patologías mentales graves, hay una mejoría con esta separación de la familia, que suele perderse con la externación.

La revisión que hace M. Selvini Palazzoli de sus casos que atendió con psicoterapia individual muestra que el resultado se hace desalentador. Resalta la autora que el éxito depende más de la relación personal del terapeuta y el manejo de la familia, que del efecto predecible de las técnicas.

Cada terapeuta encara a su paciente según una cierta óptica que puede resultar enfoques tales como el miedo al crecimiento, la evitación del sexo, la dependencia de la familia, la identidad, el miedo al grupo, etc. En general, se trata de pacientes sumamente negativistas y ambivalentes, con los que no es fácil iniciar y mantener un vínculo terapéutico. Cuando esto ocurre, el terapeuta se ve involucrado en intensas reacciones contratransferenciales simbióticas como las descritas por Searle. Suelen verse dos formas de evolución desfavorable:

1) "excelente" relación con el terapeuta (en un nivel idealizado) con progresiva pérdida de peso, hasta una intervención familiar que interrumpe el tratamiento, sobre todo cuando la identificación del terapeuta con el paciente no le permite favorecer la contribución de otras instancias.

2) "mejoría" del paciente hasta que se ve involucrado en la ilusión de alternativas de quedarse con el terapeuta o la familia, a lo que sigue un rebrote sintomatológico o bien en ese momento se da una abrupta intervención familiar para resolver la angustia que provoca sobre todo en la madre el aumento de peso o la independencia del enfermo.

Un elemento importantísimo está dado por el alto monto de *agresión* de estos enfermos, de manera que el tratamiento tiene en ocasiones el efecto de producir una brusca liberación que se traduce en "acting out", tales como intentos de suicidio, actos antisociales, explosiones agresivas, etc.

Por lo demás, el reclamo intemperante de tener una instancia exclusiva y de muy ajustada comprensión personal hace en

muchos casos imprescindible la inclusión de terapia individual.

La tendencia que se ha ido gestando respecto de estos difíciles casos es que el tratamiento debe incluir una importante acción sobre la familia.

Ningún caso genuino de anorexia nerviosa debiera ser tomado "a priori" como de fácil resolución y es preferible tener disposición a utilizar recursos múltiples a lo largo de su evolución.

### Ensayo de explicación psicodinámica

Particularmente en función de su abordaje terapéutico entendemos que los pacientes de anorexia nerviosa tienen acentuados caracteres de tipo borderline, con alto monto de ansiedades psicóticas paranoides y de abandono. Predomina en ellos la sumisión a elevadas expectativas de desempeño genial, alentadas durante todo su desarrollo y en el momento de mostrarse el cuadro de anorexia nerviosa se dan los siguientes elementos:

- 1) Una actitud de autoafirmación negativista u opositorista, similar a la del niño de 3 años, a la salida de la simbiosis normal descrita por M. Mahler<sup>8</sup> aunque con todas las características de discordancia con que K. Lewin<sup>9</sup> caracteriza los estados regresivos.
- 2) Una gran omnipotencia que conlleva una obstinada negación del cuerpo y de las necesidades corporales.
- 3) Sin embargo, sólo la simbiosis da seguridad a estos enfermos y esto se manifiesta en reclamos de "milimétrica" comprensión y gran intolerancia a la menor discordancia.
- 4) Se da una "lucha" original por su independencia respecto de la madre a la cual hubo un previo sometimiento completo. En esta actividad la comida toma un carácter simbólico, al modo de un objeto transicional de Winnicott. Así vemos que es objeto de apetencia y rechazo, se come con avidez y se vomita; o bien se atesora, en una serie de maniobras que se relacionan al estado de la relación con la simbiosis materna. Desgraciadamente, todos estos simbolismos se dan dentro de las típicas características del "acting out", en el que no cabe la conciencia sobre su significado y su valor simbólico es siempre denegado.

5) Esta lucha paradójica con ausencia de sentido de realidad, en un grado elevado de omnipotencia, actúa como un feed-back negativo que induce un incremento de la dependencia, la unión con la madre y el acrecentamiento de la rabia.

De esta manera, el paciente pasaría del cuerpo como dependencia de la madre a su bizarra negación, en lugar del proceso deseable de independización y autonomía yoica.

El proceso natural de autonomización se hace en el adolescente a través del grupo, del cual se obtiene control de ansiedades, aprendizaje de roles y vivencias de autonomía corporal.

Nuestros pacientes de anorexia nerviosa, luego de sus primeras incursiones no toleran otro rol grupal más que el de estudiante exitoso, de forma tal que hacia el fin de sus estudios secundarios rehuyen al grupo de pares como un ámbito de fracaso, al que desprecian con racionalizaciones despectivas. Quedan así atrapados en la exclusiva dinámica del grupo familiar propio, cuyas características alientan el rol de enfermo y, como plantea Gisella Pankow, para el caso de la esquizofrenia y la enfermedad psicósomática, son con sus "huecos" responsables de las malas identificaciones corporales. Se ven entonces aislados de los grupos que pudieran reactivar el aprendizaje psicosocial y de autonomía corporal que la familia no ha podido iniciar.

### La dinámica del grupo familiar

Observamos características análogas en todos los grupos familiares estudiados. Todos los autores<sup>1-4</sup> y nuestra experiencia, ubican la procedencia de estas familias en estratos sociales medio-altos, por lo menos "no humildes", con elevados ideales y aspiraciones de éxito.

Formalmente, el padre suele tener éxito laboral. La madre es una señora correcta, que suele tener un elevado interés intelectual o religioso, en aparente "conflicto" con su rol materno, si bien afirma tener todo compatibilizado. El futuro enfermo o enferma tiene una adaptación complaciente en la infancia, en particular al colegio y su enfermedad resulta una sorpresa. Se suele dar en otros hermanos roles disímiles, por

ejemplo rebeldía o dificultad escolar, aunque a veces se da diversidad social, pero reacciones muy similares al sexo o la agresión.

Esta descripción formal remarca el carácter de "adaptación social" exitosa en estas familias que no denuncia "hacia afuera" su intensa aberrancia psicosocial.

**Roles "eficaces" en la dinámica familiar.** Madre tiene una posición "central"; define valores y aspiraciones del grupo, juzga y orienta la conducta de todos, en especial del futuro enfermo. Muy atributiva e intrusiva, en particular si está ansiosa. Suele tener un fuerte rechazo por las actividades domésticas, en particular el cocinar y un fuerte sometimiento a la propia madre, a veces por la vía de ser sustituida en tareas hogareñas importantes. Por ejemplo, una familia había construido su propia casa sin cocina y la abuela materna por casi tres décadas llevaba una vianda con comida o iban todos a comer a su casa. Estas madres están muy satisfechas si no hay conflicto aparente y se "saturan" si aparece el conflicto, poniéndose por la ansiedad, más atributivas e hiperactivas.

**Padre:** suele tener escasa influencia en ordenar la familia; muchas veces idealiza las aptitudes de su activa esposa para orientar y educar a los hijos; se suele intimidar ante ella. Respecto de los hijos es relativamente seductor y poco firme.

**Anoréctico:** ha vivido sometido a la madre, buscando su agrado por la búsqueda de objetivos de elevado valor intelectual o espiritual, lo que le da un alto rendimiento en la escolaridad "reglada" de la escuela primaria y secundaria, pero escasa aptitud para su desempeño psicosocial.

**Estructura de la comunicación.** Se centraliza en la madre y se nota un llamativo "desuso" de otros canales, en particular por el enfermo. En uno de nuestros casos, las hijas hablaban libremente con la madre, con la cual se tuteaban y sólo esporádicamente entre sí, tratándose de Ud. y obligadas a comunicar sus conversaciones a la madre.

**Pragmática de la comunicación:** Se destaca la "impermeabilidad" (imperviousness) y la atribución, en un ambiente de

mucha imbricación y escaso o nulo reconocimiento de autonomía personal. El tono general es de rehusar el disenso, coincidiendo con las estructuras pseudomutuales y pseudohostiles que describiera L. Wynne<sup>4-10</sup>. La afirmación más corriente es que la familia es normal y "como todas".

**Estructura de liderazgo:** La pareja está envuelta en un conflicto del tipo del sesgo o cisma<sup>11</sup>, que se suele manifestar en discusiones a la hora de comer, cuya importancia es luego negada; pero que hacen sentir gran responsabilidad al futuro enfermo. Con frecuencia se detecta que el cuadro comienza con el abandono de la mesa del enfermo por no tolerar ya su angustia ante las discusiones parentales. Latente o explícita, la amenaza de divorcio suele estar presente. Desencadenada la patología, es común que en el manejo práctico de la anoréctica se descalifiquen mutuamente, a veces con sutileza.

**Paradigma del desencadenamiento y mantenimiento de la enfermedad.** Suele darse un fracaso psicosocial, de corte narcisístico frente a un grupo o una potencial pareja. Su "mal desempeño" en el terreno amoroso o social se agrava por el standard exigido de "gran éxito", alentado en la familia y confirmado en la escuela. Suele darse una ilusión de alternativas del tipo: "si complazco al grupo, pierdo a mamá, si me empeño en agradar a mamá me rechaza el grupo". El fracaso psicosocial deriva no sólo de la discordancia de los requisitos familiares con los del grupo de pares, sino en la ausencia de una gradual evolución del rol familiar del paciente, que impide el progreso personal de tipo "proceso estocástico" o función escalonada.

Es así que, tal como el adolescente normal, el anoréctico debe enfrentar una separación de la familia. La diferencia estriba en que el primero ya no debe desistir de una simbiosis, cuenta con mayor capacidad de simbolización, tolerancia al conflicto, autonomía yoica y un suficiente repertorio de roles sociales. En cambio, la anoréctica debe optar entre recomponer la simbiosis o padecer intensa ansiedad psicótica. El adolescente normal se separa de la familia, mientras que la anoréctica lo hace de la madre (por eso la estrategia consiste en lograr que previamente logre tener un grupo familiar).

Para la separación se le hace imprescindible lograr el control omnipotente del objeto, que se torna persecutorio por las ansiedades que surgen de los riesgos de quedarse sin ella o de ser recapturada y castigada. La pérdida no se vive como ausencia, sino como persecución, y requiere entonces el control del objeto por la negación, disociación e identificación proyectiva.

A falta de un eficaz sistema de simbolización, en estas condiciones, la comida toma el carácter de un objeto transicional, que es controlado de modo igualmente omnipotente y que, inicialmente tiende a permitir la separación de la madre, al controlar el abandono y evitar la persecución.

Una serie de "feed-backs" negativos conservan la anorexia nerviosa:

1) en el individuo, el valor "simbólico" dado al cuerpo y a la comida le permiten el control de ansiedades.

2) la madre reacciona con ansiedad, enfatizando la necesidad de elevados requisitos de carácter narcisístico: ser auténtico, feliz, o sea volver a someterse al pleno acuerdo con ella.

3) el padre disfruta "secretamente" de la aparente rebelión contra la madre, que, por primera vez, resulta ineficaz. Así es que el padre apoya el "no" = no forzarla, ser democráticos. No ofrece otro poder como alternativa a la madre y no las puede separar de su simbiosis conflictiva.

4) con frecuencia una agudización del conflicto de la pareja, con amenazas de divorcio, estimula la conducta de la anoréctica. Si uno de ellos actúa, el otro lo descalifica, si no actúa lo reemplaza.

5) Hermanos y hermanas terminan separándose del enfermo, ya sea por angustia o porque sus intervenciones se ven desalentadas por el negativismo de la enferma o el juicio de la madre.

6) La necesidad de la familia de "impresionar bien" los aparta de elementos que podrían ser favorables, tales como la familia extensa o amigos.

7) Tampoco hay un grupo de pares o una pareja que estimulen intereses menos regresivos.

### Objetivos terapéuticos respecto del individuo y el grupo familiar

Las dificultades antes señaladas en la terapia individual como tratamiento exclusivo y la imposibilidad del paciente para el grupo de pares, nos han llevado a proponernos el camino terapéutico de estos pacientes, principalmente a través del grupo familiar.

El objetivo para el individuo debe ser el acrecentamiento de la autonomía y la sustitución de la omnipotencia por un progresivo sentido de realidad. Tanto el cuerpo como la comida deben pasar a ser reales. Por lo demás, como en el caso de la terapia de esquizofrénicos, las intensas reacciones de contra-identificación en la terapia individual o familiar o la urgencia del caso, hacen imprescindible conducirse con una estrategia terapéutica. Es conveniente concebir ya de entrada que muy probablemente la terapia de uno de estos difíciles casos implicará pasos sucesivos y el empleo de un equipo terapéutico.

Nuestro planteo abarca:

1) Una exploración inicial ingenua en busca de reconocer la dinámica de los roles, liderazgo y comunicación del grupo. A tal fin, empleamos no sólo sesiones formales conjuntas sino también el eventual contacto con el paciente y sus familiares en la sala de internación si éste es el caso, etc. Tiene importancia en este rastreo encontrar los elementos a los que los miembros del grupo son sensibles y que pueden ser el camino de abordaje.

2) Buscamos no antagonizar al líder del grupo, que dado su estado de "saturación"<sup>12</sup> y sensación de fracaso, tiene que aceptar ayuda.

3) Procuramos "controlar" el conflicto de la pareja y forzar a los padres a actuar concomitantemente en relación al enfermo. Posteriormente, pueden recibir alguna ayuda específica para sus problemas de pareja, pero antes que nada los llevamos a que se unan en su acción sobre la enferma y no perturben sus intervenciones positivas. A través del cuidado de su hijo suelen

encontrar posibilidades de unión que los van separando juntos del anoréctico.

4) Un cuidado básico de todo el procedimiento consiste en resguardar la autoestima de los miembros, tal como lo enfatizara V. Satir. Sobre el paciente es necesario actuar valorizándolo. Muchas veces valoriza al paciente darle la oportunidad de intercambiar agresión. A veces es preferible el desafío al trato benévolo y, en todo caso, ya sea al comienzo o más adelante, proveerle un terapeuta individual más comprensivo. A veces tratamos de sobreactuar en momentos críticos, las imágenes de objeto bueno y objeto malo por parte de distintos terapeutas.

5) Si tenemos éxito en lograr un no demasiado ostensible control del grupo, el paso principal consiste en provocar el uso de todos los canales de relación en el grupo familiar, esto es, facilitar la relación con el padre, los hermanos y estimular la vinculación con la familia extensa. Este es un paso principal en la disolución de la simbiosis con la madre y el aprendizaje escalonado de roles sociales.

Estos pasos se dan a través de sesiones formales o bien en otras ocasiones. Pero, fundamentalmente, tienden a configurar en función de ellos la conducta terapéutica en las instancias de la terapia familiar, individual y la administración clínico-psiquiátrica.

En resumen, nos proponemos lograr dentro del grupo familiar, el incremento de las relaciones interpersonales y las identificaciones múltiples, que modifican de este modo la exclusiva identificación con la madre, reduciendo paulatinamente la rebelión inútil que confirma el sistema previo. Antes que una separación de la familia, buscamos un nuevo nivel de unión con más discriminación, autonomía y realidad. Se observa que este proceso se acompaña de un pasaje de la comida como símbolo (u objeto transicional) a la comida real. En una de nuestras pacientes se pudo observar que con la terapeuta comía y trataba a la comida como real, pero con la madre conservaba la anorexia. El abandono sostenido del uso de la comida como objeto transicional parece conllevar un incremento crucial de la

capacidad de simbolización y consiguiente separación de la madre. En el curso espontáneo de la enfermedad pareciera que la conducta de cocinar para la familia forma parte de un curso que podría llevar hacia la comida como realidad y la simbolización de la relación con la madre y sus aspectos ambivalentes.

Como concepto general, consideramos que a cada patología individual e interaccional debe corresponder una determinada estrategia terapéutica. Así como a las condiciones del neurótico resulta apropiado el psicoanálisis, postulamos que a la patología borderline del adolescente, en particular en este caso de la anorexia nerviosa, le corresponde la implementación de modificaciones en el grupo familiar y que las mismas deben ser inducidas en el proceso terapéutico.

No creemos que se requiera una permanente psicoterapia familiar conjunta, sino que conviene esta intervención en momentos elegidos del tratamiento, dentro de una estrategia que responda al concepto que se tiene de la psicopatología.

## Resumen

El objeto de este workshop es presentar un ensayo de utilizar una explicación psicodinámica sobre la dependencia y el cuerpo en la anorexia nerviosa, para aplicarla en el abordaje terapéutico. Se sostendrá el valor de la terapia familiar y se propondrá un enfoque de la técnica.

Los temas a tratar son:

- 1) Historia del conocimiento de esta enfermedad y su caracterización.
- 2) Explicaciones psicológicas y tratamientos intentados.
- 3) Ensayo de explicación psicodinámica.
- 4) La dinámica del grupo familiar.
- 5) Objetivos terapéuticos respecto del individuo y del grupo familiar.

La presentación se ilustrará con relatos de nuestra casuística y la supervisión de un caso con el método de la escultura familiar. Se incluirá el desarrollo, la experiencia y las dudas de los asistentes.

### Summary

The object of this Workshop is to present an attempt to make use of a psychodynamic explanation of dependency and the body in anorexia nervosa in order to apply it in the therapeutic approach. The value of family therapy is sustained and a technical approach is proposed.

The topics are:

1) History of the knowledge of this illness and its characteristics. 2) Psychological explanations and treatments attempted. 3) Attempt at psychodynamic explanation. 4) Dynamics of the family group. 5) Therapeutic objectives for the individual and for the family group.

The presentation is illustrated by accounts of our own practice and the supervision of a case using the method of the family sculpture. The participants' development, experiences and questions will be included.

### Bibliografía

1. SELVINI PALAZZOLI, MARA: *Self Starvation, From Individual to Family Therapy in the Treatment of Anorexia Nervosa*, John Aronson, 1978.
2. THOMAE, HELMUT: "Some psychoanalytic observations on anorexia nervosa", *Brit. J. Med. Psychol.* (1963), 36, 239.
3. MENG, HEINRICH: *Endocrinología Psicosomática*, Ediciones Morata, 1962.
4. KALUCY, R. S.; CRISP, A. H. y BRITTER, HARDING: "A study of 56 families with anorexia nervosa", *Brit. J. Med. Psychol.* (1977), 50, 381-395.
5. BRUCH, HILDE: *The Golden Cage, The Enigma of Anorexia Nervosa*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1978.
6. MINUCHIN, SALVADOR: *Familias y Terapia Familiar*, Granica Editor, Barcelona, 1977.
7. LUCAS, ALEXANDER R.; DUNCAN, JANE W.; y PIENS, VIOLET: "The Treatment of Anorexia Nervosa", *Am. J. Psychiatry* 133:9, Septiembre, 1976.
8. MAHLER, M.: "Sobre los conceptos de simbiosis y separación-indivi-

- ducción", en *Simbiosis Humana: las vicisitudes de la individuación*, Ed. Joaquín Vertiz, México, 1972.
9. LEWIN, K.: *La teoría del campo y la ciencia social*, Paidós.
  10. WYNNE, L. C.; RYCKOFF, IRVING M.; DAY, JULIANE y HIRSCH, STANLEY I.: *Pseudomutualidad en las relaciones familiares de los esquizofrénicos en Interacción Familiar*, Ed. Tiempo Contemporáneo, Bs. As., 1971.
  11. LIDZ, THEODORE; CORNELISON, ALICE R.; FLECK, STEPHEN, y TERRY CARLSON, Dorothy: "El medio intrafamiliar del paciente esquizofrénico: cisma marital y sesgo marital", en *Interacción Familiar*, Bs. As., 1971.
  12. SHAW, M.: "Communicational Networks", en *Group processes*, Penguin modern psychology Readings, 1971.

---

Las nociones de estructura y sistema y el proyecto de una ciencia unificada del hombre

---

Lic. ALEJANDRO GUSTAVO PISCITELLI

---

*Julián Alvarez 2382, 2º, G, 1425 Buenos Aires*

---

### Del cambio terapéutico al cambio epistemológico

Un punto de acuerdo entre las ciencias humanas, sus reflexiones filosóficas y la psicoterapia, se halla en su preocupación compartida por la problemática del cambio. El interrogante: *¿qué es lo que debe cambiarse —si es que después de todo, algo debe cambiarse?* varía en función de las imágenes disímiles que las distintas filosofías y formas de practicar la ciencia se hacen de su objeto de estudio: el hombre.

Un paciente es alguien que sufre. Su sufrimiento se origina en el desfasaje existente entre dos imágenes del mundo: la que tiene del mundo *real* y una segunda imagen *interna* que no se ajusta a la primera. Existen dos modos de salvar este hiato: i) ya sea modificar la imagen proveniente de la realidad externa —lo que implica cambiar esa realidad, ii) ya sea *adaptar* la imagen interna a la externa.

Entendemos por imagen del mundo a la síntesis más completa y abarcativa del conjunto de experiencias, convicciones, influencias, interpretaciones, evaluaciones, jerarquizaciones, etc., que un individuo genera/refleja. Se trata de una construcción

sumamente elaborada —moldeada en una matriz social irreducible a interacciones psicológicas puras (Bhaskar, 1979)— siendo los procesos de comunicación su vehículo social.

Las transformaciones de ideas e informaciones, no afectan al mundo mismo —a pesar de las protestas de los empiristas— sino a nuestras *representaciones* del mundo. Nietzsche intuyó el carácter *viviente* de nuestras imágenes afirmando que quienes tienen un “porqué” para vivir soportarán cualquier “cómo”; mientras que quienes lo hayan perdido no sobrevivirán —ni querrán hacerlo— aún en el habitat más confortable que se quiera imaginar.

A despecho de estos resultados, tanto teóricos como practicantes continúan cometiendo el pecado de leso empirismo consistente en el destierro de la subjetividad. En algunas oportunidades, sin embargo, los psicólogos, sociólogos o antropólogos han podido superar —en estado *práctico*— los obstáculos que dificultan el “progreso” de la epistemología. Tenemos como prueba la teoría del cambio desarrollada por la psicoterapia comunicacional. Un análisis de sus planteos arroja cierta luz acerca del tipo de cambio que es necesario en la epistemología.

### Teorías y tipos de cambio

*Cambiar algo para que nada cambie*: apotegma político, genialidad del *Príncipe*; máxima cuyo cumplimiento asegura el mantenimiento del poder al hacer circular los mensajes, los bienes y las mujeres del modo más viscoso y auto-preservador que se pueda. La frase enseña en qué medida cambios parciales y fragmentarios son *compatibles* con una estabilidad a más largo plazo. Los cambios a los que la máxima se refiere son de un tipo menor; desplazamientos mínimos de relaciones que mantienen inamovibles a los elementos (individuos). Cambios dentro de un grupo que no afectan ni su composición ni su naturaleza.

Matemáticamente, un grupo es un conjunto que posee las propiedades siguientes: i) está compuesto por elementos con una propiedad común. La composición de los mismos siguiendo

secuencias distintas siempre da el mismo compuesto, ii) contiene un elemento “neutro” tal que su composición con todo otro elemento da por resultado este último; iii) en todo sistema que satisface la noción de grupo existe para cada elemento otro “inverso” tal que la composición de un elemento y su inverso da el elemento neutro.

Existe una sorprendente analogía entre los cambios menores condensados en la máxima gattopardista citada anteriormente y las propiedades correspondientes a la Teoría de los Grupos, someramente esbozada en el párrafo anterior. ¿Qué sucede, empero, cuando un cambio altera la estructura misma del grupo (institución, organización, familia, Estado) analizado? ¿A qué teoría recurrir para conceptualizar este otro tipo de cambio para el cual la teoría de los grupos resulta, por definición, insuficiente? Los teóricos de la comunicación humana pidieron auxilio —para esta importante tarea— al análisis de los tipos lógicos (Watzlawick, 1976; Bateson, 1976).

En este caso los miembros (elementos) forman parte de una clase (grupo). Uno de los axiomas centrales de esta teoría es que “la clase de todas las clases no puede ser una clase de sí misma” [la humanidad = la clase de todos los individuos no es, ella misma, un individuo]. Sin embargo este axioma es constantemente *transgredido* en los distintos niveles de la enunciación: sintáctico, semántico y pragmático. Se producen, de este modo, las paradojas del mismo nombre (Hughes & Brecht, 1979; Hofstadter, 1980).

Los trabajos de Palo Alto han puesto de manifiesto, precisamente, en qué medida la conducta patológica puede entenderse como violación de los axiomas de la teoría que modeliza el comportamiento real (Watzlawick, 1976).

El ciberneta Ashby formuló en términos inequívocos la diferencia fundamental que existe entre estos dos tipos de cambio:

... la palabra cambio aplicado a una máquina [un autómata de estados finitos] puede significar dos cosas distintas: en primer lugar el pasaje de un estado a otro (...) que representa el comportamiento de la máquina; en segundo lugar el paso de una transformación a otra, o

sea, un cambio del comportamiento provocado por el experimentador o por un factor externo (Ashby, 1972).

Llamamos cambio-1 a las modificaciones del primer tipo, reservando la noción de cambio-2 para las segundas. El cambio-2 es un cambio de segundo orden —cambio del cambio.

### *Cambio-1 y Cambio-2 en ciencia y epistemología*

El crecimiento del conocimiento científico se realiza siguiendo un proceso *recursivo* de aplicación de reglas al universo material y comunicacional. En el caso específico de las ciencias de la materia; teorías integradoras sirven de barreras para dictaminar *cuáles* interrogantes son válidos y qué *anomalías* (aún molestas) son compatibles con el sistema de conceptos elaborado y aceptado previamente. Llamamos *ciencia normal* al conjunto de transformaciones experimentales y teóricas que tienen lugar dentro de estos parámetros (Kuhn, 1974).

La historia de la ciencia muestra, a su vez, que en ciertas coyunturas las anomalías *proliferan*; se combinan entre sí produciendo un efecto de bola de nieve. Su existencia, confinada habitualmente a los márgenes de la interrogación de la comunidad científica, alcanza súbitamente los lugares de privilegio discursivo. En este proceso, las anomalías cambian de status y se convierten en *enigmas*. Pero estos últimos, a diferencia de las primeras, urgen su solución so pena de poner en peligro la existencia misma de las disciplinas en cuyo seno afloran. Llamamos *ciencia revolucionaria* a este período de convulsiones y cuestionamientos.

Es posible, en forma análoga, concebir la existencia de una *práctica epistemológica* diferencial. Tendríamos por un lado, una conceptualización orientada fundamentalmente al estudio de las micro-transformaciones; el análisis de las modificaciones invariantes; la permanencia de los conceptos y técnicas de análisis. Llamaremos epistemología *continuista* a esta práctica cuyo objeto privilegiado de análisis son los cambios-1 o modificaciones intra-científicas.

Como contrapartida, existen los partidarios de una episte-

mología *discontinuista* centrada en los fenómenos de ruptura, apertura, macro-transformaciones especialmente apta para analizar los cambios de tipo-2: las rupturas epistemológicas y las revoluciones categoriales.

Un análisis detallado de ambos tipos de cambio en áreas tan distintas como la psicoterapia, la práctica religiosa, las conversiones políticas y las revoluciones científicas y epistemológicas han mostrado que:

1) el cambio-2 *modifica* lo que desde la perspectiva del cambio-1 es una solución ya que visto desde el cambio-2, la solución *es* el problema que se intenta resolver; 2) mientras que el cambio-1 descansa siempre en el "sentido común", el cambio-2 resulta inesperado, imprevisible, paradójico; 3) la aplicación de las técnicas de cambio-2 a la solución implica focalizar la atención en el problema tal como éste se presenta *ahora*. Estas técnicas se ocupan de los *efectos* y no de las causas. La pregunta central no es *¿qué?* sino *¿por qué?*; 4) la utilización de técnicas de cambio-2 arranca la situación del peligro generador de paradojas creado por la reflexibilidad del intento de solución.

¿Existe alguna escuela o estilo de pensamiento que permite promover el cambio-2, en particular en la psicoterapia? La importancia del paradigma estructural/sistémico (en cuanto mutación epistemológica) radica precisamente en su intento de responder a este interrogante.

## **2. Las promesas del paradigma estructural/sistémico**

El cambio epistemológico propuesto no consiste en reemplazar lo disciplinario por lo interdisciplinario. Esta alquimia verbal opera, fundamentalmente, a nivel ideológico, produciendo escasos o ningún efecto científico (Palmade, 1979). Lo que esta síntesis intenta lograr, es un estudio *transdisciplinario* de los sistemas adaptativos —simbólicos, imaginarios, reales—. Este tipo de sistemas está acotado por estructuras y delimitado y regulado en sus relaciones con uno o varios entornos. A diferencia de los sistemas generales de la teoría física clásica y en

contraposición a la mecánica de los sistemas generales (análisis de sistemas, funcionalismo, etc.), estos sistemas adaptativos dependen del tiempo, están sometidos a sus memorias internas y se auto-reproducen. (Atlan, 1979).

Históricamente, este enfoque tiene numerosos antecedentes en la época moderna. La metáfora del sistema abierto está implícita en la concepción de la novela como búsqueda; en el modelo freudiano del deseo del objeto perdido, en el proyecto de Sartre y de Heidegger de llenar lo que se conceptualiza como una pérdida primordial, etc. Lo que limita estas metáforas, empero, es su pretensión de separar el sistema abierto de su contexto biológico y sociométrico reales, al analizar los sistemas de relaciones que denominamos "individuo", "yo" o "mente" en términos elementaristas, atomistas e individualistas. El objetivo de reconciliación propuesto por esos modelos literarios, psicológicos o filosóficos se basa en utopías o en formas filosóficas románticas —no se trata de una reconciliación real—. Es por ello que las epistemologías y metodologías positivistas y reduccionistas que los subtienden están condenadas al fracaso (Wilden, 1980; Morin, 1980).

### *Las demandas del contexto*

El fundamentalismo científico propio del positivismo y el reduccionismo está basado en tres pilares: i) la malinterpretación de las nociones de *cierre* y *contexto*; ii) el desconocimiento del hecho de que el contexto está compuesto por *niveles*; iii) la imposibilidad de dar cuenta de los problemas planteados por la intersección de los tipos lógicos en los sistemas biológicos y sociales.

Es precisamente en este punto donde se sitúa la novedad programática de la teoría general de los sistemas. La delimitación del contexto es un problema de puntuación tanto al nivel de una relación dada, como al nivel de las relaciones entre sí. Los límites —al igual que los sistemas mismos— están organizados en forma jerárquica. Una importante noción que conceptúa la idea de *jerarquía de límites* es la noción de *sistema abierto* —en oposición a los sistemas cerrados.

Un sistema cerrado es aquel para el cual su contexto es irrelevante. Un sistema abierto, en cambio, es aquel que depende de su entorno para su existencia y supervivencia. Un aspecto importante de esta idea es su resurgimiento a partir de una aguda percepción socioeconómica. La crisis de la escasez, el despilfarro y la ostentación nos revelan, de pronto, que nuestros sistemas sociales —sistemas abiertos por definición— se han comportado durante estos últimos tres siglos como si fueran sistemas cerrados —más aún, como si fueran el sistema total— (Wilden, 1980).

La fuerza de esta concepción es tan grande que incluso aquellas analogías sistémicas que están comenzando a difundirse en nuestros días, terminan por sucumbir a su encanto. Gigantes como Bateson y Levi-Strauss han cometido el increíble error de abstraer la sociedad de su envoltorio material, convirtiéndola en un sistema de comunicación o una mente total. Los funcionalistas (incluyendo a J. G. Miller y su concepción de los sistemas vivientes) han adoptado el camino inverso —pero igualmente equívoco— de hacer de la sociedad un mega-cuerpo.

El discurso (cerrado) de la ciencia y la epistemología contemporáneas opera recurriendo a la *simetrización* y la *inversión* de jerarquías de relaciones que involucran niveles de poder y responsabilidad (oposiciones entre clases de sexo, edad, económicas, etc. (Balandier, 1974)).

Recurriendo a estos mecanismos, algunos aspectos centrales de las relaciones reales son neutralizados. Un modo de evitar estas inversiones y simetrizaciones, muy comunes en los encuadres terapéuticos, es examinar cuidadosamente la jerarquía de contextos dentro de la cual se establecen las relaciones. Es necesario, igualmente, prestar suma atención a los distintos tipos de niveles lógicos a lo largo de los cuales dichas relaciones tienen lugar. Es indispensable, por último, revisar las interrupciones, recodificaciones y reinterpretaciones a las que son sometidos los mensajes en función de la jerarquía real (y lógica) que ocupan los emisores.

### 3. Modelos sistémicos e intervención terapéutica

Dentro del inmenso conglomerado de teorías y enfoques que constituyen el paradigma estructural/sistémico es posible identificar algunos núcleos conceptuales que pueden servir para solidificar las bases teóricas que explican los cambios de tipo-2 en las transacciones sintomáticas dentro de la estructura familiar.

En la medida que los procesos evolutivos siguen reglas generales válidas a distintos niveles de organización de lo viviente, es posible descubrir bajo qué *condiciones* tienen lugar los cambios de regla (reencuadre terapéutico, cambio de fase, aparición/desaparición de un síntoma, etc.) en sistemas de naturaleza y estructuras muy distintas.

Las modificaciones de tipo-2 que ocurren ya sea en un sistema biológico —strictu sensu— cuanto en un sistema de interacción interpersonal son representables mediante modelos de cambios internos resultantes de influencias externas (caso: terapeuta/paciente). Ambos (y más) casos pueden subsumirse en el modelo general de los *sistemas abiertos de estructuras disipativas* —una subclase de los sistemas físicos o químicos cuya estructura de equilibrio se vuelve inestable una vez que son sacados del mismo por un campo exterior emergiendo entonces una nueva estructura, probablemente más compleja (Prigogine, 1976).

La característica más importante de estos sistemas es la de poder modificar su orden interno al recibir influencias externas. Desde este punto de vista el modelo general de las estructuras disipativas puede representar tanto las reacciones irreversibles que caracterizan la difusión química como la estabilización/desequilibración —igualmente irreversible— de una estructura sintomática (Fivaz et al., 1980).

La interacción terapéutica pone en contacto dos sistemas: uno sometido a la acción terapéutica (A) (individuo, familia, grupo) y otro que incluye las instancias que ejercen la acción terapéutica (T) (terapeutas e instituciones), que puede originarse en el mismo sistema o introducirse desde el exterior.

El primer sistema (A) es un sistema de estructuras disipativas que cumple las condiciones siguientes: i) lo forman elementos complejos acoplados entre sí, ii) posee numerosas redes de retroalimentación positivas y negativas. El sistema terapéutico (T) a su vez, es un sistema estable que cumple con las siguientes condiciones: i) es jerárquicamente superior —mucho más constante que el sistema de estructuras disipativas— su estructura no varía sino en un lapso mucho más largo que A, ii) puede proveer a A equivalentes de energía suficientes durante el período de cambio.

El proceso de cambio-2 tiene lugar en forma de una secuencia: i) el cambio se origina en una desviación local y temporaria (*fluctuación*).

En general, las fluctuaciones se compensan mediante retroalimentaciones negativas. Sin embargo, en ciertas condiciones (intensidad del campo exterior; valor de los parámetros del sistema) las fluctuaciones son amplificadas por feedbacks positivos; ii) la segunda fase consiste en la *nucleación*, o sea el surgimiento de una nueva estructura local y temporaria; iii) por último la estructura local “ocupa” todo el sistema. Si bien conserva su identidad, el sistema ha modificado su organización interna.

El estudio de numerosos casos concretos, ha mostrado la pertinencia de un enfoque de la sintomatología planteado en términos de las estructuras disipativas. ¿Es posible sobrepasar este nivel metafórico de transferencia conceptual demostrando que el uso de un modelo sistémico no sólo orienta el planteamiento y resolución de problemas, sino que provoca específicamente efectos de conocimiento inaccesibles de otro modo?

#### *Ciencia nueva, método nuevo*

Para que la imprevisibilidad, el *alea*, el cambio radical fueran pasibles de teorización, hacía falta desembarazarse de los postulados de determinismo total heredados de la mecánica clásica (Prigogine y Tengers, 1979). Los esquemas de la realidad presentados por la física tradicional eran simplificaciones extremas. En el pasado se sobrestimó el peso de las unidades y se desestimó el de las interacciones, las estabilizaciones, los

comportamientos colectivos que repercuten sobre el individuo; sirve pues, de pivot para replantear la concepción clásica de la ciencia al mismo tiempo que provee los rudimentos de un nuevo método para producir conocimientos en las ciencias humanas.

Para ello conviene evitar tanto la presión del *Superyó conceptual* presente, incluso, en la nueva física así como cualquier transferencia masiva de enunciados puramente dogmática. Las interacciones dentro de un grupo familiar son *semióticas* en vez de ser de materiales y energéticas exclusivamente.

Los cortes y delimitaciones de las unidades en interacción no coinciden ni con sus límites organizacionales ni con sus fondos legales. Las relaciones humanas —especialmente las patológicas— demuestran una exacerbación tan grande de asimetrías y faltas de complementariedades (Watzlawick et al., 1971) que olvidarlo —remitiendo todas las unidades a un patrón común— es renunciar a las adquisiciones conceptuales ganadas mediante la utilización de conceptos tales como causalidad mutua multiestabilidad, amplificación de la desviación, etc.

Es mucho lo que una teoría de las estructuras disipativas (así como otras tantas ramas de la Teoría General de los Sistemas) puede aportar para el establecimiento de una tradición de ciencia normal en las ciencias humanas. Más específicamente, es probable que nuestro entendimiento de la formación de síntomas y de su cura, mejora sensiblemente de resultados de la utilización de conceptos heurísticos provenientes de estas fronteras del conocimiento. Para comprobarlo, generalistas y especialistas, debemos trabajar en conjunto en la demarcación de nuevas áreas de acción.

## Resumen

El tiempo en que la filosofía y la epistemología pretendían *legislar* sobre la práctica científica pertenece al pasado. Por otra parte la filosofía *empirista* espontánea con que antropólogos, sociólogos y psicólogos se

acercaban a su objeto de estudio (o de transformación) está igualmente superada.

La proliferación de nuevas concepciones acerca de la naturaleza de la realidad y el papel que juega el observador participante en su construcción han privado de utilidad y sentido a los enfoques tradicionales (conductismo, funcionalismo, estructuralismo estático, etc.) en ciencias humanas. Ello no obsta, empero, para que los mismos *hegemonicen* un terreno que se niegan a abandonar.

Partiendo de una reconsideración del cambio terapéutico en tanto modificación de las reglas de juego que vuelven estable una estructura proponemos una transformación equivalente en el campo epistemológico. Nuestro objetivo: eliminar los *obstáculos* epistemológicos mencionados anteriormente así como proponer nuevos elementos conceptuales en el campo terapéutico.

Creemos que esta novedad *teórica* está contenida, en estado práctico, en el paradigma estructural/sistémico y con mayor precisión en uno de sus elementos constituyentes: la Teoría General de los Sistemas (TGS).

El cambio epistemológico buscado ha seguramente de transformar nuestra capacidad cognitiva y nuestras técnicas de tratamiento de los sistemas patológicos. La teoría de las estructuras disipativas presentes en los sistemas lejanos del equilibrio es un ejemplo, del potencial heurístico y del alcance teórico de estos nuevos enfoques. Su utilización incipiente en terapia familiar provee un ejemplo más de la amplia gama de sistemas reales cuyo comportamiento y modificación es accesible a sus principios explicativos.

## Summary

The times in which philosophy and epistemology supposed they could *legislate* scientific practice are past. Furthermore, the spontaneous *empiristic* philosophy that anthropologists, sociologists and psychologists used to approach their object of study (or of transformation) is also past.

The proliferation of new conceptions on the nature of reality and the role that the participating observer plays in its construction have deprived the traditional approaches (conductism, functionalism, static structuralism, etc.) of their usefulness and meaning in the human sciences. This does not

prevent them, however, from exercising an hegemony over a territory which they refuse to leave.

On the basis of a reconsideration of therapeutic change as a modification of the rules of the game which stabilizes a structure, we propose a comparable transformation in the epistemological field. Our objective: to eliminate the epistemological *obstacles* mentioned above and also to propose new conceptual elements in the therapeutic field.

We believe that this theoretical novelty is contained, in practical form, in the structural/systemic paradigm and more precisely in one of its constituent elements: the General Systems Theory (GST):

The epistemological change sought for must surely transform our cognitive capacity and our techniques of treatment for pathological systems. The theory of the dissipating structures present in systems that are far from balanced is an example of the heuristic potentiality and the theoretical reach of these new approaches. Their incipient use in family therapy provides yet another example of the wide range of real systems whose behavior and modification is accessible to their explanatory principles.

## Bibliografía

- ASHBY, W. R. *Introducción a la cibernética*. Bs. As., Nueva Visión, 1972.
- ATLAN, H. *Entre le cristal et la fumée. Essai sur l'organisation du vivant*. París, Seuil, 1979.
- BALANDIER, G. *Antropológicas*. Barcelona, Península, 1975.
- BATESON, G. *Pasos para una ecología de la mente*. Bs. As., Lohle, 1976.
- BHASKAR, R. *The possibility of naturalism. A philosophical critic of the contemporary human sciences*. New Jersey, Humanities Press, 1979.
- FIVAZ, E. et al. *Symptome et therapie: un modele systemique. Cahiers Critiques de therapie familiale et de pratiques de reseaux*, 1980, 35-41.
- HUGHES, P. & BRECHT, G. *Vicious circles and infinity: an anthology of paradoxes*. Middlesex, Penguin, 1979.
- HOFFSTADER, D. R. *Gödel, Escher and Bach: an eternal golden braid*. New York, Vintage, 1980.

- KUHN, T. S. *La estructura de las revoluciones científicas*. México, FCE, 1974.
- MORIN, E. *El Método*. T. 1: *La Naturaleza de la naturaleza*. Madrid, Cátedra, 1980.
- PALMADE, G. *Interdisciplinariedad e ideologías*. Madrid, Narcea, 1979.
- PRIGOGINE, I. *Tiempo, estructura y fluctuaciones. Cuadernos del G.E.S.I.*, 1980, 2.
- PRIGOGINE, I. & STENGHERS, I. *La nouvelle alliance. Metamorphose de la science*. París, Gallimard, 1979.
- WATZLAWICK, P. et al. *Teoría de la comunicación humana*. Bs. As., Tiempo Contemporáneo, 1971.
- WATZLAWICK, P. *Cambio. Principios de planteo y resolución de problemas*. Barcelona, Herder, 1976.
- WATZLAWICK, P. *El lenguaje del cambio. Elementos de comunicación terapéutica*. Barcelona, Herder, 1980.
- WILDEN, A. *System and structure. Essays in communication and exchange*. London, Tavistock, 1980.

---

Algunos cuestionamientos acerca de la función del terapeuta

---

MARIA CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES

---

*Dorrego 2381, 1425 Buenos Aires, Argentina*

---

En este trabajo el término “función” está usado en el sentido en que lo hacen Watzlawick y colaboradores<sup>1</sup> en su libro “Teoría de la Comunicación Humana”, es decir, como una relación entre variables interdependientes y su significación en la interacción humana. Es por esto que se hace necesario definir siempre la función, en este caso la del terapeuta, en un contexto determinado. El contexto del que aquí nos ocupamos, y en el seno del cual vamos a definir las funciones interactuantes, es el que se constituye al organizarse un sistema terapéutico, esto es, la estructura relacional que se establece entre un Consultante (una persona, una familia, una institución, etc.) y un Consultado (un Agente de Salud, en este caso un terapeuta).

Un buen número de autores, desde diferentes corrientes psicoterapéuticas, han hecho aportes sobre el tema, preguntándose, no ingenuamente, qué espera el “paciente” del terapeuta al que consulta. S. Nacht<sup>2</sup>, desde el psicoanálisis, cuestiona el modelo médico tradicional y propone, entre otras cosas, una revisión de la discriminación entre las consultas que se hacen acerca de problemas “orgánicos” y las que se definen como

consultas acerca de problemas "psicológicos", aceptando que desde el dolor físico se puede precisar más claramente un pedido de alivio hacia quien se inscribe en el marco cultural del sujeto doliente como un referente confiable (médico, curandero, farmacéutico, etc.).

¿Quién es en este planteo el Consultado? Es aquel que participa de una teoría y de recursos derivados de tal teoría, tales que pueden promover una modificación —también conceptualizada desde la tal teoría— que produzca alivio en el Consultante y prevenga ulteriores consecuencias.

Como terapeutas, volvemos a plantearnos con S. Nacht algunas preocupaciones:

1) ¿Cómo, con qué parámetros delimitamos el campo de lo que aflige al ser humano? ¿Hasta dónde un dolor es orgánico o funcional?

2) ¿Hasta qué punto podemos usar el modelo médico tradicional y pensar en el Consultante como en un "enfermo" o un "paciente", con las consiguientes implicaciones socioculturales estigmáticas de dichos términos?

3) ¿Siempre el que consulta se ve a sí mismo disminuido o perjudicado desde su propia definición de lo que lo aflige?

A su vez: ¿qué es lo que solicita el Consultante del Agente de Salud? Parece obvio: que cumpla con una función de consultor en el área de la salud. Obvio, pero no fácil de definir, ya que, entre otras complicaciones, habría que definir qué se quiere decir por Salud. Tomando en cuenta el sentido interactivo del concepto "función", podemos pensar que el que consulta espera las respuestas del que sabe, las acciones del que puede hacer, las ideas del que puede pensar, etc., así hasta agotar la gama de posibles funciones que no estarían en el Consultante y sí en el Consultado, y que con esa tal distribución pueden quedar implícitas en la estructura que se organiza en la consulta.

Si avanzamos aún más, citamos a Lucien Israël<sup>3</sup>; "el terapeuta, los síntomas y la enfermedad son objetos surrealistas" dice tomando la idea que transmite el cuadro de René Magritte "El terapeuta".

Pero, ¿con qué leyes se rige esta estructura si sus unidades constituyentes son objetos surrealistas?

Los terapeutas que incorporamos las ideas provenientes de la teoría de los sistemas generales como modelo para pensar acerca de las relaciones humanas entre los miembros de los sistemas abiertos, podemos plantearnos la hipótesis de que las leyes de funcionamiento de tales sistemas nos den algunas respuestas a los interrogantes planteados. En principio sabemos que en los sistemas abiertos se describen dos funciones esenciales<sup>4-6-10-7</sup>: 1) la cohesiva, que tiende a mantener la identidad y la continuidad del sistema, y 2) la diferenciadora, que tiende a producir las transformaciones que desarrollarán autónomamente a cada componente del sistema. Este modelo conceptualiza estas dos funciones dándoles el carácter de presentes, fundamentales, y en una ejercitación permanente, mutuamente contradictoria, regulada por una variable ineludible: el Tiempo. De esta manera esta estructura terapéutica caminará también hacia, por un lado, estabilizarse, repetir sus interacciones y volverse predecible, asegurando así su identidad y su continuidad, mientras que, por otro lado, tenderá a que sus componentes crezcan, se entrenen y maduren lo suficiente como para poder diferenciarse, en cuyo caso la estructura organizada como sistema terapéutico deja de tener sentido.

Estamos ahora definiendo un proceso, con sus leyes de funcionamiento, inscripto en una estructura que, como tal, está constituida por componentes relacionados entre sí, y que, en tanto proceso, necesariamente toma en cuenta el factor tiempo para su definición.

De aquí surgen nuevas preguntas: ¿cuál es la posición posible del Consultado en la estructura terapéutica desde la cual asegure la promoción de un cambio y sea entonces "efectivamente" terapéutico? ¿En qué momento del proceso estará el terapeuta preparado para evaluar y aceptar los cambios en la estructura que llevan inexorablemente a su disolución? En fin: ¿será posible para el terapeuta, sabiendo que su condición de existencia en esa estructura depende de su función en la interacción con el paciente, operar en cada

encuentro en el plano procesual adecuado como para que los factores de transformación superen siempre a los homeostáticos?

En ejemplos tomados de otras organizaciones estructurales, como la familia, podemos entender claramente cuáles son las funciones cohesivas privilegiadas que permiten la supervivencia del sistema, bloqueando lo más posible la introducción de variables diferenciativas (tales como el tiempo, el crecimiento bio-psico-social, etc.). Sólo necesitamos observar la conducta de algunas madres de hijos adolescentes o aun mayores, que ejercen las funciones infraestructurales que les corresponden a los hijos —pueden pasar inadvertidas dentro de la definición de tareas domésticas—, funciones que mientras se ejercen sustitivamente desde los padres impiden la necesaria preparación de los hijos para poder dejar en algún momento el núcleo familiar originario y armar el propio.

¿Cuáles son sus equivalentes en el sistema terapéutico?

Volviendo a Lucien Israël: “el terapeuta no es la Verdad, ni el Evangelio ni la Revelación”, y “el proceso terapéutico requiere que terapeuta y paciente hagan juntos un descubrimiento”; y aun otros autores van más allá<sup>5</sup>, poniendo en evidencia que, cuanto más se identifique el Consultado con lo solicitado, más se ata la estructura a la ilusión de absoluto en sí misma.

¿Cuál es la función “esperada” desde el que consulta? Los ejemplos surgen fluidamente en el marco de la consulta familiar. A veces se trata de confirmaciones o reforzamientos de la posición asumida por alguno/s de los miembros de la familia a través de la alianza con el terapeuta; a veces, muy ligado a lo anterior, que el terapeuta “cambie” un sector del sistema<sup>4</sup> (generalmente el llamado paciente identificado), sin mover ni tocar a otros, etc., pero, en todos los casos la respuesta del terapeuta asumiendo la función complementaria a la demanda obtura el proceso en tanto cristaliza la estructura en las posiciones iniciales de “fallado” - “experto”, y certifica las delegaciones masivas mutuas que esto implica.

¿Cuál es entonces el quid de la función del terapeuta?

Desde la terapia familiar puede pensarse como el arte de, por un lado conseguir el acceso a formar parte del sistema terapéutico, aceptando en algo el papel asignado por la familia en la danza relacional<sup>6</sup>, teniendo en cuenta que no jugamos ni podemos jugar la función esperada, para, por otro lado, tener la oportunidad de cuestionar y reubicar permanentemente en el/los consultante/s la función delegada transitoriamente en el terapeuta.

Pero, ¿cómo llevar esto a cabo desde el seno mismo de una estructura que plantea esta paradoja?<sup>7</sup> ¿Cómo resolver esta difícil exigencia al terapeuta de una posición por la cual debe ubicarse como sujeto-miembro de un sistema y a la vez en una posición meta?

Desde diversas corrientes terapéuticas se proponen técnicas que ayuden a sostener eficazmente esta posición paradójica del terapeuta, generalmente basadas en la instrumentación de alguna forma de disociación para el terapeuta, ya sea como experiencia unipersonal o como alternativas a jugar entre los distintos miembros de un equipo terapéutico (coterapias, supervisiones, etc.). También las técnicas que colocan todo el sistema terapéutico (terapeuta y pacientes) en un campo imaginario apuntan a desarrollar tanto en uno como en otros las alternativas de entrada al sistema y a la vez la posibilidad de mantener una ubicación metasistémica. En estas últimas técnicas la propuesta trata de expandir la disociación a todo el sistema terapéutico, con los beneficios de la experiencia que hace así el que consulta, que puede revisar sus percepciones acerca de sí mismo sin el filtro de su propia selección sobre lo que muestra (en función de su propia visión de lo que crea importante que el terapeuta conozca). En esta cuestión han profundizado las psicoterapias psicodramáticas, gestálticas, etc., que crean escenarios para “hacer actuar”. Una variante, capaz de crear un escenario particular, en la propuesta del uso de un campo metafórico de interacción, accesible tanto a los pacientes como al terapeuta<sup>9</sup>. El “campo metafórico”, el “escenario dramático”, la “puesta en acto” del modelo estructural<sup>10</sup>, los ejercicios gestálticos, etc., son situaciones que gozan del privile-

gio de participar de, por lo menos, dos planos de existencia a la vez, el del contexto terapéutico y el propio de la propuesta técnica, que el terapeuta y los pacientes pueden transitar para explorar dichas situaciones desde contextos diferentes.

También la inclusión sistemática de la variable *TIEMPO* en la terapia con la programación de cambios a lo largo de un proceso acotado, apunta a resolver indirectamente el dilema planteado.

Pero, y teniendo en cuenta en especial las complejas Terapias Familiares, quizás todo esto sea insuficiente, y el nivel de resolución posible tienda inexorablemente al armado de un sistema terapéutico que pueda contar con una intervención metaestructural, más allá del sistema terapeuta-familia, que rescate permanentemente una función terapéutica al servicio del cambio. <sup>7 bis</sup>

La necesidad de esta ineludible apertura a miradas externas tal vez explique el acelerado desarrollo de las aplicaciones de la tecnología (Cámara de Gessel, videgrabaciones, etc.), que incluyen el factor metasistémico asegurador del cambio, ya se trate de la presencia de un consultor, un supervisor, un coterapeuta o un equipo de pertenencia.

## Resumen

Se trata de un análisis de: a) la relación Terapeuta-Consultante (paciente), pensada desde la perspectiva de considerarla un sistema abierto, y, por lo tanto, sujeta a tendencias cohesivas y a tendencias transformativas; y de b) la "función", entendida en la aplicación interaccional de su concepción matemática, del Terapeuta en ese sistema, a quien el Consultante "delega" lo que supone que no "tiene" o no "puede".

Este análisis lleva implícito, por un lado, la noción de un proceso, con sus propias leyes de funcionamiento, inscripto en una estructura constituida por componentes interrelacionados y que, en tanto proceso, toma en cuenta el factor tiempo para su definición; y, por el otro, el cuestionamiento de la posición paradójal del Terapeuta en esa estructura, por la

que debe actuar asegurando un cambio que significa la disolución de la estructura que le da identidad como tal.

En el trabajo se muestran ejemplos ilustrativos de otras organizaciones estructurales en las que prevalecen las funciones cohesivas que mantienen estático el sistema, y se proponen algunos recursos técnicos que posibilitan al Terapeuta una meta-mirada sobre el sistema que le consienta una evaluación del momento del proceso adecuado para la elección de cada intervención transformativa.

Y, finalmente se plantea el desempeño de la función terapéutica siempre a cargo de un equipo de dos o más terapeutas, con diferente distancia con respecto al Consultante, como garantía de una "función" efectivamente terapéutica, especialmente en el caso de las complejas intervenciones familiares. (Un terapeuta en contacto directo con la familia, trabajando con otro que permanece fuera monitoreando la intervención, y participando en la elaboración de la misma, como un ejemplo.)

## Summary

This paper emphasizes the so called "function" of the Therapist as a member of the therapeutic system, function analysed from the point of view that the therapeutic system is an open system that, therefore, tends to preserve itself with cohesive tendencies while tends to promote growth and independence through differentiative lines of behavior.

The therapist, then, needs to belong to the structure Family - Therapist and, at the same time, have a permanent perspective of it from outside the system, so as to be aware of the adequate intervention to assure change.

Different therapeutic approaches bring useful contributions to this issue, helping the therapist to create, in a way, alternative imaginary fields that enable him to, being inside the therapeutic system, dissociate himself and have a metaperspective of his relationship with the consultant in every moment of the therapeutic process.

The author stresses the point that specially in the difficult Family Therapy area, all this needs to be reinforced and the only successful way seems to be the real presence of another therapist, in a different level of involvement that, in a working team with the therapist, can bring the so much needed metaperspective.

### Bibliografía

1. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON. *Teoría de la Comunicación Humana*.
2. NACHT, S. *La presencia del Psicoanalista*, pp. 122-129.
3. ISRAËL, L. *El psicoanalista a pesar de sí mismo*. Letra Freudiana N° 2.
4. ANDOLFI, MAURIZIO. *La Terapia con la Familia*.
5. SAFOUAN, M. *Estudios sobre el Edipo. La función del Padre Real*, p. 141.
6. NAPIER, A.; WHITAKER, C. *The Family Crucible*.
7. BATESON, G. *Pasos Hacia una Ecología de la Mente*.
7. (bis) CEREJIDO, M. *Orden, Equilibrio y Desequilibrio*.
8. ANDOLFI, M.; MENGHI, P. *Provocative Supervision*.
9. NICOLÒ, A. M. *El Empleo de la Metáfora en Terapia Familiar*.
10. MINUCHIN, S.; FISCHMAN, Ch. *Family Therapy Techniques*.

---

Aproximación a la dinámica familiar e individual de pacientes con trastornos en la adquisición del lenguaje.

---

Lic. SUSANA ROMERO y Lic. MARTA SIERRA

---

San José 807 – Dto. 1101 – Montevideo – Uruguay

---

*Agradecemos la colaboración de los Dres. Carlos Mendilaharsu y Selika Acevedo de Mendilaharsu, del Prof. Alejandro Amy, y de la Psic. Silvia Arrambide de Amy.*

---

Formamos parte de un grupo<sup>1</sup> de investigación interdisciplinaria (Centro Neuropsicológico de Montevideo, Uruguay), dedicado a la investigación de los trastornos del lenguaje en los adultos y en los niños.

Nuestro subgrupo de psicología intenta abordar o tratar de entender qué lugar ocupan los aspectos emocionales en los diferentes trastornos del lenguaje.

En este trabajo nos centraremos en aquello que tiene que ver con la adquisición del lenguaje en el niño.

La finalidad de esta investigación con este subgrupo es la de intentar entender cómo los trastornos afectivos pueden incidir en la afección.

Como dice De Waehlens: "El acceso a la palabra es explicable en términos hegelianos como el paso que lleva desde el

<sup>1</sup> Lic. Clara Uriarte de Pantzoglu, Lic. Aída Fernández, Lic. Aída Miraldi, Lic. Marina A. de Litvan, Dra. Gloria Laguardia, Dr. Lizardo Valdez, Dra. Susana Romero, Psic. Marta Sierra.

elemento de la mediatidad al de la mediación. Se trata pues, de renunciar a la inmediatez del objeto e ingresar en la mediación, revelándose ésta última como inseparable a la constitución de un simbolismo. Nombrar un objeto es renunciar a la presencia de dicho objeto”.

“El acceso del lenguaje es un proceso por el cual el niño se separa en primer término del primer objeto (su madre), y en segundo lugar acepta la negatividad, la ausencia”.

“Esta renuncia a la inmediatez es sustituida por la palabra o por otro signo que la sustituya. Este complejo proceso está sobredeterminado por la estructura del sujeto, sujeta múltiples relaciones donde juegan un papel preponderante las figuras parentales”.

Partiendo de la base de que el niño puede llegar a ser fácilmente el depositario masivo de los conflictos intrafamiliares es que en nuestra investigación estuvo privilegiado, en las entrevistas, el abordaje de la familia, situación ésta que nos posibilitó un mejor entendimiento de la conflictiva individual.

### El caso

Alejandro es un niño de tres años de edad que es visto en el ateneo del Centro Neuropsicológico en presencia de sus padres que dicen que notan que no oye y no adquiere el lenguaje. La madre dice haber notado esta dificultad al año, que ella interpretó como sordera. Hasta este momento los padres no habían consultado por este trastorno, manejándose con el diagnóstico hecho por ellos de “sordera”.

En el ateneo se diagnostica una Disfasia de grado moderado a severo llamando la atención que hasta el momento no hubieran consultado, siendo ambos padres maestros y la madre especializada en reeducación de sordos. Este último hecho fue marcado preguntándonos qué conexiones podrían existir entre el déficit del niño y la profesión de su madre. A punto de partida de este interrogante se decide abordar el caso, realizando una serie de entrevistas que se planificaron de la siguiente manera.

Entrevista con los padres y el niño presente, entrevista con

los padres solos, una entrevista de juego y luego una entrevista de devolución. Situación ésta que por nuestra flexibilidad permitió que ellos modificaran el encuadre, permitiéndonos visualizar a través de dichas modificaciones diversos aspectos de la dinámica familiar.

### Algunos datos de la dinámica familiar

Los padres de Alejandro tienen treinta y tres años el padre y treinta y uno la madre, viviendo en una ciudad del interior; llevan ocho años de casados, siendo Alejandro hasta el momento único hijo.

El nacimiento de este niño se produce cuando ellos pasan a vivir a la casa de los abuelos maternos, donde además vive el hermano de la madre, tres años mayor que ella, con un diagnóstico de esquizofrenia, que comenzó a los diecisiete años haciendo eclosión cuando deja la casa de los padres para venirse a vivir a Montevideo a estudiar. Hace cinco años este cuadro se agrava, no pudiendo trabajar ni estudiar vuelve a la casa de sus padres y desde entonces vive en un total estado de dependencia con su madre. Esta historia surge ya en la primera entrevista.

Cuando se hace referencia a este tema dice:

Madre: “Los detalles de la enfermedad no los sé, todo quedó entre el psiquiatra y él”.

Padre: “Nosotros al grupo familiar tampoco le decimos nada sobre la enfermedad de Alejandro”.

Vemos aquí cómo relacionan inconscientemente la enfermedad de aquél con Alejandro y cómo emerge una situación que oficia como secreto familiar en relación a la enfermedad mental.

Luego tratando de justificar la situación actual de Alejandro dicen:

Padre: “Mi madre es maestra. Mi hermana también. Van a querer reeducarlo ellas”.

Pudiendo vislumbrar cómo Alejandro, así como su tío, son

utilizados en su enfermedad como una forma de aglutinarse, de encerrarse. Desde el principio de la entrevista han insistido en que fueran ellos los reeducadores, sobre todo la madre de Alejandro, cuestionando la reeducadora que les ha sido asignada en el ateneo.

Luego agregan:

Madre: "Por la voz me daba cuenta de que no podía ser sordo".

Padre: "Desde los dos años lo veíamos como sordo".

Madre: "Este año nos fuimos entreteniendo". "Uno lo ve tan normal en todo..." "Uno tiene una resistencia a aceptar las cosas".

Mostrándonos la ambivalencia en el deseo inconsciente de que permanezca sordo, de entretenerse con el síntoma, encerrándose en él.

Madre: "Ya tenemos el código de él". "Nos entendemos".

Desde el comienzo de la entrevista Alejandro mostró el lugar que ocupaba en la pareja, sentándose entre ambos, pidiendo atención tanto al padre como a la madre e interfiriendo la comunicación con nosotros.

Luego nos fueron relatando que Alejandro dormía en el cuarto con los padres y muchas de las veces en la misma cama con ellos. Que nunca se habían separado de él.

Durante el transcurso de la entrevista algunos señalamientos nuestros permitieron en Alejandro una reubicación por la que éste pudo comenzar a jugar con la caja de juego.

Situación ésta que permitió que trajeran la primitiva relación con Alejandro.

Madre: "El problema lo tenía de bebé".

Padre: "Al nacer le hicimos todos los tests".

Madre: "Yo ya tenía la especialización". "Primero investigué si era sordo. Lo estimulaba con campanitas, cajitas de música".

Padre: "La vista también, ver si no era ciego, le colgamos objetos sobre la cuna".

Madre: "Le hacía todo lo de la maduración, toda la parte motriz y cognoscitiva. Cuando vi que las etapas las cumplía me desentendí". (Al año.)

Habían señalado que al año había una pérdida de vocabulario.

En este material pudimos ver cómo Alejandro había sido tenido por sus padres como objeto de investigación que les servía para dejar de lado todo el compromiso afectivo con él y entre ellos, viendo cómo era sustituido el afecto, situación encubierta por sus profesiones y en el afán de investigar.

Pensamos que en este vínculo distorsionado el afecto es sustituido por la investigación de un supuesto déficit inconscientemente deseado por los padres, al haberlo dejado de estimular. Alejandro lo puede haber vivido como un abandono y haber facilitado una regresión.

Madre: "Los juegos los seguimos haciendo, para estimularlo". "Le hacemos sonar una cajita de música, el despertador".

Luego la madre refiriéndose a la elección de carrera y a su embarazo dice:

"Yo quise especializarme en retardo, luego decidí dedicarme a sordos".

Sobre el embarazo dice:

"Nunca lo pasé tan bien". "Ni antojos tuve". "Nunca soñé con un hijo que necesitara reeducación".

Material en el que vemos cómo se ve la negación de un deseo inconsciente mostrado en la conducta de Alejandro desde el nacimiento de un antojo-sueño de tener un hijo sordo o retardado como una forma de ir entreteniéndose.

En la segunda entrevista se cita a los padres solos, pero vienen con Alejandro porque dicen que no tienen dónde dejarlo. Como deben volver al interior por motivos de trabajo se decide señalarles algunos aspectos de lo visualizado en la primera entrevista en lo que hacía a la relación de ambos con Alejandro, situación ésta que provoca gran resistencia con ansiedades persecutorias sobre todo en la figura del padre.

El padre dice: "Yo juego a la pelota con él tratando de ver si sabe los verbos Tirá, Vení, Dame".

Siendo muy difícil el tratar de hacerles entender que esta conducta en vez de ayudarlo puede perjudicarlo. Hasta un momento de insight de la madre. En este momento cuando jugando con Alejandro (la madre tiene un títere en la mano, tratando de jugar con él, Alejandro come una galletita).

La madre dice: "No sé qué hacer. No sé como tratarlo y ahora comienza a llorar".

Explicitando que iba a pedirle la galletita a Alejandro para ver si entendía el verbo Dame.

Este Insight disminuye las ansiedades persecutorias y permite una mejor comunicación con nosotros, cosa que permitió plantearles una serie de conductas a seguir con Alejandro, como por ejemplo:

- sacarlo de la cama y del cuarto
- discriminarse de la reeducadora, favoreciendo que se genere otro tipo de vínculo entre ellos y Alejandro

y se les plantea una entrevista de pareja que ellos determinan que por factores de trabajo sea un mes después.

Al finalizar la sesión Alejandro no se quiere ir.

Se realiza así la tercera entrevista en la que habían sido citados solos y aparece la mamá de Alejandro acompañada por su madre y Alejandro.

La abuela dice: "Vengo a acompañar solamente".

Nosotros, pensando en que esta modificación del encuadre que ellos realizan puede tener una significación, es que decidimos incluirla.

Alejandro se sienta entre ambas y la abuela pasa a ocupar el lugar que en las entrevistas anteriores había estado ocupado por el padre.

Comienzan con un diálogo que se refiere a los aspectos agresivos y a la destructividad de Alejandro que no tolera límites, interviniendo en este momento solamente la abuela.

Esto nos demuestra una invalidación de la figura de Alejandro que luego se continúa con la figura del padre.

A través del material de esta entrevista vemos cómo aparece una invalidación masiva de las figuras masculinas de todo el grupo familiar, viniendo ellas a ocupar el lugar de esas figuras invalidadas y a defender la estructura familiar patológica simbiótica de esta familia. Ocupan el lugar de la ley, ley que invalida al tercero impidiendo la ruptura de la simbiosis y mostrándonos que su función en esta entrevista será también la de tratar de mantener esta estructura que siente amenazada por la introducción de nuestro rol como terapeutas, donde también oficiáramos como ese tercero.

Más tarde, se da un movimiento donde hay un esbozo de reconocimiento a nivel inconsciente de que esta situación de permanente invalidación que permite el mantenimiento de la simbiosis origina la "locura".

Dice la abuela de Alejandro refiriéndose a su hija: "Tengo miedo que se ataque de los nervios".

Más adelante nos relatan, siempre desde una actitud invalidante, y a través de una proyección masiva la estructura también simbiótica patológica de la familia del padre de Alejandro.

De esta manera vemos cómo el vínculo entre ambos padres repite y sostiene reforzados en el síntoma de Alejandro, las estructuras familiares de ambos en las cuales se sienten aprisio-

nados, pero mostrándonos una alianza que permite cumplir con los mandatos de ambas familias.

Vemos además cómo se omite hablar de la esquizofrenia del hermano de la madre de Alejandro, pasando a relatar la simbiosis de la hermana del padre de Alejandro.

La madre de Alejandro dirá en esta entrevista refiriéndose a su suegra:

“Se cree médica, psicóloga, psiquiatra. Ella lo sabe todo”.

Luego dice:

“El problema es que yo no tengo identidad”.

Aquí la abuela dice:

“No estará influenciada por mí”.

Sabemos por lo que ya vimos, cómo la madre de Alejandro está identificada en esas figuras que todo los pueden.

Aceptar nuestra intervención implicaría renunciar a esas figuras femeninas omnipotentes donde ellas son la ley.

Reafirmando esta hipótesis vemos cómo se reconoce la mejoría de Alejandro a partir de las entrevistas en la medida de posibilitarle un lugar, pero lugar que implicaría la ruptura de los modelos patológicos simbióticos vistos.

Dice la madre de Alejandro: “El ahora no mezcla lo de la casa con lo de la escuela”. “El se soltó”. “El delimita”. “Si mi suegra va a la casa él la echa”. “Fue después de las entrevistas”. “No duerme solo aún, el padre no lo deja”.

Pero queda el mensaje de esa madre que se opone y que niega finalmente ya que no concurre más a las entrevistas fijadas ni responde a nuestro llamado.

## Conclusiones

Hemos mostrado un caso con un diagnóstico clínico de Disfasia de desarrollo.

Dice Mendilaharsu en su trabajo sobre patología del lenguaje en el niño, que se trata de un distrubio que ha dado lugar a múltiples controversias, tanto en torno al diagnóstico, como a la etiología.

Habiendo autores que lo consideran como un disturbio funcional sin substractum anatómico en el que podían incidir una serie de factores entre los que estarían los disturbios afectivos.

En su concepto hay dos hipótesis etiológicas, la primera en que habrían alteraciones estructurales determinadas por lesiones precoces de diversa naturaleza y en segundo caso, los casos familiares (genéticos).

Hemos mostrado a través del material clínico cómo desde una comprensión psicoanalítica se pueden detectar sin duda elementos determinantes del mantenimiento del síntoma.

También cómo puede haber incidido el deseo inconsciente de los padres de tener un hijo enfermo y en esta área específica.

Creemos que el material muestra claramente cómo Alejandro nace de un deseo y es inmerso en un discurso familiar que lo determina.

Creemos que este caso nos enfrenta a las complejas relaciones entre el nivel psíquico y el orgánico, punto al cual convergen diversas disciplinas que a pesar de sus esfuerzos aún no han logrado una adecuada articulación de los conocimientos que permiten una comprensión más acabada del mismo.

“Desde la época en que se despliega el pensamiento de la madurez de Freud se ha ido afirmando una comprensión epistemológica de tipo dialéctico donde la causalidad ya no es concebida como una acción lineal, sino como complejas interrelaciones entre el nivel psíquico y el nivel orgánico.

Nos ha parecido de interés este punto dado que podemos tender a instalarnos en una ciencia psicoanalítica o antipsicoanalítica, neurofisiológica o bioquímica. Esto puede ser índice

de una necesidad "de certezas" que más que facilitar obture el desarrollo científico que hoy nos impone la necesidad de enfoques multidisciplinarios".

## Resumen

Formamos parte de un grupo interdisciplinario (Centro de Neurología de Montevideo - Uruguay), dedicado al estudio e investigación de los disturbios del lenguaje, tanto en el adulto (Afásicos) como en el niño (Disfásicos).

Nuestro subgrupo de psicología dinámica, intenta abordar la incidencia de los trastornos afectivos, tanto a nivel individual, como a nivel familiar en los distintos trastornos específicos de ambos campos.

En este trabajo nos vamos a referir a algunos aspectos de nuestra investigación en las Disfasias. Nuestros interrogantes en torno a esta investigación serían: si los trastornos de la esfera afectiva, tanto a nivel individual como a nivel de lo grupal familiar serían consecuencia, si estarían interactuando con los factores orgánicos y cómo incidiría en el mantenimiento de dicho síntoma.

## Summary

We belong to the interdisciplinary group (Centre of Neurology of Montevideo, Uruguay), dedicated to the study and research of disturbances of language, in adults (Aphasics) as well as in children (Dysphasics). Our sub-group of dynamic psychology attempts to approach the incidence of emotional disturbances both at individual and at family level, in the different alterations specific to both fields.

In this paper we refer to some aspects of our research in the Dysphasias. Our questions connected with this research are whether the disturbances of the emotional area, at individual as well as at the level of the family group, are a consequence of organic factors or whether they interact with these, and if so, in what ways they influence the maintenance of this symptom.

## Bibliografía

- AULAGNIER, PIERA: *Observación sobre la Estructura Psicótica*. Carpeta de Psicoanálisis. Edición: Letra Viva, marzo 1978.
- AULAGNIER, PIERA: *El Sentido de lo Perdido (o El Esquizo y la Significación)*. Carpeta de Psicoanálisis No. 1. Psicoanálisis de la Psicosis. Edición: Letra Viva, marzo 1978.
- AULAGNIER, PIERA: *Los Destinos del Placer*. Edición: Petrel, 1979.
- AMY, ALEJANDRO: *Seminario sobre Epistemología y Filosofía del Lenguaje*. Dictado entre 1976 y 1979. (Inédito)
- ACEVEDO DE MENDILAHARZU, SELIKA, y MENDILAHARZU, CARLOS: "De los Discursos y el Lenguaje". *Revista Uruguaya de Psicoanálisis*. Tomo 57 - Año 1978.
- ALTMAN DE LITVAN; ARRAMBIDE DE AMY; HAJER DE WOLF; ROMERO, SUSANA; URIARTE DE PANTASOGLU: "Aproximación a la Psicopatología de una Paciente con Colitis Ulcerosa". *Psicología y Enfermedad*. Editorial Imago, 1979.
- BLEGER, JOSE: *Simbiosis y Ambigüedad*. Biblioteca de Psicología Profunda. Editorial Paidós - Tercera Edición, 1975.
- BION, W. R.: *Aprendiendo de la Experiencia*. Editorial Paidós, Bs. Aires, 1975.
- CASAS DE PEREDA y Col.: "La Transferencia en el Análisis de Niños. De la Novela a la Historia". Suplemento de la *Revista Uruguaya de Psicoanálisis*, No. 23 - 1975.
- DE AJURIAGUERRA, J.: *Manual de Psiquiatría del Niño*. 1974.
- DE AJURIAGUERRA, J. y col.: *Le Des Audimutités Psychiatrie Enfant* 1-6-62, 1958.
- DE AJURIAGUERRA, J. y col.: "Evolución y Pronóstico de la Disfasia en el Niño". *Manuel de Psychiatrie de l'Enfant*. 8-391-453, 1965.
- DE JAURIAGUERRA, J. y col.: "La Ontogénesis del Lenguaje". *Rev. Prat* 15-17; 2241-2250, 1965.
- DE WAEHLENS A.: *La Psicosis*. Ediciones Morata, 1973.
- FOUCAULT, MICHEL: *Enfermedad Mental y Personalidad*. Paidós, 1979 - 2da. Edición.
- FREUD SIGMUND: "Inhibición, Síntoma y Angustia". *Obras Completas*. Tomo XX. Edición Amorrortu.
- FREUD SIGMUND: *La Afasia* (1889). Editorial Nueva Visión, Bs. Aires.
- FREUD SIGMUND: "Proyecto de una Psicología para Neurólogos" (1895). *Obras Completas*. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.

- FREUD SIGMUND: *Introducción al Narcisismo*. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
- FREUD SIGMUND: *El yo y el Ello*. Edición Amorrortu.
- LACAN, J.: *Ecrits*. Edición Seuil, París, 1966.
- LACAN, J.: *Función y Campo de la Palabra en Psicoanálisis. Lectura Estructuralista de Freud*. México, Ed. Siglo XXI - 1971.
- LANG, J. L.: *El abordaje Psicoanalítico de las Psicosis en el Niño*. Publicado en Carpeta de Psicoanálisis I.
- MANONI, M.: "L'Enfant, sa Maladie et les Autres".
- MANONI, M.: *Psicosis Infantil*. Prólogo. Edición Nueva Visión, Pág. 7 a 9, 1971.
- MENDILAHARZU, C.: "Patología del Lenguaje en el Niño". *Estudios Neuropsicológicos*. Tomo III, Editorial Delta, Montevideo, 1981.
- MENDILAHARZU, C. y col.: "Batería de Pruebas para el Estudio del Lenguaje del Niño de Acuerdo al Modelo de Sprec y Benton". *Estudios Neuropsicológicos*. Tomo III, Editorial Delta, Montevideo, 1981.
- MENDILAHARZU, C. y col.: "Evolución de la Conducta de Copia de la Figura Geométrica en el Niño". *Acta Neurológica Latinoamericana*. 192-213. Año 1972.
- NOCETTI, J. C.: "La Organización de las Relaciones Familiares".
- PICHON-RIVIERE, E.: *Del Psicoanálisis a la Psicología Social*. Editorial Galerna, 1970.
- PICHON-RIVIERE, E.: *Teoría del Vínculo*. Edición Nueva Visión, 1979.
- RYCROFT, C.: *Diccionario de Psicoanálisis*. Paidós, 1976.
- SHERZER, ALEJANDRO: "Diferentes Formas de Participación de los Padres en la Psicoterapia de Niños".
- SIERRA, MARTA: "Algunas Consideraciones sobre la Psicoterapia de los Niños y su Interrelación con el Grupo Familiar". Publicado en las *Actas del Congreso de Psicoterapia de Grupo*. Venecia, 1980.
- WINNICOTT, D. W.: *El Proceso de Maduración en el Niño*. Editorial LAIA, 1965.
- WINNICOTT, D. W.: *Realidad y Juego*. Granica Editores, 1972.

---

Anorexia nerviosa. Una comunicación clínica.

---

Lic. WANDA SANTI

---

Juncal 2605, 7º, C - 1425 Buenos Aires - Argentina

---

Cuando escuché a Salvador Minuchin y a Mara S. Palazoli, hace ya unos años, hablando de su forma de trabajo con familias, tuve una clara sensación de encontrarme frente a una técnica de trabajo que permitía realmente un abordaje breve y efectivo en casos como por ejemplo la Anorexia Nerviosa, clásicamente considerada entre las patologías más severas y resistentes a los métodos psicoterapéuticos tradicionales.

Hace ya un tiempo que estoy trabajando solamente con los padres en terapia familiar, apoyando teóricamente mi elección en un pensador sistémico, Murray Bowen, quien solía seleccionar como unidad de trabajo sólo una parte del sistema familiar. Pocas veces Bowen veía al niño sintomático, concentraba su trabajo en los padres, diciendo que, cuando éstos pueden mantener sus problemas dentro del subsistema parental, el niño, libre ya, de esta triangulación, deviene capaz de evolucionar y crecer.

Varios años de experiencia, le han demostrado al Grupo de Milán, el efecto terapéutico inmediato, que suele tener el dejar en la consulta a los padres y los niños en casa, aún en casos muy graves.

Mi modalidad de trabajo se desarrolla de la siguiente manera: después de una o dos entrevistas diagnósticas con todo el grupo familiar, comunico a los padres que por el momento seguiré trabajando sólo con ellos. Durante la primera entrevista con los padres solos, explico mi interés en que trabajemos juntos, para que puedan ser ellos y a través de la convivencia cotidiana, quienes modifiquen la situación que los preocupa. Esta modalidad resulta útil y exitosa, a mi juicio, por varias razones:

- a) Los padres pasan de una posición pasiva de incompetencia e impotencia, a una activa, dirigida y sistematizada, con el aval de un experto con el cual establecen un pacto de colaboración.
- b) Quedan automáticamente establecidas y aumentadas las fronteras generacionales, cuyos límites imprecisos son una constante en familias disfuncionales.
- c) Los padres triangulan con otro tercero, el psicoterapeuta.
- d) Hacemos una alianza con el área libre de conflicto de los padres, para trabajar incrementando una de las funciones de todo sistema, la transformación.

Sabemos que los sistemas para poder cambiar deben modificar la relación existente entre homeostasis y transformación, a favor de esta última. Según nos enfrentemos a una familia más o menos rígida o flexible deberemos adecuar nuestra estrategia para producir el desbalance terapéutico hacia el polo de la transformación. En terapia familiar sistémica, buscamos descubrir el modo de transacción que soporta o da sostén al síntoma, para trabajar luego en el cambio de esa transacción.

Los psicoterapeutas no nos enfrentamos habitualmente con patología que ponga en riesgo de muerte al paciente, pero en familias psicósomáticas, sí. Es por ello que, aún para un terapeuta muy experimentado, el tratamiento de una familia anoréctica, resulta todo un desafío.

Las familias psicósomáticas presentan cinco características que las distinguen: aglutinamiento o pegoteo, sobreprotección, rigidez, dificultad para resolución de problemas y sobreinvolu-

cración del P.I. en el conflicto parental. Esta última es considerada clave o llave del sostén del síntoma psicósomático.

### Definición

Entendemos por anorexia nerviosa, un síndrome psicósomático caracterizado por síntomas psíquicos y físicos. Potencialmente fatal en una proporción del 10 al 15%. La enfermedad generalmente aparece en mujeres de clase media, comienza durante la adolescencia, aunque se registran casos en adultos o preadolescentes. Rara vez en varones.

Los síntomas físicos incluyen la pérdida de por lo menos un 25% del peso corporal, amenorrea, hiperactividad, hipotermia y en casos avanzados, todas las características típicas de la caquexia.

Los síntomas psíquicos incluyen ausencia de deseos de comer, intensos temores de aumentar de peso, insistencia en mantenerse extremadamente delgados, perturbación de la imagen corporal, sentimientos de ineficacia y retraimiento.

### El sistema anoréctico

Está priorizada la cercanía en los contactos personales. Predomina la lealtad y protección sobre la autonomía y autorrealización. No compiten, buscan aprobación, se subordinan. La recompensa por un buen rendimiento, no es el conocimiento o el logro personal, sino el amor o aceptación de los demás. Hay poca autonomía por intrusión y sobreprotección de todos. El desacuerdo y la iniciativa personal son considerados traición. Está muy bien considerado el negarse a sí mismo en beneficio del otro. Hay una sobreinvolucración de todos y cada uno con todo el resto, a causa de lo difuso de las fronteras intergeneracionales. Son familias dedicadas a los hijos, ocupadas de su bienestar, hipervigilantes de sus actividades y preferenciando sus necesidades psicobiológicas, sobreocupadas de las funciones corporales. Son niños que crecen muy observados y observadores de sus adultos, se recluyen en el interior de la familia por la intensa dificultad para lidiar con el mundo externo, por eso la

llegada de la adolescencia actúa de disparador de la enfermedad. El grupo de Milán destaca como constante en estas familias el rechazo de las opiniones de los demás, entendiendo entonces el rechazo del alimento como una respuesta extrema a un sistema rechazante.

Una maniobra típica de estas familias es el pedido encubierto de uno u otro de los padres al hijo, para que satisfaga su carencia, por la profunda desilusión que su compañero le produce. Esta distribución le resta energía para una existencia propia, menos aún para una crisis adolescente.

### Caso Clínico

Presentaré un brevísimo resumen de las dos primeras entrevistas de un caso de anorexia nerviosa que traté en diez entrevistas. Pretendo demostrar la posibilidad de lograr éxito en corto plazo, en una patología que por el compromiso vital que implica no nos permite disponer de tiempo. Estamos en Noviembre de 1981.

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Derivación: Psiquiatra       | Peso en marzo 81: 38 kg.            |
| Padre: 36 años. Abogado      | <i>Primera visita al pediatra:</i>  |
| Madre: 35 años. Ama de casa. | Septiembre 81                       |
| Ceramista.                   | Altura 1,45. Peso, 33 kg.           |
| JESSICA: 12 años 7mo.        | <i>Primera entrevista familiar:</i> |
| Dolores: 10 años 5to.        | Noviembre 81                        |
| Elmer: 6 años 1ro.           | Altura 1,45. Peso, 28,100           |

**Problema:** Jessica fue llevada a su pediatra en el mes de septiembre porque su abuela materna alertó acerca de que estaba adelgazando y comía mucho menos. Pesaba en ese momento 33 kg o sea 5 menos que en Marzo de ese mismo año al volver de las vacaciones. El pediatra manifiesta el temor de que se trate de una anorexia nerviosa, pero decide esperar un poco. Habla con Jessica y obtiene de ella la promesa de aumentar su ingesta. A pesar de esto la pérdida de peso continúa muy rápidamente, ven al psiquiatra, a quien ya habían consultado

unos meses antes, quien los deriva directamente a tratamiento de familia. Esta consulta con el psiquiatra había sido 8 meses atrás. Consultaron por manías religiosas, intensos temores por los castigos del infierno, preocupación extrema por el pecado y llantos constantes. Había muerto una compañera suya un mes antes, lo que había hecho recrudecer sus preocupaciones por la muerte y los castigos del infierno. El padre, muy reticente con la intervención psicoterapéutica, recurrió a los consejos de un sacerdote al que pidió que hablara con Jessica, porque, dijo: "estas cuestiones de la religiosidad, se resuelven de esta manera". Así fue como pocas semanas después de comenzado el tratamiento individual que se le indicara en aquella oportunidad, Jessica dejó de concurrir.

Se trata de una familia donde la pareja tiene y manifiesta serias dificultades de relación. El esposo ha descalificado siempre a su mujer por incompetente como ama de casa, y madre poco e inadecuadamente dedicada a los hijos. Hace unos 2 años que la madre de Jessica comenzó a hacer cerámica en un taller, al cual concurre varias tardes por semana. A partir de este hecho, esto pasa a ser el motivo desencadenante de desacuerdo inconciliable entre los padres. El padre es una persona muy religiosa y tienen siempre discusiones con la madre y los chicos sobre el tema del cumplimiento de los preceptos de la Iglesia. Jessica es usada como juez por su madre, quien suele pedirle que opine sobre la injusticia del trato que recibe de su esposo. Pero por otro lado Jessica, reprocha mucho a su madre, las horas que ésta dedica a su taller y no está en la casa, asimismo hace listas de alimentos junto con su padre para "suplir" los olvidos de la madre. Desde hace unos meses ayuda en las tareas de la casa, se ocupa de sus hermanos menores y está sumamente atenta a las comidas de ellos. Le molesta sobremanera que se hagan distintas comidas en la casa (dietas de la madre) y las horas de la comida han pasado a ser un verdadero drama familiar.

**Resumen de primera entrevista:** Vienen los padres, con Jessica y Elmer. Dolores se ha quedado en casa porque tenía

fiebre alta. Relatan que han venido por indicación del psiquiatra, ya que se acercan indefectiblemente al límite de peso que el pediatra estipulara para internar a Jessica y el descenso continúa. Está pesando hoy 28,100 kg y el límite son los 28 kg. Cuentan alternativamente, uno u otro de los padres, sobre los manejos y problemas con respecto de la comida, la negativa de Jessica, los ruegos de ellos, las promesas incumplidas, y la exigencia de que se la mantenga informada de todo lo que hacen sus padres. Hablan de su historia, como una niña buena, dócil, con buen rendimiento escolar, muy religiosa, con pocas amigas. Tuvo una época en que actuaba despóticamente con el servicio doméstico; ahora sólo lo hace con su madre, pero en forma alternada con declaraciones de que su mamá es sensible y buena como ella y la entiende, no como su padre que es insensible y la reta exigiéndole que cumpla con la religión.

La mamá acusa al papá de haber alentado a Jessica a abandonar el tratamiento individual. Y ya que esa fue su conducta hace unos meses, le pregunta directamente a qué se debe que ahora esté aquí. El papá le contesta que es por la situación actual de Jessica. Sí es grave y que él está dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija. Pero, me dice, en realidad el problema de Jessica es que no quiere vivir con el drama de ser gordita como la madre que está permanentemente haciendo dietas medianamente efectivas. Me explica que él siempre discutió con su mujer porque insistía en que ella debía darles de comer en la boca desde pequeños y que en esta circunstancia actual debería hacerlo nuevamente. La mamá, insiste en que no está de acuerdo, pero que, como hasta su propia mamá le dice que ella está haciendo algo mal, ya no sabe qué hacer. La mamá cuenta que se llevan muy mal porque su marido la acusa de irresponsable e ineficaz. El esposo interviene moderando las opiniones de la esposa diciendo que esos no son problemas. Pero acuerda en que Jessica está últimamente muy ocupada en ayudarlo a él con las compras en el Supermercado el sábado, para lo cual ya le tiene preparadas las listas. En realidad, agrega, esto no es nuevo, ya que hace años que él debe controlar a diario la heladera para ver qué cosas se han olvida-

do de comprar. Dicen que sus otros dos hijos no traen problemas. Dolores últimamente se está quejando de que Jessica le insiste en que coma más.

Yo hice en esta primera entrevista dos intervenciones, la primera en el momento en que arreciaban los comentarios acerca de la religión y la comida y la segunda a modo de cierre.

**1ra. intervención:** "Veo que Jessica ha demostrado ser capaz de llevar los temas que preocupan particularmente a papá y mamá hasta sus extremos. Hace un año con la religión que tanto le interesa a Ud. (al padre) a tal punto de no poder cumplir con los preceptos. Y ahora con la comida que es capaz de controlar tan exitosamente para no engordar como Ud. (a la madre)".

**2da. intervención:** "Yo voy a reunirme a trabajar solamente con Uds. dos (señalando a los padres) en las próximas entrevistas. Vos, Jessica, seguramente estarás internada, ya que sólo te faltan 100 gramos para ese momento. Veo que has decidido salir de tu casa, de esta manera, para no seguirte tentando de reemplazar a tu mamá".

#### *Comentarios de la primera entrevista*

La primera intervención, apunta a cambiar a Jessica de su posición de P.I., el enfermo, débil, al fuerte con poder. Más aún que sus padres, a quienes es capaz de superar.

La segunda intervención tiene dos partes; una primera que apunta a delimitar subsistemas. Padres en consulta, hijos en casa. Y otra donde se prescribe el síntoma. Se da por sentado que estará internada, para lo cual debe persistir en no comer. La connotación positiva está en la consideración de su buena intención de salir de la casa para no ocupar el lugar de la mamá.

Queda así planteado un doble ligamen terapéutico. Puede rebelarse a la prescripción paradójal, pero sólo si abandona el síntoma. Se le da salida posible porque se la muestra capaz de controlar y decidir.

Por otro lado queda también insinuado un desafío a la madre a que retome su lugar, ya que Jessica renuncia a él a tan alto costo personal. Las reacciones del sistema aparecen en los relatos de la 2da. entrevista.

**Resumen de la segunda entrevista:** Vienen los padres solos. La madre relata que Jessica se fue llorando de la entrevista de familia. Lloró bastante tiempo en su casa, pero con rabia, como indignada. Como si la hubieran vejado. En cuanto se calmó fue a hablar con las mucamas, diciéndoles irónicamente, que la habían llevado a lo de una Sra. que no tenía nada que hacer y se iba un rato de su casa a sacarle el dinero a la gente. A este comentario de Jessica, la madre agrega.

—¡ Fiel reflejo de su padre!

Continúa relatando que al llegar la hora de la comida de aquel día de la primera entrevista, Jessica anunció que no iba a comer. Entonces su madre decidió que no iba a “quedarme como una estúpida a su lado luchando para que coma” y se fue a su cuarto. Jessica fue a buscarla y le pidió por favor que la acompañara. Para gran sorpresa de su madre comió “normalmente”. Hacía muchísimo tiempo que sólo escarbaba y pico-teaba en su plato. Esto los sorprendió. Sin embargo siguen la entrevista con una discusión sobre si ella dirige o no la casa. El opina que todo está en manos del servicio doméstico. Ella debería dejar de ir al taller definitivamente, tal como lo está haciendo últimamente, que Jessica estaba tan mal.

La mamá me dice que están muy mal entre ellos, que hace tres meses que no tienen relaciones sexuales, de modo que no cierran jamás su puerta, ya que sólo lo hacían en ocasiones de tenerlas. Refieren que les resulta muy molesto cerrar la puerta, porque desde que nacieron los chicos mantienen todo abierto, para poder escucharlos por si necesitan algo durante la noche. Ya ahora los chicos están acostumbrados y exigen que no cierren aunque son más grandes. El estilo y tónica de la entrevista sigue más o menos en estos términos y desembocan en un pedido, que formula la mamá de qué podría hacer yo por ellos y sus graves dificultades de pareja.

La madre se manifestó muy animada por la reacción de Jessica quien ha seguido comiendo, aunque poco, pero lo suficiente como para no seguir perdiendo peso, lo cual ha evitado hasta el momento la internación. El papá es mucho más reticente e insiste en que es muy poco aún.

Yo intervengo diciéndoles:

**T:** “La situación de la pareja de Uds. es preocupante, pero no ha sido el motivo que los trajo. Si están mal y desean separarse lo podrán hacer más adelante, es más, yo puedo ayudarles a que lo hagan, pero no ahora. Mi interés en este momento es pactar con Uds., para que colaboren conmigo y puedan modificar situaciones familiares a través de la convivencia, para lo cual voy a pedirles que hagan una serie de cosas. Sé que es una tarea muy difícil que tendrán que hacer, pero será un sacrificio más que harán por su hija”.

Y les comunico los puntos de la tarea:

- 1) Mantener absoluto secreto con respecto a todo lo referente a las entrevistas.
- 2) Por lo menos una salida secreta de ambos, antes de la próxima entrevista. Respondiendo a las probables preguntas acerca de su destino y motivación: “son cosas nuestras”.
- 3) Cerrar con llave la puerta de su cuarto todas las noches, desde este día en adelante. Tengan o no intención de tener relaciones sexuales.
- 4) Que cada uno de ellos anote sobre las reacciones del resto de la familia, frente a todos estos cambios, porque de lo contrario les será difícil recordar tantas cosas.

#### *Comentarios de la segunda entrevista*

Toda esta virulenta explicitación de las dificultades de la pareja, estaría marcando la reacción de rechazo del subsistema parental, ante la designación que se hizo de ellos como P.I. ya que son los que vendrán a las sesiones. Si la hija mejora el síntoma y ellos continúan mal, queda descartado este elemento, como posible determinante de la sintomatología.

La primera parte de la intervención, apunta a calmar su preocupación con respecto de su mala relación, ya que digo que no me ocuparé de esto ahora. Pero intento lograr una modificación de ese aspecto del sistema a través de la tarea que les solicito.

- 1) Si mantienen secreto, delimitan un ámbito privado de su subsistema, estimulando al otro a lo mismo. Todos los hijos recibirán el mismo trato "la información". Recordemos que Jessica exigía ser siempre informada de los movimientos de sus padres.
- 2) La salida de ambos, apunta a aumentar la cohesión de la pareja, pero sin sentirse comprometidos, puesto que lo hacen por mi pedido expreso. Además la respuesta que deben dar a las preguntas, impide que Jessica siga metida entre los dos.
- 3) Reiterar la imagen de un espacio de la pareja, distinto al de los hijos, porque una puerta cerrada delimita dos espacios, el de cada uno de sus lados. Forzará a asumir el crecimiento de los hijos. Ya no son pequeños, como para que sea necesario estar tan atentos a sus necesidades.
- 4) Si toman nota de las reacciones, mantienen a mi juicio un nivel mayor de observación que de acción. Hay una segunda intención que consiste en un vínculo de alianza con el terapeuta a través de las anotaciones que se hacen para él.

Creo que el llanto, la indignación y los comentarios de Jessica son su reacción por sentirse descubierta, por esta inesperada redefinición del síntoma como instrumento de poder.

El primer ataque al sistema consistió en privar a Jessica del control que ejercía sobre las relaciones familiares a través de su "loco" comportamiento de no comer. Ya su conducta no es involuntaria, sino que tiene una lógica y una intencionalidad autodeterminada.

La madre sale de su posición de insistencia inútil, porque Jessica ya no es víctima de un terrible síntoma involuntario,

sino una adolescente rebelde que se niega a comer y así pretender manejarla.

*De cómo continuó el tratamiento:* Durante las 8 entrevistas restantes, seguí trabajando sobre los temas centrales de esta interacción familiar:

Delimitación de fronteras de los subsistemas.

Aumento del espacio individual de cada miembro.

Asunción de los padres de sus funciones de decisión y autoridad frente a los hijos.

Consolidación de una conducta que implicará acuerdos de los padres.

Bloqueo de pautas habituales de manejos de Jessica.

Bloqueo de conductas de coalición y triangulación que uno u otro de los padres utilizaba alternativamente.

La evolución del síntoma, con altibajos, fue dibujando una curva ascendente, acercándose a una ingesta normal.

En la 6ta. entrevista cuentan que el pediatra ha interrumpido el pesaje sistemático ya que Jessica había superado los 28,500 kg. Ya en la 8va. entrevista hablan de que ha comenzado a incorporar golosinas y alimentos dulces en general, e inclusive pastas. Gradualmente va abandonando la selección de alimentos hipocalóricos y aumentando el volumen de la ingesta.

Todo esto se acompaña de un mejor humor, la ven contenta más a menudo. Las comidas no son dramáticas aunque aún les cuesta lograr no discutir durante ellas. En la 10ma. y última entrevista, están agradecidos y contentos de los resultados de la terapia pero reiteran lo difícil de sus relaciones de pareja. Se van de vacaciones con un bagaje de estrategias distintas para manejar las situaciones que puedan presentarse.

Los objetivos que determinaron el comienzo de la terapia, a saber: evitar la internación y modificación del síntoma, se habían logrado.

*Resumen entrevista de seguimiento:* Tres meses después, Jessica pasó bien sus vacaciones, ha mejorado más aún su

WANDA SANTI

estado de ánimo, ríe, tiene algunas salidas con amigas y está haciendo una buena adaptación al nuevo colegio. Tuvo un descenso de peso a su vuelta a Buenos Aires, pero la mamá se puso muy firme y bajo amenazas se impuso a Jessica, quien recuperó sus 30 kg en pocos días. Ese es el peso que mantiene. Manifiestan estar conformes con la evolución de Jessica.

### Resumen

Es la comunicación de un caso de anorexia nerviosa aguda en una niña de 12 años.

El trabajo consiste en la presentación clínica; exposición de la técnica de abordaje de terapia familiar breve que se utilizó; desarrollo y terminación del tratamiento; y resumen de entrevista de seguimiento realizada tres meses más tarde.

### Summary

This is the account of a case of acute anorexia nervosa in a 12 year old girl. The paper consists in the clinical presentation, exposition of the approach with brief family therapy used, development and termination of the treatment, and summary of the follow-up interview three months later.

### Bibliografía

- SELVINI PALAZZOLI, MARA: *La anoressia mentale*, Editorial Fetrinelli - Milano - 1981.
- SELVINI PALAZZOLI, MARA: "Terapia de la familia a transacción

- esquizofrénica". Revista *Terapia Familiar*, Argentina, Bs. As., No. 4, 1979.
- SELVINI PALAZZOLI, MARA: *Paradoja y contraparadoja*,
- SELVINI PALAZZOLI, MARA, y PRATA, GIULIANA: *Hacia una metaterapia. Una prescripción a niveles múltiples*. 1981.
- MINUCHIN, SALVADOR: *Familias y terapia familiar*. Granica Editor. Barcelona, 1977.
- MINUCHIN, SALVADOR: *Psychosomatic Families*,
- BATESON - JACKSON - FERREIRA y otros: *Interacción familiar*. Ediciones Buenos Aires, 1980.
- ANDOLFI, M; MENGHI, P.; NICOLO, A. M; SACCU, C.: "La interacción en los sistemas rígidos: un modo de intervención en la familia con paciente esquizofrénico". Revista *Terapia Familiar*, No. 4, 1979.
- KAUFMAN, M. RALPH; HEIMAN, MARCEL: *Evolution of Psychosomatic Concepts-Anorexia Nervosa: A Paradigm*. International Universities Press Inc., New York, 1964.
- HAYLEY, JAY; BASS, JOSSEY: *Problem Solving Therapy*. California, 1978.
- HALEY, JAY: *Estrategias en Psicoterapia*. Toray, Barcelona, 1971.
- HALEY, JAY: *Tratamiento de la familia*. Toray, Barcelona, 1974.
- ROBLES GORRITI, CARLOS J.: *Anorexia nerviosa*. Bs. As., 1980.

---

## El juego de las identidades en el sistema familiar

---

Lic. ALBA MARTA SCHABAS

---

El presente trabajo es una síntesis personal de algunas conceptualizaciones teóricas en las que se basa el modelo de trabajo clínico con familias del Centro de Familias y Parejas (CEFYP).

Los conceptos aquí desarrollados son producto de la elaboración conjunta del equipo de Integrantes de la Institución y sus Directores.

Voy a hacer hincapié en aquellos aspectos que aluden a la identidad como concepto relacional que se juega en el sistema familiar.

Desde las formulaciones básicas de la Teoría General de los Sistemas abordaré el concepto de sistema como una totalidad organizada de elementos en permanente interacción, con capacidad de autorregulación a través de mecanismos homeostáticos.

Partiendo de las propiedades de los sistemas antedichas me refiero al sistema familiar como a un conjunto de personas relacionadas por lazos de parentesco, que habitualmente conviven, que interactúan significativamente, y que están organizados

y funcionan de acuerdo a ciertas reglas de organización de la relación que son observables y evaluables en la comunicación bajo la forma de redundancias relacionales.

Los miembros del sistema familiar pautan y pactan respecto de: qué debe hacer cada uno, cuándo, a quién debe dirigir ciertas acciones, cómo se deben establecer las relaciones con el afuera, los acuerdos, en qué se puede acordar, en qué no, cómo deben ver a los demás, cómo deben ser vistos, etc.

Por lo tanto regulan sus acuerdos relacionales.

Desde la Teoría de las Relaciones Interpersonales de Laing, la identidad es aquello por lo cual cada uno siente que es el mismo en un proceso témporo-espacial. "Es aquello por lo cual se es identificado".

La identidad es un proceso que se va desarrollando en cada uno, en relación con otros, que nos devuelven una cierta imagen de nosotros mismos, y nos la confirman o no en sucesivos intercambios relacionales.

Estos otros son fundamentalmente figuras significativas de nuestra historia. Aprendemos a ser quienes se nos dice que somos, y de esa manera respondemos a los otros.

La familia como sistema establece sus reglas de relación, regula sus intercambios relacionales, de manera tal que la conducta de cada uno de sus miembros permita la convalidación de la imagen de cada uno por parte de los otros: Yo soy Yo en esta particular estructura sistémica con esta particular red de relaciones.

Cada uno de los miembros del sistema familiar actual, posee modelos de relación témporo-espaciales que funcionan como un modo de ver, ser visto, desear, actuar, etc., que necesitan ser recreados en este nuevo sistema, para poder confirmar su identidad.

Los modelos relacionales históricos de cada uno de los miembros del sistema familiar actual, es una matriz de relaciones, de pautas de relación témporo-espaciales, que se repiten en la organización actual, y en ese sentido constriñen y restringen las conductas y relaciones de sus miembros, constituyendo la compleja trama del sistema familiar en desarrollo.

La particular organización del sistema familiar, las idiosincráticas reglas que lo gobiernan, permiten que la identidad de cada uno de sus miembros le sea confirmada, en tanto se es tal o cual en este lugar y en este tiempo, tal como se fue en otro lugar y en otro tiempo. Esto se da en la medida en que ciertos modelos relacionales continúan vigentes.

Al repetir un modelo relacional del pasado en el aquí y ahora, intentamos dar y que nos devuelvan una determinada imagen de nosotros mismos, tal como nos fue devuelta y actuada recíprocamente en otro momento histórico.

Lo que se repite no es un vínculo (por ejemplo madre-hijo, hermano-hermana), sino la estructura relacional de ese vínculo, el modelo de relación, que podrá ser transferido a cualquier vínculo en el sistema familiar actual.

Esto sería la Transferencia Relacional Dominante (T.R.D.)\*.

A partir de los modelos relacionales que cada uno de los miembros del sistema transfiere, propone su sistema de creencias, su propia ideología acerca de la realidad y su organización, y su propia ideología acerca de sí mismo y sus relaciones.

A partir de estas propuestas, se van estableciendo acuerdos entre los sistemas de creencias de cada uno de ellos, generándose el sistema de creencias compartido, que sustenta y es sustentado por las reglas de organización de la relación específicas de ese sistema.

En este proceso, la imagen de identidad de cada uno de los miembros, y su necesidad de convalidación en esta relación actuarían como ejes y motores del juego relacional.

En este sentido, y desde el concepto sistémico de causalidad circular, identidad, T.R.D., sistema de creencias y reglas, se van intrincando y sustentando mutuamente en el funcionamiento del sistema familiar actual.

Cabría aquí hacer una distinción, entre sistemas más rígidos y más flexibles. En los sistemas rígidos, o sea aquellos en los cuales la generación de conductas alternativas para resolver situaciones es escasa, el sistema de creencias compartido que es

\* Término acuñado por el doctor Adolfo Loketek.

sustentado y se sustenta en la regla, es un sistema de creencias rígido, con características míticas, y con escasa posibilidad de ser cuestionado. En este sentido, las reglas de organización de la relación también lo son, y habrá menos alternativas de convalidación de la imagen de identidad de sus miembros.

En este caso, es posible que frente a situaciones nuevas que se generen en el sistema a partir de cambios externos o de su propio desarrollo interno, la única alternativa posible sea la aparición de un miembro sintomático.

De esta manera, el síntoma actúa simultáneamente como encubridor de la disfuncionalidad de las reglas del sistema, y como denuncia de la misma. La aparición de síntomas genera cierto tipo de sentimientos y relaciones específicas que hace peligrar la convalidación de la imagen de identidad de sus miembros. El sistema se encuentra en crisis.

Contrariamente a lo planteado, en sistemas familiares más flexibles, con mayor posibilidad de generación de conductas alternativas, habrá una mayor posibilidad de cambio de las reglas de la relación, correspondiéndose con un sistema de creencias compartidas más amplio y flexible, y mayor la cantidad de aspectos de la identidad de sus miembros posibles de ser convalidados.

A modo de ejemplificación de los conceptos anteriormente desarrollados, me referiré a un caso clínico.

Ricardo y Silvia consultan por dificultades en la pareja, insatisfacción y posible separación planteada por Silvia, situación ésta que se viene dando desde hace tres o cuatro meses, coincidente con el nacimiento de la primera hija de ambos. Esta presentación del problema es planteada con fuerza por parte de Silvia, y con un tono de resignación por parte de Ricardo.

Relatan que hasta ese momento vivían muy bien como pareja, estaban muy contentos de estar juntos, y con grandes deseos de tener un hijo.

Resulta llamativo desde un primer momento la forma de expresarse de los dos miembros de la pareja, hablando siempre en plural ("nosotros"), y con gran dificultad para hablar en

primera persona. A pesar de las intervenciones terapéuticas en este sentido, a lo largo del primer proceso de intervención no hubo por parte de Ricardo o Silvia expresiones del tipo "yo pienso" o "yo siento".

En general, y en todas las áreas aparecía un notorio acuerdo entre ellos planteado desde el "nosotros", pero aun así se sentían insatisfechos.

Ricardo había conseguido un trabajo estable poco tiempo antes del nacimiento de Mariana, estimulado y buscado por Silvia, y hasta ese momento vivían de changas, "de la caza y de la pesca", tal como ellos lo refieren.

Frente a mis preguntas dirigidas a alguno de los miembros de la pareja, éste comenzaba a responderme, y el otro proseguía y así sucesivamente, al estilo locutores de radio. Esta situación fue redundante a lo largo de las primeras entrevistas, lo que me permitió inferir la siguiente regla de organización de la relación: Cada vez que alguno de ellos hace un intento de diferenciarse, el otro acude en su ayuda para que la situación se convierta en un: de a dos.

En el sistema terapéutico no había un lugar para un tercero, salvo que se mantuviera a una distancia óptima, permitiendo a Ricardo y Silvia relacionarse en forma siamesa. En este caso, cada uno de los miembros de la pareja convalidaba al otro en la imagen de identidad de ser: un pedazo del otro, un otro yo, un siamés.

Mariana, obviamente, había pasado a ser el tercero, que a partir de sus demandas y necesidades como bebé, no podía mantenerse a una distancia óptima, y por lo tanto su presencia amenazaba la regla de organización que hasta ese momento había sido funcional para este sistema, como así también la imagen de identidad que cada uno de ellos ofrecía y convalidaba en el otro.

A partir de la investigación de los modelos relacionales históricos de Ricardo y Silvia, relacionados con la regla anteriormente inferida, aparece:

*desde Ricardo:* Tiene un hermano gemelo, con el cual se

criaron juntos y solos, ya que su madre muere cuando ellos tenían cuatro años, y el padre había muerto antes. Quedaron a cargo de sus hermanos mayores, pero ellos se apoyaron y cuidaron uno del otro siempre. Vivieron siempre juntos, desarrollaron las mismas actividades, y se separan por primera vez hace 3 años, en que Ricardo viene de Chile (donde estaban viviendo), y su gemelo no puede hacerlo. En esta época conoce a Silvia.

**desde Silvia:** Es hija única de un matrimonio que se separa durante su temprana infancia. Ella queda viviendo con su madre, y a su padre no lo volvió a ver más. Vivió siempre muy pegada a su madre, "compartimos siempre todo", "fuimos siempre muy amigas y compañeras", "pero mi casa era triste". Cuando Silvia conoce a Ricardo, su madre estaba a punto de concretar una relación de pareja estable, situación ésta que enojaba mucho a Silvia, y por primera vez comienzan a aparecer peleas con su madre.

Estos modelos relacionales históricos, estas estructuras de relación, sustentaban y eran sustentadas por las reglas de organización de la relación de esta pareja. Estas eran las T.R.D. de Silvia y Ricardo, que se jugaban en el sistema familiar actual, y se convalidaban mutuamente.

Por otra parte, el sistema de creencias propuesto desde cada uno de ellos era:

**desde Silvia:** Hay que vivir de a dos, como si fuésemos uno solo, hasta que yo decida (relacionado con la decisión de separación de sus padres, y su propia decisión de separarse de su madre).

**desde Ricardo:** Hay que vivir de a dos, como si fuésemos uno solo, hasta que la muerte o alguna circunstancia externa lo decida, y resignarse (relacionado con la muerte de su madre, o la situación política de un país).

El sistema de creencias compartido era: Vivamos de a dos, como si fuésemos uno solo, y si así no fuere, Silvia decidirá, y Ricardo se resignará.

Es así como a partir del nacimiento de Mariana, se ve amenazada la estabilidad de este sistema, a la vez que da cabida al sentimiento de insatisfacción, y amenaza la convalidación de ciertos aspectos de las imágenes de identidad de cada uno de ellos.

Los cambios en este sistema, a lo largo del proceso terapéutico, se dieron a partir de intervenciones encerrantes, provocativas y paradójales, que incluían el nivel actual e histórico, y fueron llevando al sistema a la búsqueda de conductas alternativas para la nueva situación planteada.

## Resumen

La propuesta central del trabajo alude a la identidad como concepto relacional que se juega en el sistema familiar.

Partiendo del concepto de identidad de Ronald Laing, y de las propiedades de los sistemas descriptas por la Teoría General de los Sistemas, se conceptualiza a la familia como un sistema con reglas que organizan las conductas de sus miembros de manera tal, que permitan la convalidación de las imágenes de identidad de cada uno.

Se incluye el nivel histórico como repetición de modelos relacionales históricos transferidos al sistema familiar actual por cada uno de sus miembros.

Se conceptualiza la necesidad de convalidación de las imágenes de identidad como eje y motor del juego relacional sistémico familiar.

Se ejemplifican estos conceptos con la presentación del recorte de un caso clínico.

## Summary

The main proposal of this task refers to the identity as a related concept that is played in the family system.

Starting from Ronald Laing's identity opinion, and the qualities of the systems described by the Systems General Theory, the family is considered as a system with rules that organize the behavior of the

members in such a way, that would allow the confirmation of the identity image of each one of the family members.

The historic level is included as a repetition of related historical models transfered to the actual family system by each one of its members.

The need of confirmation of the identity images is considered as the shaft and motor of the systematic familiar related game.

These concepts are illustrated with the presentation of a clinical case clipping.

### Bibliografía

VON BERTALANFFY, LUDWIG: *Teoría General de los Sistemas*.

LAING, R. D.: *El yo y los otros*.

LAING, R. D.: *Percepción interpersonal*.

BIKEL, ROSALIA: *Las reglas de la relación en la pareja conyugal*.

LOKETEK, ADOLFO: *Comunicación personal*.

---

### Aplicación de la terapia familiar en niños y adolescentes

---

Dra ANNY SPEIER, Dra. ESNEA AULETTA y Lic. RUBEN VADAGNEL

---

*Centro de Estudios y Asistencia Médico Psicológica de la Niñez y Adolescencia - 11 de Septiembre 986/88, 1426 Buenos Aires*

---

La psicoterapia familiar traslada la atención desde el individuo a la familia en la cual éste interactúa. Ya no se centra en el enfermo reconocido sino persigue la transformación de la familia misma en un grupo que funcione mejor. La familia se convierte, así, en el foco del tratamiento. La familia es concebida como un todo orgánico, como una estructura, cuyas partes son interdependientes.

En tal sentido, refleja la influencia, por un lado, de la psicología social (H. S. Sullivan, K. Levin) y, por otro lado, de la cibernética con los aportes del análisis de sistemas iniciado con Ludwig van Bertalanffy y de la teoría de la comunicación (Ruesch, Watzlawick, Satir). Coinciden, además, en señalar al hombre como "existente" en su medio las corrientes existencialistas europeas. Tres conceptos son esenciales en este enfoque:

1. El resultado de las relaciones personales es algo más que la suma de las personalidades en juego. Los miembros de una familia se relacionan de acuerdo a algunos acomodamientos que

determinan su interacción. Estos aunque por lo común no explicitados o reconocidos, forman en su totalidad la estructura de la familia, y esto implica un modelo ideal que representa una realidad de la estructura de un orden distinto a la realidad de sus miembros individuales, realidad que, a su vez, modifica a los individuos.

**2. El concepto de retroalimentación y sus efectos acumulativos.** La teoría de la comunicación intenta enfocar la conducta dentro de un sistema en el cual todo cambio en una parte afecta al sistema, que presenta una tendencia a mantener la constancia y estabilidad, comparable al principio de homeostasis de Cannon. Bateson, sin embargo, opina que éste no alcanza para explicar fenómenos como el crecimiento, el cambio y la creatividad, que se explican por el concepto de retroalimentación, que pone en evidencia la circularidad de la interacción como causa del cambio y de la *modificación progresiva* entre los individuos interactuantes, proceso que Bateson ha denominado cismogénesis. A actúa sobre B, pero B no sólo responde a A con su posibilidad de respuesta originaria, sino como B más A, de modo que A contestará a su vez como A-(B-A). La conducta, pues, es enfocada como una reacción funcional interrelacionada, pero como lo advierte el mismo Watzlawick para "captar su significado hay que agregar la entelequia intrapsíquica de cada una de las partes". Como se ve, al asumir esta dimensión surge el dilema entre dos enfoques, que algunos sienten como contrapuestos: lo intrapsíquico y lo interaccional. (Sue Walrond Skinner, Laing). Sin embargo, no hay contradicción con un concepto del desarrollo interpersonal, en el que consideramos que desde un principio se establece una interacción circular entre el medio y lo intrínseco que el individuo trae al mundo como potencial que tiende a desarrollarse (C. Jung, T. Rea). En este enfoque el desarrollo genético es siempre al mismo tiempo interaccional, y podemos enfocarlo en forma vertical u horizontal, y, sin duda, en terapia familiar estamos enfocando el segmento en forma horizontal, aunque en ningún momento puede decirse que uno excluya del todo al

otro. Al igual que la estructura individual, tenemos que concebir, pues, también a la estructura familiar, al modelo, no como algo estático, sino como un proceso de estructuración constante que implica desestructuración de lo antiguo y apunta a la estructuración de lo nuevo. Con lo cual se agrega la dimensión del *porvenir* como fundamental para comprender el dinamismo de la conducta individual y de la familia.

**3. Influencia de la interacción actual en la modificación de la conducta.** El reconocimiento de la importancia de la interacción actual se basa en la observación que los individuos se modifican en el presente independientemente de su pasado y actúan en forma distinta en distintos contextos. Y es este reconocimiento el que lleva a centrar la terapia en la interacción actual que favorece la reestructuración en el aquí y ahora.

**Procesos de la estructura familiar.** La dinámica de la familia está dada por su funcionamiento total y no por la dinámica individual de sus miembros. Comprender a la familia significa descubrir el proceso dinámico básico de la familia concebida como una estructura en evolución constante (Brody, Ackermann).

Aquí se perfilan diferencias en la medida que el énfasis está puesto más exclusivamente en el aspecto de estructura y sistema, señalando modos de interacción y objetivos del sistema (Minuchin, Sue Walrond Skinner, Watzlawick) o en los aspectos internos de la interrelación, señalando complementariedad, individuación y crecimiento (Ackermann, Brody, Satir), o la imagen fantaseada de la familia o "los objetos internos" (Laing, Teruel). De todos modos, habrá que descubrir la implementación particular de estos procesos en una familia dada, el momento del proceso de cambio evolutivo y particular por el que atraviesa, finalidad y objetivo de su funcionamiento. Procesos.

**Procesos específicos de la comunicación.** Entendiendo que el proceso de la comunicación es un proceso de interrelación

no simplemente a nivel verbal, sino en todos los niveles no verbales de contacto e interacción, se comprende que a través de éste se desarrolla todo el crecimiento del individuo, a través de contextos aceptadores y esclarecedores, o rechazantes y confusos, en los que tienen lugar la confirmación positiva o la disconfirmación anuladora. Lo que importa, pues, es el *valor relacional*. Las familias disfuncionales se manejan con mensajes indirectos o en relación de "doble vínculo", lo que afecta en grado diverso el desarrollo de la identidad de sus miembros.

**El enfoque psicoterapéutico.** La familia presenta al terapeuta una estructura simultánea compleja, donde la multiplicidad de las interrelaciones, la diversidad de las edades y de los subgrupos, y su finalidad parcialmente diferente respecto al sistema familiar, coloca al terapeuta, de inmediato, en el plano de la conducta actual. Se perfilan, sin embargo, en el manejo tendencias distintas en el sentido del énfasis puesto más en el "vínculo de la relación" o en la interacción, si la terapia se dirige más a la relación o a la estructura. La línea divisoria parece marcarse en el concepto del cambio y en la forma de producirlo. Beels y Herber distinguen dos tipos de terapeutas familiares, los "reactores" y los "conductores", según eliciten el cambio desde adentro con técnicas elaborativas o desde afuera con técnicas directivas. Minuchin intenta un distingo más amplio al diferenciar tres corrientes: La "transicional", la existencial y la sistémica. La división, sin embargo, no parece tan absoluta, ya que también cuando se utilizan técnicas conductuales puede verse a través de la entrevista que la variable elaboración juega un papel fundamental.

**Un enfoque dinámico-elaborativo-interaccional.** Concebimos el cambio como producto de una elaboración interna y recíproca a la vez. El desarrollo se cumple en un marco de relación interpersonal como transformación y reestructuración continua que tiende a la formación de nuevas estructuras. Siempre se trata de una nueva creación y éste es el factor de cambio en la vivencia actual en la interacción. El *proceso terapéutico* se

caracteriza por la acción constante del proceso interaccional actual. Intervienen aquí fundamentalmente tres factores: la movilización más rápida, la vivencia actual y el nuevo intercambio en la comunicación. *La movilización más rápida* facilita la expresión abierta y la elaboración de los resortes íntimos de la interrelación. *El proceso catártico*, sin embargo, es de carácter distinto al de la terapia individual, ya que está sujeto a la vez a la retro-alimentación negativa actual. También debe tenerse presente el posible efecto desorganizante de un "acting-out" que se continúa en el grupo (Winne). *La vivencia actual* permite una nueva percepción del "otro", dando lugar a un proceso de reestructuración afectiva que se acerca a la "experiencia vivida y evidenciada" del otro (Laing). *El nuevo intercambio en la comunicación* significa: 1) una experiencia democrática en sí, en la cual la actitud del terapeuta representa un *modelo de relación* tácitamente incorporado. 2) Una percepción más clara de los mensajes contradictorios y su rectificación. 3) Esta permite expresar sentimientos y motivaciones, conscientes e inconscientes, traduciendo el *lenguaje simbólico* a un *lenguaje directo*, lo que promueve un cambio profundo hacia un nuevo equilibrio.

La trama central del proceso parece ser la modificación de los efectos acumulativos de la retro-alimentación. Cambia el *tipo de complementariedad*: se modifica la interacción simétrica y se modifica el carácter de la interacción complementaria negativa. Otro proceso importante es la *desensibilización de la interacción* (A. Speier), por el cual la toma de conciencia de problemas individuales libera de la proyección de éstos sobre la familia.

*La relación terapéutica* adquiere aquí caracteres particulares (D. Jackson, Bateson). Se establece una compleja red de relaciones afectivas que se caracteriza por la multiplicidad de los intercambios. El terapeuta debe establecer una relación no sólo con cada uno de los miembros de la familia, sino con *la familia como conjunto*. Debe comprender la "imagen de la familia" y sus necesidades implícitas, y el significado de la *interacción disfuncional*, que en cierto sentido, es funcional para la familia

que consigue así evitar la disgregación. Esta relación con la familia total no es fácil ya que el terapeuta está sometido a impactos directos y múltiples, mientras la relación adquiere un *carácter circular* donde el terapeuta puede verse incluido en cambios de alianzas, rivalidades y requerimientos alternativos. En fin, es decisivo el papel de *participante afectivo* del terapeuta (Winne, Ackermann, Bateson, Satir, Minuchin) y el valor de la *aceptación*, por la cual se neutraliza lo negativo y se acrecienta lo positivo, dentro de un proceso de reencuentro en una vivencia emocional compartida.

**Manejo terapéutico.** Se integra en un contexto terapéutico lo elaborativo vivencial con lo interaccional. Centramos la terapia en: 1) la elaboración conjunta de la interacción actual y de sus consecuencias transaccionales recíprocas en la conducta de cada uno de los miembros interactuantes. 2) En la elaboración de las motivaciones de la conducta aun en su nivel intrapsíquico pero interdependiente. 3) En la toma de conciencia de sus efectos acumulativos de cambio recíproco y sobre la estructura. La elaboración puede ser a nivel verbal o también a través de técnicas expresivas, gráficas o de juego o dramatizaciones.

El terapeuta evita los silencios iniciales, explicita aspectos del proceso interaccional, señala la importancia de la experiencia de sinceridad que la familia está dispuesta a emprender. El terapeuta estimula, por un lado, la elaboración espontánea interaccional, por el otro, interviene con señalamientos e interpretaciones. Estas se dirigen siempre a la *interacción*, interpretando la interacción complementaria y simétrica. No se excluye el esclarecimiento del juego intrapsíquico individual, pero siempre en relación a sus efectos interdependientes acumulativos y actuales. En la *comunicación* se induce a la clarificación de la discordancia entre el contenido y la relación y a la rectificación de los mensajes analógicos del "doble vínculo". Se promueve además constantemente el proceso de crecimiento y diferenciación, la clarificación de la imagen de la familia en sus niveles sociales conscientes y en sus niveles emocionales inconscientes, el descubrimiento de los *sentimientos positivos* que la lucha

cotidiana no permite percibir y de las *fuerzas positivas* de que dispone la familia.

Estos principios generales que rigen la orientación de la psicoterapia encuentran su aplicación en diversas modalidades terapéuticas cuya elección debe sopesarse en cada caso estableciendo finalidad y objetivos de la terapia, de acuerdo a las características de una determinada familia.

### Casuística

**Terapia familiar con fines diagnósticos y de objetivos limitados con una niña con conducta rebelde en una familia satisfactoria inestable.**

(Caso atendido en colaboración con la Dra. Esnea Auletta)

**Motivo de consulta:** Los padres solicitan una entrevista familiar para ser orientados en el manejo de su hija Florencia, de cinco años.

**Primera entrevista:** Padres con ambos hijos, Florencia y Guido, de dos años. Los padres expresan su preocupación porque la niña últimamente no acepta separarse de la madre para concurrir al jardín de infantes. Es agresiva y provocadora, al mismo tiempo pegoteada con los padres. Mientras tanto la niña juega en el pizarrón con el hermano, pero trata constantemente de llamar la atención, molesta, interrumpe, pelea y se excita in crescendo. Se introducen técnicas de *dibujo y juego*. En el dibujo todos intervienen, Florencia pide que se dibuje una casa con 8 primos y los abuelos. Dice: "Todos gritan". Se la induce a dibujar el grito y hace un garabato con gran fruición y descarga. Se la nota por primera vez, relajada. Los padres lo advierten. Se ofrece material lúdico. La niña toma el revólver y hace que apunta y mata a los padres y a la terapeuta. La terapeuta sigue el juego y se hace la muerta, ambos padres no saben cómo conducirse. El padre logra imitar a la terapeuta. La madre queda paralizada y angustiada ante el juego de la niña y es incapaz de tomar el revólver. Se hace el

cambio de roles de madre e hija y la madre consigue con dificultad tomar el arma.

**Interacción observada.** En la entrevista se evidencia la incapacidad de los padres de: a) poner límites frente a una niña excitada y con actitudes histriónicas. b) adoptar conductas de rodeo. La madre tiene incapacidad de soportar la agresión probablemente por motivos personales. **Manejo terapéutico:** Este tendió a integrar a la familia en una actividad que involucrara a todos sus miembros. A la descarga de emociones por parte de la niña. A un aprendizaje de los padres del juego. A la "vivencia a un nivel de como si" de situaciones ansiógenas para los padres. En base a esto se establecen los siguientes objetivos: 1) orientación a los padres en una entrevista de a dos. 2) terapia familiar sin la presencia del hermanito, con la finalidad de modificar algunos aspectos de la conducta de la niña y de la interacción familiar. 3) probable atención individual de la niña debido a ciertos rasgos de excitabilidad básica.

En la entrevista con los padres, que permite completar la información, la madre revela y elabora su problemática personal frente a la agresión y su sentimiento de culpa frente al nacimiento de la niña. Dice que la niña la "odia" y se larga a llorar por no haber ella recibido cariño de su madre. Se culpa por la cesárea tardía y toma conciencia de que esto no entraba en su responsabilidad.

En la próxima entrevista con los padres y la niña éstos refieren que Florencia ha mejorado muchísimo. Mientras la niña acapara la atención del padre, sentándose en sus rodillas o pellizcándolo o dibujando juntos, la madre comenta con entusiasmo cómo se siente más libre frente a la agresión y logra manejar con bromas las exigencias y los juegos agresivos. En esta entrevista se produce un importante insight en el padre que toma conciencia de motivos personales que le impiden poner límites ya que relaciona la agresividad entre los niños con la relación con su propio hermano menor.

**Evolución.** Se continúa con terapia individual con la niña, y

orientación a los padres con notable mejoría. Se agrega terapia familiar con los dos hermanos por la relación de agresión aún no resuelta entre ellos.

**Terapia familiar prolongada con utilización de la expresión simbólica y de la "sesión-comida" en un caso de anorexia en un niño con personalidad esquizoide con un grupo familiar satisfactorio inestable.**

(Caso atendido por la Dra. Anny Speier)

Felipe, de 8 años, es retraído e impulsivo, lento e inseguro, anoréxico, con rumiación de la comida, que retiene en la boca durante horas hasta que, licuada, se desliza por las comisuras. La terapia familiar se realiza en forma paralela a la individual durante 8 meses. Concurren los padres y los hermanos, Gastón, de 6 años, y Juanito, de 4 años. En la terapia la elaboración abarca cuatro niveles:

1) *A nivel verbal:* Felipe rectifica los mensajes indirectos de la madre y expresa profundas fantasías simbólicas que lo atormentan, por las que la madre percibe el desamparo interior del niño. En una entrevista Felipe toma la revista de Gastón y se sumerge en la lectura. La madre le exige repetidamente en tono muy duro y amenazante que devuelva la revista, hasta que Felipe acata la orden pero se desploma en una actitud apática y deprimida. Interpreto la interacción complementaria entre la exigencia de la madre y la retirada depresiva de Felipe, y señalo la reciprocidad circular. La interpretación logra de inmediato reestablecer y dinamizar el diálogo. De pronto Felipe dice: "Hoy tuve un sueño, soñé que un tigre me comía, me comía todo, la cabeza, el cuerpo, acá, los brazos, el pecho, yo no me veía más..." El relato es tan angustioso que todo el grupo queda en silencio muy impresionado. El *manejo* fue elaborado: Se pidió a todo el grupo que continuara la fantasía dramatizándola; en la misma el tigre comía a Gastón y a Juanito que gritaba asustado a Felipe que no lograba defenderse. Al final Felipe demostrando su reconciliación interior y la

nueva confianza, atribuye la defensa a la madre: ésta llegaba y vencía al tigre.

2) En la *expresión gráfica* a través del dibujo el grupo revela y elabora progresivamente en profundidad los sentimientos y experiencia interna vivencial de cada miembro de la familia y de la interacción, y el significado simbólico específico de algunos conflictos. El *manejo* fue elaborativo e interpretativo, individual e interaccional a la vez. Felipe dibuja un ladrón que ha escapado de la cárcel y ha asaltado un banco y la policía lo persigue. Lleva dos enormes bolsas, llenas de monedas de oro, y tiene una boca abierta redonda, regresiva. La madre se dibuja a sí misma descansando sola detrás de la casa, revelando ese aislamiento básico de tipo narcisista que la caracteriza en sus relaciones afectivas, logra luego en otros dibujos incorporar la pareja y los hijos. Felipe, después del sueño del tigre, llega a dibujar un niño alimentando a tres patitos, expresando así una oralidad positiva y compartida. Todos los demás miembros del grupo familiar también logran expresarse y evolucionar.

3) A *nivel conductual* se producen una serie de nuevas percepciones y ajustes. La madre percibe los problemas de los otros chicos, modera a Juanito y comienza a defender a Felipe. Gastón, "el bueno" del grupo, comienza a defender sus derechos. Felipe se hace más comprensivo con Juanito que aprende a aceptar límites.

4) A *nivel oral* la "sesión-comida" que se introdujo por las características del síntoma anoréxico, no tuvo sólo un significado específico para Felipe, sino para todos (Minuchin). Significó para todo el grupo una vivencia emocional correctiva en un nivel regresivo en la relación terapéutica y en la propia relación materna.

**Evolución.** Se modificó la interacción profunda entre la madre y Felipe, que logran vincularse en ese nivel afectivo

primario que nunca habían podido establecer. Además todo el grupo familiar mejora notablemente a través de un proceso de crecimiento y diferenciación individual e interrelacionada.

**Abordaje familiar con un adolescente con personalidad esquizoide con una familia insatisfactoria inestable de características altamente patológicas.**

(Caso atendido por la Dra. Anny Speier)

Marcelo, de 17 años, es traído a la consulta a la fuerza por un cuadro de total negativismo y retraimiento. Acepta, sin embargo, concurrir con la familia. Ya la primera entrevista permite descubrir el complejo mecanismo latente en la interacción familiar, dentro del cual, la única salida de Marcelo es el retraimiento que llega a paralizar casi toda su personalidad. La *comunicación* en la familia es altamente disfuncional. La madre se relaciona en doble vínculo, llegando a ser muy agresiva frente a la rectificación y utilizando mensajes tan contradictorios e incomprensibles, que la entrevista llega a adquirir una atmósfera de irracionalidad. Frente a esto Marcelo ha adoptado un modo de comunicación en el cual, o se calla, o niega él mismo sus propios mensajes, actitud que adopta también con la terapeuta. La madre se queja de que Marcelo perturba la tranquilidad con la radio, pero ella misma ha escondido el audífono que él ha comprado para resolver el problema, resultando imposible obtener una aclaración ya que la madre sólo se ríe en forma extraña, hasta que Marcelo se hunde de nuevo en el mutismo. El *doble vínculo* se evidencia en los mensajes contradictorios, en los cuales se le ordena a Marcelo dos cosas opuestas, acusándolo, por ejemplo, de no concurrir al club y prohibiéndoselo al mismo tiempo, resultando para Marcelo imposible rectificar el mensaje.

**Interpretación interaccional e intrapsíquica.** La interpretación de la *interacción circular* entre la incomunicación de Marcelo y las exigencias de la madre, liberan a Marcelo de su chivo-emisario. Se le señala a Marcelo que los problemas de

comunicación se dan en dos niveles. Por un lado existe una tendencia a ser más introvertido y, por otro, la interacción acentúa la tendencia. Se produce un círculo vicioso: frente a la demanda excesiva de comunicación e imposiciones permanentes que contradicen las iniciativas personales, Marcelo se encierra y cuanto más él se encierra, más se insiste del otro lado. A esto se agrega la *interpretación del significado intrapsíquico del síntoma*, como defensa frente a la situación y la *interpretación* de sus consecuencias para él mismo. La terapeuta dice: "Marcelo corta la comunicación por defensa. Para defenderse se hace el retraído. Pero, Marcelo, esto vuelve a caer sobre ti, tal vez te hayas retraído demasiado. También te has retraído de cosas buenas para ti".

**Evolución.** La madre revela una total incapacidad para comprender la situación de su hijo, debido a su estructura psicótica. El padre, si bien es más consciente, es incapaz de enfrentar a su esposa y defender a su hijo. Los padres mantienen una relación insatisfactoria inestable que logra una pseudoestabilidad en el acuerdo en contra del hijo. Marcelo resulta así el chivo emisario de la familia, lo que logra resolver a través de las entrevistas conjuntas. Los padres no modifican su actitud y Marcelo pide para sí un tratamiento individual.

**Terapia familiar prolongada con una familia con alto grado de conflicto abierto.**

(Caso atendido por el Lic. Rubén Vadagnel.)

**Composición familiar:** padre, madre y tres hijos: Marcela, de 18 años; Andrea, de 14, y Eduardo, de 12.

**Motivo de consulta:** Consultan por Eduardo, por su desconformismo, aislamiento, mal humor.

**Fundamentación de la elección de la terapia familiar.** Se realizan algunas entrevistas individuales sin resultado con Eduar-

do. En una reunión con los padres y el niño, el padre hace una crisis de llanto por el clima insoportable del hogar. Se convienen ocho reuniones de terapia familiar.

**Primera entrevista.** En esta se detecta el carácter de las interacciones y de las alianzas básicas. El clima de violencia en la comunicación, que linda con la desorganización y hace dudar de la viabilidad de la terapia, inducen al terapeuta a intervenir de inmediato en la interacción simétrica negativa y en el chivo emisario.

En la entrevista el grupo no se centra en el paciente identificado, sino en Marcela, que permanece callada frente a los ataques generales. Hasta que Marcela reacciona frente a la descalificación de la madre acusándola en forma directa por su grave rechazo.

**Marcela:** ... ¿sabe qué pasa? ... (al terapeuta) antes de venir acá mamá me dijo "no vayas a mentir". (La madre quiere aclarar y Marcela no la deja y grita.) ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ... A Eduardo siempre le dicen "querido, amoroso", y en cambio a mí ... (Sigue la discusión, Marcela se levanta de la silla, grita, la madre retruca, el padre se calla.)

**Madre:** (al terapeuta) Ella es buena con los amigos, pero conmigo no. Sabés lo que pasa ... que vos estás mal conmigo porque te las canto ... vos querés ponerme la tapa a mí. Yo siempre te las canté las cosas antes que sucedieran. ¡Vos a mí lo que querés es castigarme!

**Marcela:** (a los gritos y de pie) ¡No es cierto! ¡No es cierto! (al terapeuta): Mire, ella siempre dijo que yo era su peor castigo, que al nacer fui el peor de los castigos y eso a mí me dolió mucho. Además (a la madre), vos siempre me culpás a mí de todo. Me culpaste por el toallón y había sido Andrea (Andrea asiente).

El padre y Eduardo aparecen en un papel pasivo y relegado. El padre intenta hablar pero nadie lo escucha, hasta que lo consigue apartando con sus brazos a los que tiene a su lado. Eduardo y Andrea tratan de decir algo. El padre comienza a hablar muy rápidamente. El terapeuta se lo hace notar. El

padre contesta: "Sí, porque si no me sacan la palabra", como efectivamente ocurre. La madre vuelve a recriminar: "Nos sentimos estafados por Marcela, nunca dice la verdad", y se enciende de nuevo la discusión, en la que interviene débilmente Andrea, a la que la madre apoya. El terapeuta induce a la clarificación de la percepción recíproca, pidiendo que describan cada uno la imagen que tienen del otro, señalando también los aspectos positivos. Mientras lo hacen vuelven a discutir y el terapeuta entrega entonces una hoja a cada uno para que lo escriban y luego lo lean. Mientras Marcela se toca la cara y la madre con señas trata de impedirlo.

*Madre:* (al terapeuta) Ve, se saca los granitos y se lastima la cara al apretarse.

*Terapeuta:* ¿Cómo le gustaría a Ud. que tuviera la cara Marcela?

*Madre:* Tiene una linda cara pero mire cómo se la deja... nos quiere castigar.

*Terapeuta:* Están pidiendo a Marcela que se cuide... y ¿qué otros pedidos hay en la familia?

Los hijos se quejan de que los padres están gordos y no se visten bien. Siguen insistiendo en la ropa y el peso y el terapeuta pide detalles del tipo de ropa y arreglos para cada uno de la familia. Al finalizar el terapeuta señala que una de las características de la familia es que se ocupan silenciosamente del otro. El clima al terminar es de mayor distensión.

**Evolución.** En las sesiones siguientes Marcela deja de ser el blanco de los ataques y comienza a participar más en el hogar. Andrea sale de su pasividad y comienza a manifestar desacuerdos en forma directa. Se clarifica y modifica la interacción complementaria entre el aislamiento de Eduardo que refuerza la incertidumbre de los padres y su necesidad de protegerlo, y la dependencia de éste, que empieza a mejorar. Los chicos quedan libres del chivo emisario y aparecen muy claramente dificultades personales de los padres, a los que se recomienda terapia de pareja.

En total tuvo lugar una reestructuración de la percepción

recíproca, un cambio en el tipo de complementariedad y una desensibilización de la proyección. La familia pudo tener vivencias de relación desconocidas que favorecieron el crecimiento afectivo. Las intervenciones del terapeuta tendieron a descubrir y a estimular la elaboración de las motivaciones actuales interaccionales e individuales de los conflictos, permitir y estimular la emergencia de aspectos positivos y la diferenciación y logro de metas en cada uno.

## Resumen

Se expone un enfoque psicoterapéutico de tipo elaborativo - dinámico - interaccional.

La terapia familiar enfoca a la familia como una estructura cuyas partes son interdependientes.

Tres conceptos son esenciales en este enfoque:

1. El resultado de las relaciones personales es algo más que la suma de las personalidades en juego.
2. El concepto de retroalimentación y de sus efectos acumulativos y de modificación progresiva entre los individuos interactuantes.
3. Influencia de la interacción actual en la modificación de la conducta, que fundamenta la terapia centrada en ésta.

*Procesos de la estructura familiar.* La familia es una estructura en evolución constante, a través de procesos de complementariedad y diferenciación por los que se integra el crecimiento individual y los objetivos de la familia.

*Los procesos de la comunicación.* Constituyen la trama de la interacción en su nivel verbal y analógico y definen el significado y el valor relacional.

*Los enfoques psicoterapéuticos.* Se perfilan aquí tendencias distintas según el énfasis puesto más en la relación o en la estructura. La línea divisoria parece marcarse en el concepto del cambio, y de cómo producirlo. Beels y Herber dividen a los terapeutas en "reactores" o "conductores", según eliciten el cambio, desde adentro, con técnicas elaborativas o, desde afuera, con técnicas directivas.

*Un enfoque dinámico - elaborativo - interaccional.* Concebimos el

cambio como producto de una elaboración interna y recíproca a la vez. El desarrollo se cumple en un marco de relación interpersonal como transformación y reestructuración continua que tiende a la realización del potencial en nuevas estructuras. Siempre se trata de una nueva creación y ésta es el factor de cambio a través de la vivencia actual en la entrevista interaccional.

*El proceso y el manejo psicoterapéutico.* Integramos en un contexto psicoterapéutico lo elaborativo - vivencial con lo interaccional. Centramos la terapia en: 1. La elaboración conjunta de la interacción actual y de sus consecuencias transaccionales recíprocas en la conducta de cada uno de los miembros interactuantes. 2. En la elaboración de las motivaciones de la conducta, aún en su nivel intrapsíquico, pero siempre en su función interdependiente. 3. En la toma de conciencia de sus efectos acumulativos recíprocos y sobre la estructura.

*La relación terapéutica.* El terapeuta debe establecer una relación múltiple con cada uno de los miembros de la familia, con la familia como conjunto, con la imagen de la familia y con el significado de la interacción disfuncional. Una vivencia emocional positiva compartida, en la cual el terapeuta se convierte en un modelo de relación tácitamente incorporado, favorece el crecimiento afectivo de la familia.

*El manejo terapéutico.* El terapeuta estimula, por un lado, el proceso de elaboración espontánea interaccional, interviene, por el otro, con señalamientos e interpretaciones. Estas se dirigen siempre a la interacción (complementaria y simétrica) y a sus implicancias motivacionales interdependientes. Promueve la clarificación en la comunicación de los mensajes contradictorios y analógicos, y de doble vínculo; el crecimiento y la diferenciación; y el descubrimiento y desarrollo de las fuerzas positivas de la familia.

*Casística:* Se exponen cuatro casos que ejemplifican distintas modalidades de terapia introductoria y de objetivos limitados o prolongada, con elaboración a nivel verbal interaccional y utilización de técnicas gráficas, dramáticas y, de juego y "sesión-comida", en casos específicos.

## Summary

A psychotherapeutical approach of the elaborative - dynamic - interactional sort is set forth.

Family-therapy views family as a structure whose components are

interdependent. Within this approach, three concepts are essential:

1. The result of personal relationships as something beyond the sum of the personalities involved.
2. The concept of feedback, its accumulative effects and the progressive modification among the interacting individuals.
3. The influence of the actual interaction on the behaviour modification, upon which the therapy centered on the latter is grounded.

The process and the psychotherapeutical handling. The change is conceived as the product of an elaboration both internal and reciprocal. The development takes place within a frame of interpersonal relationship, as a continuous transformation and re-structuration tending to the carrying out of the potential towards new structures. It is always a new creation, being this the change factor through the actual life-experience of the interactional interview.

The elaborative, life-experienced and interactional aspects are integrated in one psychotherapeutical context.

The therapy is centered upon the joint elaboration of the actual intaction, its motivations and the accumulative process, within a positive therapeutical relationship which favors the affective growth of the family. The therapist stimulates the interactional process and intervenes by clearing up interaction and communication. Different family-therapy techniques are illustrated through four clinical cases.

## Bibliografía

1. ACKERMANN, W. NATHAN, *Diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares*. Ed. Hormé, Buenos Aires, 1961.
2. ACKERMANN, W. NATHAN, y otros: *Teoría y práctica de la psicoterapia familiar*. Ed. Propteo, Buenos Aires, 1970.
3. ACKERMANN, W. NATHAN: *Psicoterapia de la familia neurótica*. Ed. Hormé, Buenos Aires, 1969.
4. BATESON, G.; FERREIRA, A; JACKSON, DON D.; WEAKLAND, JOHN H.; LITZ, D; WINNE, L. C.; ZUCK, G.: *Interacción familiar*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
5. BRODEY WARREN, M.: "Proceso de cambio familiar", en: Ackermann, N. W., y otros: *Teoría y práctica de la psicoterapia familiar*. Ed. Proteo, Buenos Aires, 1970.

6. BOSZORMENYI-NAGY, IVAN, y FRANCO, L. JAMES: *Intensive Family Therapy*. Ed. Harper and Row, New York, 1965.
7. BOSZORMENYI-NAGY, IVAN: "Tipos de pseudo individuación", en: Ackermann, N. W., *Teoría y práctica de la psicoterapia familiar*, Ed. Proteo, Buenos Aires, 1970.
8. LAING, RONALD D.: *El cuestionamiento de la familia*. Ed. Paidós, Bs. Aires, 1972.
9. LAING, RONALD D.: *Experiencia y alienación en la vida contemporánea*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971.
10. MINUCHIN, SALVADOR: *Familias y terapia familiar*. Ed. Gedisa, Granica, Barcelona, 1974.
11. MINUCHIN, SALVADOR: *Psychosomatic families, Anorexia nervosa in context*. Harvard N. Press, U.S.A., 1978.
12. RECA, TELMA: *Psicología, psicopatología, psicoterapia*. Ed. Siglo XXI, México, 1973.
13. SATIR, VIRGINIA: *Conjoint Family therapy*. Ed. Science and Behavior Books, Palo Alto, California, 1968.
14. SKINNER, SUE WALROND: *Terapia Familiar*. Ed. Anesa, Buenos Aires, 1978.
15. SPEIER, ANNY: *Psicoterapia dinámica de la pareja*. Ed. Psique, Siglo XX, Buenos Aires, 1977.
16. SPEIER, ANNY: *Los procesos de simbolización en la infancia*. Ed. Proteo, Buenos Aires, 1971.
17. TERUEL, GUILLERMO: "Nuevas tendencias en el diagnóstico y tratamiento del conflicto matrimonial", en: Berenstein, J. Kalina y otros: *Psicoterapia de pareja y grupo familiar con orientación psicoanalítica*. Ed. Galerna, Buenos Aires, 1970.
18. WATZLAWICK, PAUL; BEAVIN, JANET, JACKSON DON, D.: *Teoría de la comunicación humana*. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, 1971.
19. WATZLAWICK, PAUL: "Examen de la teoría del doble vínculo", en: Jackson, Don, D. y otros: *Comunicación, familia y matrimonio*. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.
20. WINNE, LYMAN C.: "Indicaciones y contraindicaciones de la terapia familiar exploratoria", en: Bateson, G. y otros: *Interacción familiar*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.

---

## Trastornos del sueño en la primera infancia

---

Lic. HAYDEE M. C. DE TORONCHIK

---

Mansilla 338, P.B., "C", Capital Federal

---

Es frecuente la consulta por niños de corta edad, que padecen trastornos de sueño. Estos varían entre las dificultades para dormirse, despertares en distintos momentos de la noche, sueño invertido, pesadillas, terrores nocturnos y pasaje a la cama de los padres. Deseo referirme en este trabajo a la experiencia realizada con doce niños menores de un año y medio.

La problemática de todos ellos se centraba en dificultades para iniciar el sueño, rechazo a la cuna y despertares durante la noche. Coincidían también en ser todos primogénitos de parejas jóvenes —entre los 22 y los 30 años—. Las criaturas no presentaban ningún trastorno orgánico, ni otro tipo de síntomas psicológicos. Los padres habían puesto en práctica distintas conductas, pero se sentían impotentes para manejar el síntoma.

La técnica utilizada fue la de entrevista con los padres, y sólo en 5 casos fue tomado el grupo familiar. Las primeras entrevistas se dedicaban a recabar los datos de la historia del niño —embarazo, parto, evolución en la conducta, característi-

cas personales, etc.—, la descripción del síntoma, y una breve historia de los padres antes de casarse, y luego en tanto pareja.

En los casos de entrevista con el niño, se colocaron juguetes apropiados para su edad. La consigna a los padres fue de tipo amplia: hacer lo que desearan. Mi tarea fue la de observadora, aceptando, además, las propuestas de la familia. En todos los casos el niño me hacía participar de algún modo en su juego, una vez pasado el tiempo de reconocimiento.

Luego de estudiar el material, mantenía entrevistas con los padres para elaborar ciertos conflictos e instrumentar algunas estrategias. La cantidad de entrevistas varió en función de la problemática, pero en ningún caso pasó de 6. Al ceder el síntoma generalmente dábamos por terminadas las entrevistas, y nos poníamos en contacto tres meses más tarde para comprobar si la mejoría se mantenía o no. De los doce casos que nos interesan, sólo *dos* persistieron en el síntoma, si bien mucho más atenuado. Las recaídas que registramos, fueron breves, y coincidentes siempre con enfermedades o con situaciones familiares tensas o difíciles.

### Los padres

Del estudio de estas doce familias podríamos extraer algunos denominadores comunes. Si bien los padres podrían tener individualmente características y personalidades diferentes y diversos conflictos, todos pasaban, en época de la consulta, por situaciones de crisis en tanto individuos y en tanto parejas.

El nacimiento del hijo, aun en las parejas que lo deseaban, había traído una ruptura en un estilo de relación, y no habían podido organizar uno nuevo adecuado para la integración del nuevo miembro.

Los padres parecían ser niños abandonados, resentidos, ambivalentes y con intensos sentimientos de culpabilidad. En ciertos casos, reeditaban síntomas que habían padecido en la infancia, a veces relacionados con el nacimiento de algún hermano (alergia, colitis, jaquecas).

Las mamás mostraban una imposibilidad de separarse de su hijo, su actitud era contradictoria: momentos de mucha ansie-

dad, fastidio y rechazo, alternaban con momentos de mucha ternura.

Los papás se sentían excluidos, tanto de la relación madre-hijo, como de sus esposas como compañeras. Reaccionaban con rabia, abandonando toda posibilidad de intervención.

En todos los casos se presentaban, además, problemas en las relaciones sexuales. En algunos casos leves —menor frecuencia—, pero en otros se llegaba a disfunciones serias, como por ejemplo, el cese de las relaciones aun después de seis meses del nacimiento del bebé.

En las fantasías paternas, el niño aparecía como una imagen sumamente persecutoria, prohibidora o envidiosa de las relaciones sexuales u otras actividades adultas. Los padres elaboraban explicaciones tales como "Pobre. ¿Cómo voy a dejarlo solo cuando nosotros estamos juntos?", o bien: "Cuando apago la luz me parece que el nene está en la habitación y nos mira".

La reedición de la problemática edípica, y aun anterior, transformaba a estos padres en niños impotentes. Recordemos que antes del nacimiento del niño, estas parejas no presentaban problemas evidentes.

El tipo de contrato matrimonial estaba basado en un pacto complementario, en el que cada uno representaba un padre protector para el otro. Satisfacían aún sus necesidades de ser cuidados y amados con exclusividad.

En ellos, el proyecto de tener un hijo estaba basado en fantasías idealizadas: el bebé hermoso que iba a reafirmar o mejorar su autoestima. Así, pasado el primer momento de manía frente al nacimiento, descubrían con asombro que la crianza de un hijo significaba un cambio de vida, renunciando y reajustes. Se sentían defraudados y con odio, sentimiento que les resultaba muy difícil de aceptar.

Con esta situación emocional, era imposible que la mamá tuviera la capacidad de ser continente del bebé. Más bien lo estimulaba exageradamente, sin poder adaptarse a las necesidades de su hijo, ni ponerle los límites adecuados. El padre, a su vez, no cumplía la función de contener la ansiedad de la madre ni de sostener a la pareja madre-hijo permitiendo la simbiosis

HAYDEE M. C. DE TORONCHIK

necesaria, luego al apartarse o competir celoso, ser un factor de separación y modelo de otras identificaciones.

### Tipo de trabajo realizado

En las entrevistas se realizaron:

1) Señalamientos que ponían de relieve la afinidad de las conductas actuales con situaciones infantiles no resueltas. Esto tendía a discriminar al bebé y a la pareja de proyecciones de figuras arcaicas.

2) Esclarecimiento del contrato matrimonial anterior al nacimiento del bebé. Duelo por algunos aspectos perdidos del primer momento del matrimonio.

3) Proyecto de un nuevo contrato más adecuado a las funciones actuales que como pareja debían abordar: relaciones sexuales, sociales, aspiraciones, gratificaciones, renunciadas.

4) Revisión de la idealización del hijo. Aceptación de la ambivalencia que provoca la crianza. El odio como sentimiento necesario y útil.

5) Reordenamiento de la vida del bebé adecuado a su edad y estilo personal en relación a posibilidades y características de los padres.

Lo ejemplificaré a través de uno de los casos.

### Gastón, 8 meses

Los padres consultan por Gastón, que desde que nació presenta problemas de sueño. Los dos primeros meses de vida, el bebé se despertaba cada tres horas durante el día y la noche. Luego comenzó a dormir muy poco durante el día, despertándose tres o cuatro veces por la noche. "No había forma de calmarlo", relatan los padres y describen su rechazo por la cuna, que concluía con hacerlo dormir en la cama de los padres.

En general Gastón es descrito como un niño sano, activo, que juega y es afectuoso. Al atardecer, sin embargo, comienza a ponerse irritable, y resulta difícil manejarlo.

Ambos padres son profesionales. Están casados hace tres años. El padre es el hijo mayor, y tiene un hermano al que le lleva tres años. La madre es la hija del "medio", con un hermano dos años menor y una hermana cuatro años mayor. El padre relata una infancia y una adolescencia poco conflictuada, salvo por una relación —muy difícil— con su hermano. Aparentemente, logró una independencia sumamente temprana con respecto a sus padres, a quienes desvaloriza mucho: "Trato de que vengan poco a casa. No como mi hermano que todavía depende de ellos para todo".

La madre se describe a sí misma como "la nena buena" entre dos hermanos muy rebeldes. Pinta a sus padres como una muy buena pareja, siempre como novios, aunque menos preocupados por los hijos que por ellos. No pide colaboración de la madre, porque ella siempre "se las arregló sola".

Se conocieron hace seis años siendo estudiantes. El venía de una relación muy frustrante, y estaba muy deprimido. Ella se sentía muy sola, le resultaba difícil hacerse de amigos. Muy estudiosa se "refugiaba en la biblioteca". Ella lo ayudó a recobrarse en el estudio y también en el afecto. Es muy cariñosa. El aportó sus amistades y la ayudó a vencer sus temores sociales.

Se constituyeron como una pareja muy unida, que pasaba todo el tiempo posible junta, trabajando en un mismo estudio y realizando las mismas tareas extraprofesionales.

Planearon el embarazo con entusiasmo. El nombre del hijo se pensó en función de una novela, cuyo personaje se destaca por su inteligencia y bondad, que le permite *salvar* a un pueblo que atraviesa una situación caótica.

Dos semanas después del nacimiento, el esposo se reintegró al trabajo. La madre, luego de haber decidido dejar de trabajar por tres meses, y quedarse sola en casa, pidió expresamente a las abuelas que *no* la acompañaran. Sin embargo, a las pocas horas, comenzó con una crisis de angustia muy intensa. El bebé lloraba y ella "no podía calmarlo". Finalmente llamó a su esposo, cuyo regreso la calmó, pero al repetirse los episodios, éste comenzó a irritarse.

Por su parte el esposo se sentía mal: al estar en casa la sensación era de que su esposa "no terminaba nunca con el bebé", y él quedaba postergado. Comenzaron a tener peleas, y las relaciones sexuales se tornaron esporádicas y poco satisfactorias.

Además, no reanudaban ninguna de las actividades que les brindaban placer —conciertos, vida social, etc.—. Todo giraba alrededor del cuidado del nene y el cansancio que su síntoma les producía.

Al revisar la vida diaria del bebé resaltaba una falta de organización: la ausencia de horarios de comida, paseos o de sueño. Al anochecer, cuando regresa el papá, el bebé se pone muy irritado, y los juegos que éste le propone, aunque al comienzo gratos, parecen excitarlo aún más. Es llamativo que el dormitorio del bebé nunca es usado durante el día. Su vida transcurre en el living, y cuando está el papá en el dormitorio de los padres.

### Labor terapéutica

La labor terapéutica consistió en entrevistas con los padres donde se esclareció la relación de pareja anterior al nacimiento de Gastón. Se hizo consciente el contrato de complementación y satisfacción de las necesidades infantiles: lo que les pareció una prueba de madurez e independencia pasó a revelarles todos sus conflictos no resueltos de celos y dependencia.

Aparentemente estos padres habían sentido el matrimonio como una evasión de las situaciones de exclusión de la pareja de sus padres, rivalidad con los hermanos. Pero el nacimiento de Gastón rompe esta ilusión.

En esta familia no había un lugar para el bebé diferenciado de los padres. Todos eran niños frustrados compitiendo por amor y compañía.

Desde esta regresión los padres se identifican con el niño masivamente, interpretando con envidia y rabia los logros adultos (vida sexual, logros sociales, vida adulta en general). Sienten culpable o persecutoriamente al bebé, se inhiben y

confunden. Parte de la sexualidad se satisface en una erogenización exagerada hacia el niño.

El horario de sueño nocturno es un aprendizaje de una norma social así como el lugar donde se duerme. Está relacionado con la capacidad de poner límites adecuados.

De la adaptación plena a las necesidades del recién nacido —importante para crear su capacidad de omnipotencia— nace poco a poco otra tarea parental que es la de ir desilusionando al bebé.

Estos padres fracasaron en las dos tareas: ni podían establecer un primer momento de tranquila ensoñación y contención, ni podían pasar a un segundo momento de límites necesarios, ya que sentían a éstos como agresiones.

¿Qué pasa entonces con ese niño tan idealizado desde el nombre que le eligen?

Más que a salvar viene a destruir fantasías. Desde la madre no es el hijo de las fantasías infantiles, ya que no es ni del padre ni del hermano. Desde el padre no nació de su vientre sino de una mujer. Para ambos además replantea la triangularidad y por ende la exclusión.

Así, el hijo idealizado del embarazo se transformó en un niño real que ocasionaba problemas y producía odio. Elaborar los sentimientos penosos que todo hijo produce, pero aún más cuando las fantasías depositadas en él son demasiado lejanas a la realidad, fue una de las tareas más arduas. Pero a partir de este momento, aceptada la ambivalencia, disminuyó la culpa y pudieron comenzar a relacionarse mejor.

Comenzaron a establecer modelos de manejo: horarios más o menos fijos, paseos adecuados, uso del dormitorio del bebé, juegos en su cuna, tareas tranquilas en las últimas horas del día.

La disminución de la culpa también obró sobre las posibilidades de dejarlo durante algunas horas con una niñera o con los abuelos, permitiendo que ellos retomaran algunas de sus actividades sociales.

Poco a poco elaboraron un nuevo contrato matrimonial, donde los roles estaban más diferenciados. El rol-mamá y el rol-papá se relacionaron con las necesidades del bebé, y no tanto

con las infantiles de los padres. Pudieron volver a sus propios padres a pedir ayuda sin sentirse infantilizados. Las relaciones sexuales se normalizaron.

### Conclusiones

Partimos del concepto de Winnicott de *preocupación materna primaria*, como un estado de *enfermedad* necesaria, de *sensibilización* que le permite una *adaptación delicada* a las necesidades del recién nacido, enfermedad de la que irá *recuperándose lentamente*, pero que sólo se da en *madres sanas*.

La realización de esta regresión *normal*, requiere de una evolución de los conflictos infantiles, un yo maduro, un ideal del yo que haya suplantado al yo ideal narcisista.

Los procesos maternos inadecuados producen ansiedades de aniquilamiento en el bebé. Ante esto, la tarea paterna es la de ser, en primera instancia, "madre" de la esposa, continente de ésta durante la primera etapa, para luego intervenir en la separación normal, por medio de su autoridad.

Proponerse como modelo de identificación alternativo al de la madre, conectar con el afuera, alentar la conducta motriz y la socialización, también esto es el resultado de una maduración adecuada.

Los casos estudiados no representaban fracasos absolutos, sino sólo parciales dentro de este proceso tan delicado. La crisis de crecimiento había puesto en evidencia fallas que desbordaban la capacidad de elaboración de sus miembros.

A esto se sumaba un alto nivel de ansiedad, donde el uso de mecanismos inadecuados impedía al bebé encontrar un lugar —no excitante— en donde reposar.

La función de una familia normal o suficientemente buena es la de aquella estructura que permite la identidad de sus miembros, y permite cumplir los procesos de crecimiento y las gratificaciones necesarias.

\* \* \*

Queda por preguntarse cuál es el lugar del terapeuta. La

impresión es tal vez, la de haber dado un marco terapéutico donde se unían las características de una madre y un padre.

Dicho de una manera quizás enunciativa, contener ansiedades, acompañar la regresión, dar tiempo para recuperar los aspectos más adultos, poner límites, y orden.

### Bibliografía

- WINNICOTT, D. W. *Escritos de pediatría y psicoanálisis. Realidad y juego.*  
CLIFFORD SAGER. *Contrato matrimonial y terapia de pareja.*  
BOSZORMENGY-NAGY, I., FRAMO, J. *Terapia familiar intensiva.*

Me propongo examinar en este trabajo algunas de las áreas conceptuales en las que el psicoanálisis y la terapia familiar pueden iluminarse y fecundarse mutuamente. Creo que para quienes como yo hemos llegado al campo de la terapia familiar desde el psicoanálisis, se trata de algo más que de una cuestión meramente académica. El problema nos sacude en nuestra identidad como psicoanalistas y nos obliga a un replanteo de nuestros esquemas referenciales básicos. La experiencia de haber tratado alguna vez una familia con un miembro psicótico —en especial si éste es un esquizofrénico— es de una fuerza tal, de un tan notable impacto emocional, que después de la misma no podemos ni ser los mismos de antes ni seguir conceptualizando nuestros hallazgos clínicos del mismo modo en que lo hacíamos. Para el psicoanalista habituado a complacientes pacientes de diván, libremente asociativos y horizontales, se trata poco menos que de una revolución. Y es muy difícil que la misma no deje huellas profundas en su técnica, sus teorizaciones y su práctica clínica.

La asimilación de una experiencia nueva implica revisar las hipótesis y teorías sobre las que basamos nuestro quehacer terapéutico, en la medida en que las mismas arrojan luz —o sombras— sobre el campo que estamos estudiando. Hay hipótesis que se alistan del lado de la esperanza y otras que racionalizan prejuicios o preconceptos ideológicos bajo un disfraz científico. Esto parece ser particularmente notorio en el caso de las enfermedades mentales, y sobre todo en el de la esquizofrenia. La creencia en la posesión demoníaca condujo al exorcismo y a la quema de los posesos en la hoguera. La hipótesis en apariencia más científica de la localización cerebral o el trastorno metabólico como causas de la esquizofrenia llevó a hogueras menos espectaculares pero igualmente despiadadas para quienes tuvieron que soportarlas: la lobotomía, el electroshock, la insulina o el metrazol. “Las creencias de Jung y Bleuler —dice Lidz— de que las perturbaciones psicológicas que estaban describiendo eran secundarias a un trastorno tóxico, y la idea de Freud de que la fijación narcisística y la regresión del paciente esquizofrénico hacían imposible una relación transferencial convencieron a muchos psicoanalistas de que estos pacientes estaban más allá de su alcance. Incluso, cuando Sullivan, Fromm-Reichmann y Hill demostraron que las relaciones transferenciales eran posibles, muchos otros analistas se mostraron escépticos y derogatorios porque el hecho iba contra dogmas aceptados”. Los avatares de estas teorías y de los campos terapéuticos que alentaron o entorpecieron deberían hacernos reflexionar acerca de los alcances de nuestros modelos conceptuales. Así, si tomamos un fenómeno típico de la esquizofrenia como el delirio o la alucinación, por ejemplo, ¿lo caracterizaremos del mismo modo o —lo que es más importante— procederemos de igual manera si suponemos que se trata de una mera producción bizarra debida a una intoxicación cerebral, que si lo describimos como la externalización de una situación persecutoria basada en una mala relación original con el pecho (un pecho convertido en malo por la preponderancia de un fuerte instinto de muerte o de una elevada dosis de envidia primaria), o que si consideramos el fenómeno como una

reacción frente a un mensaje de doble vínculo ante el cual el paciente (la víctima, como diría Bateson) no puede escapar?

En el primer caso, sólo nos queda recurrir a la modificación por electricidad o a la ablación por lobotomía del órgano enfermo. En el segundo, deberíamos llevar al paciente a una situación altamente regresiva en la que pudiese reproducir —y comprender— en un contexto transferencial las vicisitudes de su relación con el objeto primario. Cito a Rosenfeld: “En nuestra aproximación a la esquizofrenia retenemos los rasgos esenciales del psicoanálisis: es decir, las interpretaciones detalladas de las transferencias positiva y negativa sin el uso de medidas educativas o de reaseguramiento; el reconocimiento y la interpretación del material inconsciente del paciente; y, por sobre todo, la concentración de las interpretaciones sobre las ansiedades manifiestas y latentes del paciente. Se ha encontrado que las manifestaciones psicóticas se vinculan con la transferencia tanto en los estados agudos como crónicos, de modo que se desarrolla lo que uno podría llamar una “psicosis de transferencia”. La principal tarea del analista tanto en las esquizofrenias agudas como crónicas es el reconocimiento del relevante fenómeno transferencial y su comunicación al paciente”.

Un familiólogo, por su parte, podría considerar ciertos elementos delirantes como un mensaje cifrado en el cual el paciente estaría expresando que siente que le incumbe la misión (¿impuesta por la familia?, ¿autoasumida?) de unir a sus padres en conflicto o en abierta oposición.

Frente a un paciente esquizofrénico que alterna en comportamientos de proximidad y rechazo, un psicoanalista podría interpretarlos como la expresión del temor a quedar atrapado dentro de él. Un familiólogo, en cambio, señalaría tal vez aquí la respuesta frente a un mensaje de doble vínculo de una madre que atrae a su hijo con conductas seductoras y lo aleja cuando éste se aproxima, calificando al mismo tiempo como condenables tanto su apartamiento como su intento de acercarse. Frente a este conflicto insoluble la reacción puede ser un estallido psicótico que no alcanzaríamos a entender con el instrumental psicoanalítico habitual.

He hecho mención de la teoría del doble vínculo que seguramente todos ustedes conocen bien. Lo que tal vez no se destaque suficientemente es que se fundamenta en la teoría de los tipos lógicos de Bertrand Russell. Digo esto para recordar que los familiólogos emplean una serie de modelos —comunicacionales, cibernéticos, etc.— que poco tienen que ver con aquéllos a los cuales están tradicionalmente acostumbrados los psicoanalistas o por lo menos con los que consideran fundantes de su disciplina. Un psicoanalista se basa en la existencia de fenómenos inconscientes que procura develar mediante una técnica muy específica y rigurosa. Su campo de estudio está constituido por los sueños, los síntomas, los actos fallidos. El analista los observa en un campo bipersonal y en el contexto de un fenómeno de repetición del pasado que se denomina transferencia. Su instrumento privilegiado es la interpretación y su objetivo el “insight”. El terapeuta de familia, en cambio, se mueve en el campo observacional de las relaciones familiares, en el que se propone describir y revelar la naturaleza de la trama que las sustenta y de las transacciones que la hacen posible. Señala interacciones. Prescinde —o puede prescindir— de las interpretaciones transferenciales. Puede no importarle el “insight”. Y en cuanto al inconsciente, veremos en qué medida y con qué sentido puede incorporarse la noción de inconsciente al modelo conceptual del terapeuta de familia.

¿Qué posibilidades habrá entonces de encontrar un modelo común que dé cuenta de los hallazgos psicoanalíticos y de los de la terapia familiar y permita una articulación entre ambas prácticas? El problema ha interesado más a los psicoanalistas dedicados a la familiología que a los familiólogos provenientes de otros campos. Entre nosotros ha sido tema de reflexión de algunos analistas y hay interesantes trabajos al respecto de Liendo, Picollo, Berenstein, García Badaracco, para citar sólo algunos de los más conocidos. También a algunos psicoanalistas de la escuela americana les ha preocupado la cuestión. Mencionaré entre otros a Stierlin, Anthony, Lidz, Boszormenyi-Nagy, Roger y Edward Shapiro, etc. Pero se me ocurre que para los americanos la búsqueda de un modelo conceptual

común es menos complicada que para nosotros porque están habituados a un tipo de teorización y de práctica en las que el individuo aparece más condicionado por las influencias de su ambiente (familia, cultura, sociedad).

Un modelo psicoanalítico válido para el estudio de los fenómenos psicopatológicos en el sujeto aislado y en un contexto familiar debería partir del reconocimiento de la existencia de un nivel inconsciente. Así lo hace Picollo, quien habla de un *nivel de inconsciente familiar operativo*, distinto del nivel de inconsciente ligado a las patologías individuales. El nivel de inconsciente familiar operativo se vincularía con los modelos comunicacionales que la familia utiliza para relacionarse. No sería un inconsciente colectivo o grupal sino una dinámica grupal relacional que permanece inconsciente para todos y cada uno de los miembros.

Para Stierlin, “lo primordial tiene que ver con mecanismos invisibles y, en gran parte, inconscientes: mecanismos que, en el psicoanálisis, se nos presentan sobre todo en forma de conflictos y defensas intrapsíquicos y en la dinámica familiar como mitos familiares, como procesos de delegación, de una invisible vinculación a un modo peculiar de lealtad, de un enmarañamiento recíproco hecho a base de vergüenza y culpa”.

Basándose en un modelo que denomina “psicoanalítico-estructural”, Berenstein postula la existencia de “una estructura familiar inconsciente” que define como “un operador a través del cual se generan significaciones provenientes de la cultura”. “La estructura familiar inconsciente contiene el significado, el orden, el sentido y es un objeto en sí mismo, distinto de los sujetos que lo forman. Estos son elementos o signos dentro de su sistema. Considerar la estructura nos torna comprensibles las relaciones aparentemente incomprensibles, dispares y a menudo opuestas de los integrantes, aparentemente incoherentes si no se las considera en su conjunto /.../ Un terapeuta de familia iría a las relaciones familiares, desde las interacciones familiares a la estructura familiar inconsciente”.

Un modelo psicoanalítico realmente abarcativo, debería

ayudarnos a esclarecer el significado de una manifestación patológica tanto en el contexto de una estructura familiar como en el de una sesión psicoanalítica con un paciente individual. Creo que en este sentido la hipótesis de un "inconsciente familiar" —operativo o estructural, tramado por mitos, secretos y lealtades, tejido por modos de comunicación distorsionados y distorsionantes— es sumamente útil para comprender mejor la familia interna del paciente y el papel que éste nos adjudica. Un síntoma cobra otro relieve si además de esclarecer el conflicto individual que busca expresarse mediante esta formación de compromiso lo entendemos como una reacción frente a una situación de doble vínculo, de lealtad, de ruptura de un pacto o denuncia de un secreto de familia. Las dudas frente a la propia identidad —sexual, profesional, generacional— se esclarecen muchas veces cuando entendemos que la búsqueda de una identidad propia significa un desafío a la identidad delineada desde los padres. En resumen, las construcciones que sobre su propio pasado hacemos a los pacientes se enriquecen cuando podemos mostrarles el sentido del lugar que ocupan desde la perspectiva de una trama multigeneracional en la que este "inconsciente familiar" tiene una dominancia tan fundamental como el del propio sujeto en la determinación de su destino.

Un trabajo de articulación minucioso requeriría revisar y visitar algunos conceptos psicoanalíticos fundamentales y estudiar su posible correspondencia con ciertas hipótesis caras a los familiólogos. Enumero al azar y sin mayor afán de rigurosidad científica: simbiosis y pseudo-mutualidad, principio de constancia (o compulsión a la repetición) y homeostasis familiar, novela familiar y mito, posición esquizo-paranoide (o confusional) y doble vínculo, etc. A su vez la problemática edípica, estudiada en el campo familiar, se carga de nuevos significados si —como lo propone Devereux— incorporamos a la leyenda clásica de Edipo recogida por Freud los mitos complementarios referentes a Layo (su homosexualidad, la maldición que recayó sobre él por violar a Crisipo hijo del Rey Pelops, etc.) que le confieren una dimensión multigeneracional.

Por último, quiero subrayar cómo dos conceptos psicoanalíticos básicos sumamente útiles para el trabajo con familias —el de duelo y el de identificación proyectiva— se colorean con otra tonalidad cuando se los examina en el contexto de las articulaciones que hemos descripto. Como ustedes saben, la identificación proyectiva es un término creado por Melanie Klein para designar un mecanismo basado en fantasías mediante las cuales el sujeto introduce su propia persona (su self) en parte o en totalidad en el interior del objeto para agredirlo, poseerlo y controlarlo. En su descripción original se trata de un mecanismo de acción unidireccional que va desde el bebé al interior del cuerpo de la madre. Pero algunos familiólogos de extracción psicoanalítica (Zinner y Shapiro sobre todo) lo utilizan en sentido amplio y lo convierten en un mecanismo de doble vía que circula tanto de los hijos hacia los padres como de éstos hacia los primeros. En este último caso estaría al servicio de lo que dichos autores llaman "delineación defensiva" y que coincide en esencia con lo que Laing caracterizó como "mistificación": la definición de los actos y personalidad del "miembro más débil" hecha desde la perspectiva del más fuerte con el objeto de controlarlo, poseerlo y depositar en él aspectos rechazados o idealizados.

En cuanto a los duelos, el trabajo con familias muestra que muy frecuentemente ante la pérdida de un ser querido se niega su muerte y se escoge a otro miembro para intentar reemplazar y revivir al ausente. Este miembro designado para corporizar un fantasma pagará el precio de tan pesada carga bajo la forma de una patología psicótica. La terapia familiar señalará el papel que cada uno juega en el tramado de esta fantasía de resurrección. Y el psicoanalista podrá agregar una nueva dimensión a su comprensión de la noción de duelo descripto por Freud cuando lo examine bajo la luz de este mandato familiar.

## Resumen

Este trabajo se propone indagar acerca de las articulaciones posibles entre psicoanálisis y terapia familiar. Examina algunos de los modelos propuestos y señala que los mismos tienen en común la idea de lo que podría llamarse un "inconsciente familiar". El mismo operaría como una suerte de estructura básica que daría cuenta de las transacciones y modos de comunicación del grupo familiar. Está tramado por los mitos, las alianzas, los secretos, las expectativas, las delineaciones mutuas que los miembros de una familia comparten sin saberlo. Este modelo permitiría no sólo una mejor comprensión de la patología en el contexto familiar sino también de la del paciente en análisis. Ambas prácticas se fecundarían así mutuamente.

## Summary

This paper proposes to investigate the possible articulations between psychoanalysis and family therapy. It examines some of the models proposed and points out that these share the idea of what might be called a "family unconscious". This idea would operate as a kind of basic structure which would account for the transactions and communication modes of the family group. It is woven of the myths, alliances, secrets, expectations, and mutual delineations shared by the family members without their knowledge. This model would permit not only a better understanding of pathology in the family context but also that of the patient in analysis. Thus, both practices would mutually enrich each other.

## Bibliografía

- ANTHONY, J.: The Contagious Subculture of Psychosis. En C. J. Sager y H. S. Kaplan (eds.) *Progress in Group and Family Therapy*, Brunner/Mazel Publishers, Nueva York, 1972.
- BERENSTEIN, I.: Aportación al Panel sobre Terapia Familiar, VIII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1980.

- DEVEREUX, G.: Why Oedipus killed Laius - A note on the Complementary Oedipus Complex in Greek Drama. *Int. J. Psycho-Anal.*, Vol. XXXIV, 1953.
- GARCIA BADARACCO, J.: Integración del Psicoanálisis Individual y la Terapia Familiar en el Proceso Terapéutico del Paciente Psicótico, *Rev. de Psicoanálisis*, T. XXXV, N° 3, 1978.
- LAING, R.: On Mystification. En Boszormenyi-Nagy, I. y Framo J. L. (eds.) *Intensive Family Therapy, Theoretical and Practical Aspects*, Harper and Row, Nueva York, 1965 (hay traducción española).
- LIDZ, T.: The Influence of Family Studies on the Treatment of Schizophrenia. En C. J. Sager y H. S. Kaplan, *ob. cit.*, 1972.
- PICOLLO, A. M. y col.: Psicoterapia de la Familia. *Rev. de Psicoanálisis*, T. XXXV, n° 3, 1978.
- ROSENFELD, H.: Notes on the Psychopathology and Psychoanalytic Treatment of Schizophrenia. En *Psychotic States, A Psychoanalytical Approach*, The Hogarth Press, Londres, 1965 (Hay traducción española).
- STIERLIN, H.: *Psicoanálisis y Terapia de Familia*, Icaria Editorial S.A., Barcelona, 1979.
- ZIMMERMAN, E. y KUTEN, J.: Patología Familiar y Esquizofrenia. Un caso Clínico. En *Patología y Terapéutica del Grupo Familiar*. Editorial Acta, Buenos Aires, 1970.
- ZINNER, J. y SHAPIRO, R.: Projective Identification as a Mode of Perception and Behaviour in Families of Adolescents, *Int. J. Psycho-Anal.*, Vol. 53, 1972.

---

1er. Premio del Concurso Terapia Familiar 1981

---

Comprensión y tratamiento interaccional del alcoholismo. La familia alcohólica.\*

---

Dr. MARIO TISMINETZKY\*\* y Lic. DANIEL FRANKEL\*\*\*

---

*\* Este trabajo fue realizado con la colaboración del Lic. en Filosofía Enrique Bein, quien se ha desempeñado en la revisión del mismo.*

*\*\* Médico psiquiatra. Director del Centro de Salud Mental de San Justo, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Director del Instituto de Docencia y Asistencia Psicológica (I.D.A.P.). Integrante del grupo interdisciplinario de investigación sobre alcoholismo del C.S.M. de San Justo. Miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Constituyentes 834, 1708 Morón, Pcia. de Buenos Aires.*

*\*\*\* Licenciado en Sociología. Profesor Adjunto de la Cátedra "Aspectos Psicosociales en el Trabajo con Familias", Carrera de Sociología, U.B.A. Becario de la Dirección Nacional de Salud Mental y CONICET para el Plan Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Investigador del equipo interdisciplinario sobre alcoholismo del C.S.M. de San Justo. Integrante del equipo de familia del C.S.M. de San Justo. Miguel Cané 2627, 1754 Villa Luzuriaga, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires.*

---

*Las causas causan  
que las causas causen las causas*  
Anthony Wilden

### Introducción

Las explicaciones incompletas que resultan tanto de las teorías psiquiátricas o psicológicas que hacen hincapié en la adaptación-desadaptación del individuo al medio, como las que resultan de las teorías sociológicas que apuntan a la influencia de características socioeconómicas deficitarias que coadyuvan poderosamente en la formación de sociopatías graves, no pudieron dar al trabajo clínico el material necesario para orientar el tratamiento del alcoholismo. En ese sentido, la

aproximación al problema desde la óptica sistémica, constituye un intento de salida a partir de un nuevo modelo, que en el fondo sintetiza ambas vertientes y que construye, por lo tanto, un nuevo objeto de conocimiento a saber: la familia en interacción dinámica con su entorno el que al mismo tiempo orienta a sus miembros socializándolos.

En este contexto, claro está, las razones etiopatológicas de la enfermedad —predisposición orgánica o psicológica del individuo alcohólico— revestirán únicamente un interés secundario.

### Fundamentos teóricos para el análisis de la familia alcohólica

Utilizaremos en este trabajo una serie de conceptos que, a fin de evitar equívocos y de otorgarle mayor claridad, describimos a continuación:

a) Pautas de *conducta* para una adaptación creativa y activa a la realidad son las que desarrollan las personas, internalizando y sintetizando una amplia gama de estímulos, manteniendo a la vez un equilibrio dinámico con el medio.

b) Pautas de conducta *pasivas*: son producidas por personas cuya relación conduce a escasa relación con el entorno. Se caracterizan por su rigidez y por su estereotipia. En el seno de una familia conducen a formar un sistema rígido y cerrado.

c) *Ciclo de vida* o historia de vida; es la sucesión de una serie de etapas, caracterizadas cada una de ellas por un cambio significativo, que forma en conjunto el período de vida de una familia.

d) *Relación simétrica*: es aquella en la que los cónyuges se comportan como si tuvieran igual status. Define una relación de competencia donde cada uno intenta manejar la misma área de competencia.

e) *Relación complementaria*: es aquella en la que los cónyuges se ayudan y colaboran mutuamente asumiendo alternadamente el rol de dador y receptor. Existe libertad en definir áreas de influencia y cada cónyuge respeta áreas del otro.

f) *Sistema familiar aglutinado*: es aquel en el cual los límites entre los sub-sistemas son tan débiles que no permiten

una clara diferenciación entre ellos, por ejemplo padres e hijos no desarrollan experiencias individuales por miedo a perder su identidad.

### La familia alcohólica

El síntoma alcohólico aparece como resultado del alto nivel de conflicto familiar que se incrementa por una limitada relación con el entorno, lo que a su vez condiciona la aparición de conductas estereotipadas. El sistema familiar así estructurado tiende a ser rígido y cerrado. El uso del alcohol juega día a día una conducta crítica de rol tal que se convierte en un motivo central de organización alrededor del cual pueden ser ordenadas las reglas y normas del grupo. En ese sentido los aspectos más importantes de la conducta están afectados por el estilo y las consecuencias del uso del alcohol. La familia pasa alternativamente por dos distintos estados interaccionales, uno asociado con la sobriedad y el otro con la intoxicación. Así el alcoholismo aparece valorado sintomáticamente cuando surgen dificultades familiares en el manejo de las distintas crisis normales de su ciclo de vida<sup>1</sup>. Una familia, por ejemplo, puede pasar por largos o breves períodos de abstinencia/intoxicación asociadas a las conductas bebedoras de uno o quizás dos de sus miembros. La dificultad radica en observar la poderosa significación interaccional del alcoholismo en contraposición a la tendencia habitual de señalar únicamente la conducta del miembro que ingiere. Hemos observado que la pareja conyugal de las familias alcohólicas atendidas en nuestro Centro, al

<sup>1</sup> La falta de habilidad de manejar satisfactoriamente las tareas asociadas a una etapa del ciclo de vida, comprometerá los recursos familiares en la etapa siguiente. La aparición de los síntomas psiquiátricos u orgánicos se da cuando este proceso se perturba. Según *Milton Erikson*, los síntomas aparecen cuando la familia encuentra dificultades para superar una etapa del ciclo de vida. Es necesario poner en marcha el ciclo atascado causado por una situación crítica que la entorpece. Para poder salir de un síntoma se debe producir un cambio básico en la situación social de la persona, una modificación que le permita liberarse a fin de seguir creciendo y evolucionando.

momento de contraer matrimonio, eran individuos no alcohólicos, existiendo generalmente en uno de ellos un hábito de ingestión moderada. Es decir, habría habido una suerte de predeterminación, producida por *variables socioculturales correspondientes al ciclo de vida*, que llevó al hábito de una ingestión moderada a una ingestión excesiva, centrando a la familia alrededor del alcoholismo.

Al iniciarse el matrimonio, es decir, al comenzar el proceso de consolidación de normas y valores de la pareja conyugal, comienza a estructurarse el futuro rol del hábito alcohólico. Debido a relaciones disarmónicas entre los cónyuges, la pareja se ve imposibilitada de forjar reglas propias y adopta por ello, frecuentemente, las de sus respectivas familias de origen como una mera extensión, fortaleciéndose de ese modo la línea materna o paterna respectivamente. Por el contrario, si la pareja puede estructurar reglas que sintetizan los aportes de ambos cónyuges por igual la existencia del nuevo sistema asegurará una activa interrelación creativa con el medio y cada uno de sus miembros. En resumen, el alcoholismo no es producto de una conducta atípica de un solo individuo sino consecuencia de relaciones de pseudomutualidad entre los cónyuges.

Según los tres posibles casos de matrimonios —un miembro alcohólico con un no alcohólico, dos no alcohólicos o dos alcohólicos— cualquiera de ellos puede evolucionar en una pareja alcohólica. Nuestra experiencia versó únicamente sobre el segundo de los tres, donde uno o ambos cónyuges bebían en forma moderada. Hemos constatado que esta ingestión moderada no era registrada como problemática al momento del casamiento. Aún más: este hecho puede hacerse extensivo al primero de los tres casos arriba mencionados.

Existía “en apariencia” una mutua complementariedad de los roles y plena aceptación de la ingestión por el miembro no bebedor. Esto es comprensible si tomamos en cuenta que la primera fase del matrimonio es una etapa crítica con frecuentes tensiones, que permite probar a la pareja variados modos de acercamiento y de organización de las relaciones. Nuestra

experiencia y nuestra lectura de la realidad a partir de la teoría de la comunicación, nos indican que *el miembro que no ingiere acepta y promueve la ingestión en el otro*. Llamamos la atención sobre este punto porque transcurrido un lapso en el ciclo de vida es frecuente escuchar afirmaciones despectivas sobre la calidad moral del miembro que ingiere.

Otro fenómeno observado ha sido que durante sucesivas etapas de aparente armonía las familias han adaptado la ingestión moderada o excesiva de alcohol a las reglas, ritos y mitos familiares. Cuando en un momento crucial de su existencia se rompe la estabilidad del sistema, la familia ya tiene a su disposición un síntoma; que adquiere significación, con la mera rotulación del bebedor activo; el sistema vuelve a estabilizarse rígidamente alrededor del síntoma. Esta dinámica subsiste hasta la disolución del sistema por muerte o separación de uno de los cónyuges.

Concluyendo: las familias que acuden a un tratamiento lo hacen generalmente con el fin expreso de curar al miembro rotulado. Pero de acuerdo a lo desarrollado en párrafos anteriores, podemos afirmar que el síntoma alcohólico no es el resultado de un proceso individual sino que es el *producto de la interacción del grupo familiar con el entorno y consigo mismo*.<sup>2</sup> Es por eso que los tratamientos tradicionales basados sobre la comprensión individual del síntoma fracasan produciéndose una deserción del mismo. Por el contrario, a partir de la visión sistémica de la sintomatología, hemos obtenido resultados significativos con el alta familiar en terapias breves.

#### Criterio de salud y enfermedad de la familia alcohólica. Anomalía y patología del síntoma.

El concepto normativo utilizado con frecuencia para la definición del alcoholismo es el de la media estadística, que registra la cantidad de alcohol consumida en un día, el número

<sup>2</sup> Pasamos entonces a una taxonomía diferente ya que no hablaremos de individuo alcohólico sino tomando la categorización de Seinglass, de “familia alcohólica”.

de embriagueces por año, es decir, las características del beber según ellas sean continuas, remitentes o intermitentes. Lo "normal" para nuestra cultura, es un índice general, que registra valores acordes a un promedio establecido sin tener en cuenta las características de la población, sus usos y costumbres. Como complemento de esta categorización se encuentran todas aquellas justificaciones psiquiátricas (respecto de una perspectiva genética en la transmisión del alcoholismo de padres a hijos); psicológicas (respecto de una personalidad dependiente del alcohólico); sociológicas (cuando la estructura social restringe al individuo el acceso a las metas de éxito definidas culturalmente con la consiguiente desadaptación al medio) y antropológicas (que indican el hábito alcohólico de la población en esa dirección). A su vez los medios masivos de comunicación transmiten el mensaje de la necesidad de beber como símbolo de la felicidad del hogar, del fortalecimiento de las relaciones laborales y sociales, etc. Esta variedad de posibles etiologías se hace extensiva y conduce a una confusión en los tratamientos clínicos y de rehabilitación. Como el alcohólico es considerado un estigmatizado, es decir, que posee atributos desacreditadores y desvalorizados, el tratamiento se hace difícil también por la elevada tendencia al rechazo por parte del profesional.

La concepción científica de nuestro tiempo, a pesar de haber transcurrido más de cien años desde su elaboración, *sigue siendo positivista*, ya que no sólo se cuantifica (la curación equivale a una reducción parcial o total de la ingestión expresada numérica o porcentualmente) sino que se rotula al paciente mediante el síntoma.

Expondremos a continuación, en apretada síntesis, la teoría clásica positivista sobre el alcoholismo para contraponerla luego a la desarrollada por nosotros.

Recordemos a Comte, para quien las leyes de lo normal, definidas como armonía, son iguales a las leyes de la enfermedad, separando a ambos estados un mero cambio cuantitativo. *Toda modificación de lo normal se refiere a la intensidad de los fenómenos y no a una variación de clase o de naturaleza.* Así, entonces, todo estado alcohólico tiene un estado normal que le

corresponde y del cual es una expresión perturbada. El problema de la curación del alcoholismo sobrevendría por la insuficiencia de conocimientos del estado sobrio. Es decir, habría ciertas funciones normales desconocidas, que impiden la explicación del estado de intoxicación. Podríamos decir, que tal como ha sido considerado el problema del alcoholismo, hay dos aspectos fundamentales que lo sintetizan:

— *Homogeneidad entre el estado sobrio y el alcoholismo:* ya que ambos poseen una naturaleza en común, con definir la de uno se conoce la del otro.

— *Relación de continuidad del estado sobrio al alcohólico:* la diferencia entre ambos estados es una variación cuantitativa expresada numéricamente en una curva cuyo origen es el estado sobrio. La terapéutica consiste en reducir paulatina o drásticamente el estado de ingestión exagerada hasta arribar al punto cero de la curva antes citada.

Se desprende de lo antedicho que ambos aspectos son inseparables: para que haya homogeneidad debe hacer continuidad entre ambos estados.

En contraposición a la teoría clásica expuesta, nosotros sostenemos que la diferencia fundamental entre el estado sobrio y el alcohólico es de orden cualitativo. Aún más: toda variación cuantitativa responde a una modificación cualitativa.

Esta tesis implica una serie de postulados que marcan una diferencia radical con respecto a los que se desprenden de las teorías tradicionales:

— Las actitudes del individuo sobrio son cualitativamente diferentes a las del alcohólico;

— Todo el grupo familiar está comprometido con la ingestión activa de uno o de varios de sus miembros;

— *El estado alcohólico no es anormal.* Por el contrario, establece normas y valores que se distinguen de las elaboradas en el estado sobrio por serles inferiores en cuanto inmodificables. Es decir, *ambos estados son normales porque tienen la capacidad de ser normativos*, y se distinguen entre sí, al generar leyes distintas que enfocan la vida de otro modo.

En fin, los conceptos tradicionales que se basan sobre la

homogeneidad-continuidad enfocan el síntoma individual del alcohólico, pero no estudian ni comprenden los mecanismos funcionales propios de los sistemas familiares, que son los que dan coherencia a la aparición y mantenimiento de la patología. Esta aparece entonces, a nuestro juicio, en una totalidad que le da sentido. El alcoholismo es un síntoma que se cronifica fácilmente debido a las necesidades del grupo familiar de estabilizarse alrededor de una persona que haya asumido ese rol.

Hasta el momento en que se desequilibre el sistema familiar la ingestión alcohólica funcionaba como anomalía no patológica. La conducta alcohólica anómala es un conjunto de conductas singulares, con una estabilidad dinámica determinada, pero en la cual no hay conciencia del problema. Tomemos como ejemplo una familia donde el hombre es bebedor casero o salidor, pero donde esta actitud es perfectamente aceptada por su cónyuge, quien a su vez fomenta y consiente este rol. Al producirse, por factores internos o externos, un cambio profundo en el ciclo de vida se desequilibra el sistema y la anomalía alcohólica se hace patológica, porque les será necesario a los cónyuges estructurar el síntoma para seguir manteniendo el mismo modelo de funcionamiento basado en la distancia y separación de éstos. Cuando la anomalía se hace consciente en el sistema familiar se hace patológica: surge la denuncia de la enfermedad. Decía Leriche que *la salud es el silencio de los órganos*. Sólo hay conciencia concreta de la anomalía por obra de la enfermedad. En el caso del alcoholismo, mientras exista anomalía, se acepta lo diverso, y existen muchas conductas que rodean, justifican y "protegen" al miembro que bebe. Cuando éste es rotulado definitivamente como alcohólico la familia no acepta que sean descubiertos otros conflictos ya que se ha establecido un estereotipo que responde a una norma rígida, única e invariable. Tan crucial es este punto que durante los tratamientos la familia se resiste a descubrir en su seno conductas y actitudes desconocidas hasta el momento y no aceptadas por la conciencia del grupo. Nuestro tratamiento tendrá como objeto lograr una modificación de la interacción

familiar para que sus miembros puedan crear normas más flexibles.

La definición de *sobriedad* y de *intoxicación alcohólica* está íntimamente ligada al universo de los valores sociales y culturales. Ambos conceptos están en relación directa con las categorías instrumentadas por la sociedad para estructurar la realidad. Cada momento histórico establece un marco normativo determinado que explica la realidad sociopsicológica y los modelos de conducta de las personas. Las categorías son relativas, ya que dependen del modelo histórico en que se desarrollan. Sus modelos de identificación primaria —las primeras relaciones objetales— y los de identificación secundaria —los grupos de pertenencia y/o referencia— responden a formaciones socioculturales más que a la naturaleza humana establecida biológicamente. Sin embargo cuando es necesario definir patología, el enfoque tradicional opta por la segunda entidad, porque al decir que el alcohólico tiene un síntoma orgánico, la enfermedad es asumida con mayor facilidad y el rol difícilmente cuestionable. En este modelo que la sociedad ha elegido para aprehender la realidad, la dicotomía realidad sociopsicológica-organicidad queda resuelta adscribiendo al sustrato orgánico; funciona como criterio de verdad que da a los sujetos una "auto-percepción de seguridad" y un menor compromiso en la resolución de los problemas. Lo esperado en el alcohólico, según el estereotipo social vigente, es una conducta que actúa como marco de referencia y que sirve para tipificarla según un cierto modelo de comportamiento. En resumen, la sociedad establece un cierto marco de referencia en la valoración de la conducta alcohólica, determinadas pautas esperables, ciertas normas prefijadas<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> ¿Cuáles son las características de un alcohólico? Los alcohólicos tienen un estilo de sobriedad que los impulsa a beber; este estilo contiene algún error o patología al que la intoxicación proporciona necesariamente alguna corrección, por lo menos subjetiva. Bajo este punto de vista la sobriedad es considerada "errada" en cambio la intoxicación "acertada". Siguiendo a Bateson, la personalidad alcohólica es una personalidad total que no puede combatir al alcoholismo de ninguna manera posible. El alcohólico está ligado por una red de premisas que, independientemente

Nosotros sostenemos en cambio que para elaborar correctamente un modelo de alcoholismo la sociedad debería respetar los estilos particulares de ingestión de los grupos, expresado por las diferentes cuanta de ingestión tolerados<sup>4</sup>.

Insistimos: *sobriedad y estado alcohólico se distinguen cualitativamente*. Nuestro punto de partida para definir el concepto de normalidad es la interrelación dinámica del hombre con su medio ambiente o entorno. Se puede predicar la normalidad únicamente de la interrelación, no de cada uno de los términos por separado. Citando a Canguilhem "Un ser vivo cualquiera es normal en un medio ambiente dado, en la medida en que es la solución morfológica y funcional hallada por la vida para responder a todas las exigencias de ese medio ambiente". Es en ese sentido que afirmamos que lo patológico no es el individuo aislado sino todo el grupo familiar que no tolera por su rigidez, ninguna desviación de las condiciones en las que vive. Su margen de interacción es tan pobre que no puede cambiar el rumbo de vida.

Anteriormente nos referimos a la diferencia de anomalía y patología en la estructura de la familia alcohólica. Ambas son normativas pero con una salvedad: mientras la primera mantiene una adaptación activa a la realidad, en cuanto a estabilidad dinámica, fecundidad y variabilidad de la vida, la segunda implica la estereotipia, la rigidez de la norma, que inevitable-

de su verdad o de su falsedad, se convierten en autovalidantes para él. Fundamental es la premisa del orgullo o "hybris" del alcoholista: él domina su ingestión, puede dejar de tomar en cualquier momento. Otra, derivada de ésta, es la relación simétrica que supone mantener con la botella. La realidad indica que ambas son falsas: *La relación con la botella no es simétrica sino complementaria*; el alcohólico no domina su ingestión y tras enconada resistencia a ser sometido por ésta cae vencido.

<sup>4</sup> Nótese qué olvidado está este respeto en las terapéuticas tradicionales. Según éstas, la población de Rafael Castillo, que tiene una ingestión promedio de 3/4 litros de vino por día por persona, sería alcohólica en su totalidad! Desde nuestro enfoque comprendemos los diferentes usos y costumbres de la población atendida debiendo comprender primero sus leyes sobre la salud antes que extrapolar las nuestras.

mente tiende a la pobreza del sistema familiar, en cuanto disminución de relación con el entorno y, por lo tanto, tendencia a la destrucción. Lo patológico no es la ausencia de norma, sino la existencia de una norma que procura una adaptación pasiva al medio.

Al definir el estado sobrio, tomamos en cuenta lo que hemos dado en llamar los "comportamientos adaptativos"; esto es, el comportamiento signado por aquellas conductas que la familia elige para responder de un modo funcional a las exigencias del medio. Para mantener la estabilidad dinámica la familia desarrolla un proceso dialéctico<sup>5</sup>.

Por el contrario, característico de la familia alcohólica es el "comportamiento catastrófico". Llegada al umbral de estabilidad, cualquier cambio en la vida diaria desencadena una catástrofe a partir de la cual aparece el síntoma como estabilizador: pero téngase en cuenta que la nueva estabilidad será estática y pasiva, es decir disfuncional, porque han fracasado los intentos de adaptación activa<sup>6</sup>. Cuanto mayor es el empeño de esta familia de generar respuestas adaptativas tanto mayor será el encierro al que se verá sometida. La familia alcohólica

<sup>5</sup> Por ejemplo frente a la adolescencia de sus hijos una pareja se plantea la posibilidad de dar cumplimiento a su deseo de efectuar salidas solos y ya no con sus hijos; para evaluar su decisión cuenta con un conjunto de normas positivas y negativas:

| Normas Positivas                 | Normas Negativas                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Salir todos los días.            | No salir sin los hijos.                       |
| Salir todos los fines de semana. | Salir sólo uno de los cónyuges.               |
| Salir sólo con amigos.           | Salir uno de los cónyuges con algún hijo.     |
| Salir sin amigos, etc.           | Quedarse en casa y que salgan los hijos, etc. |

A partir de éstas será sintetizada la nueva norma (salir una vez por semana solos y con los hijos, cuando éstos se lo requieran) que le permitirá insertarse de un modo funcional creativo en la nueva situación.

<sup>6</sup> Siguiendo con el ejemplo anterior, en la familia alcohólica se resolverá que los cónyuges no salgan como producto de su síntesis vital negativa y estática.

ha quedado aprisionada en un modelo de funcionamiento "donde el resultado de las conductas son siempre "más de lo mismo".

### Alcoholismo y migración

Los tratados clásicos sobre migración refieren su punto de vista desde la perspectiva de los factores de la misma —estructurales e individuales—; de las características —tipos de migración, volumen y distancia, grupo social— y de las consecuencias —tanto para el lugar de origen como para el de destino.

La mayor parte de los pacientes alcohólicos que atendemos pertenecen a grupos migrantes que por fuerza de las circunstancias han debido aprender a vivir en dos culturas con todas las implicaciones que este hecho reviste. Debido al choque cultural, la población migrante también debió aprender a convivir con dos conceptos de salud y enfermedad: el propio de su lugar de origen y el de la sociedad receptora.

Por la naturaleza de nuestro trabajo nos hemos abocado al estudio del proceso de adaptación y la significativa aparición del síntoma en el curso del ciclo de vida.

Generalmente los profesionales trasladan sus propios modelos sin visualizar claramente las diferencias culturales con respecto a las de sus pacientes. Al chocar dos modelos sobre el problema del alcoholismo surge la incomprensión y la frustración y generalmente la mutua acusación del fracaso del tratamiento. Teniendo en cuenta estas experiencias fracasadas nos propusimos en principio conocer los patrones culturales respecto de las reglas y metarreglas de los pacientes alcohólicos atendidos con el objeto de elaborar y comprender sus modelos de conducta. Hemos estudiado los rituales particulares de interacción, los modos de comunicación, características de abordaje del problema y diferencias en la organización y estructura familiar. El punto fundamental sobre el cual hemos centrado nuestra atención ha sido la falta de una integración total a la sociedad receptora. Debido a que hubo aspectos en el proceso de aculturación que no fueron internalizados, el grupo

familiar ha quedado ubicado en una situación de semi marginalidad.

Analicemos un poco más de cerca la falta de integración. En un plano aparente, formal, la adaptación es total: las familias migrantes tienen trabajo, usufructúan los servicios públicos y se encuentran protegidos por una legislación igualitaria pero la realidad es otra: hay desadaptación porque la familia se aferra a las pautas de su lugar de origen (como un mecanismo de defensa que veremos más adelante) ya que no existe ninguna institución intermedia que actúe como "colchón amortiguador" entre la "vieja" y la "nueva" sociedad<sup>7</sup>. Esto nos llevó a pensar que debería existir algún nexo entre el síntoma y la desadaptación a través de alguna falla en el proceso de re-socialización. Falla que estabilizaría al sistema en una crisis de valores entre las dos sociedades, manteniéndose de ese modo la distancia cultural entre ambas. De este modo los grupos de familias migrantes, al devenir en sistemas aglutinados, deciden que el hombre, que en principio desempeña el rol instrumental, sea el encargado de negociar con los otros sistemas, mientras que la mujer, a cargo del rol afectivo, adquiere un poder importante como factor de cohesión y como eje de decisiones. Explicitando: al ser el hombre quien cumple el rol activo, es él quien sufre el embate de las nuevas normas en su trabajo diario desequilibrando el sistema. Contrarresta la mujer esta desestabilización al ser la encargada de conservar la adherencia al pasado. La familia migrante actúa entonces como si estuviera en un sistema matriarcal. Esta particular interacción funciona como mecanismo de defensa para evitar la desintegra-

<sup>7</sup> Sluzky en su trabajo sobre migración menciona que ella "es un cambio con pocos o ningunos rituales prescriptos. En la mayoría de las culturas y medios, los migrantes son abandonados únicamente a sus rituales privados. La más notable excepción tiene lugar en Israel, donde el Ulpan, un programa inicial de residencia y de enseñanza intensiva del hebreo a los nuevos migrantes, produce todo un verdadero ritual de iniciación. Hay también excepciones en otras culturas, tales como los "vagones de bienvenida", rituales desempeñados por vecinos de la clase media americana para las nuevas familias que migran".

ción del sistema. Debido a la discordancia que resulta del desajuste entre las expectativas y el medio ambiente, esta distancia entre culturas reduce al mínimo la regulación de los mecanismos de adaptación. Como la preocupación fundamental en el período que sigue inmediatamente a la migración es la supervivencia, a pesar de encontrarse fallas en los mecanismos de adaptación, no se produce todavía el síntoma.

Hemos observado en las familias alcohólicas que tanto el hombre como la mujer han traído de su lugar de origen el hábito de ingestión moderada. La estructura aglutinada del sistema tiende a mantener los conflictos en estado latente y el único rasgo observable es que ciertas características de la interacción aparecen ligeramente exageradas. Así el hombre aumentará su tendencia a ser salidor, a encontrarse con sus pares en el bar mientras que la mujer incrementará, en principio, su adherencia al pasado y luego su relación con el subsistema hijos, produciéndose una mayor separación entre cónyuges. De acuerdo a lo que definimos anteriormente, el hábito de beber se enmarca en la anomalía no patológica.

Sin embargo el efecto de las resistencias, de las deficiencias de los mecanismos de adaptación familiar, del fracaso de instrumentar reglas y valores que fueron útiles en el lugar de origen pero no funcionales para la sociedad receptora, es acumulativo; la deficiente resolución de los conflictos tiende a incrementarlos hasta llegar a las fronteras del sistema, produciéndose lo que hemos denominado la catástrofe.

Debido a la existencia de fallas en los mecanismos de adaptación y regulación, los niveles de tensión y hostilidad latentes crecen rápidamente hasta producir la desestabilización del sistema. *El alcoholismo aparece entonces como elemento estabilizador y es en este momento en el que la anomalía se hace patológica.* Este proceso no tiene una duración definida sino que responde a las particularidades de la interacción de cada grupo; puede extenderse desde unos pocos meses hasta años después de la migración. También puede aparecer en la segunda generación si el sistema familiar migrante fue muy cerrado y pudo mantener su cohesión en el nuevo medio. En

esta etapa se consolidan las conductas que anteriormente habían comenzado a manifestarse. El hombre que incrementó su autonomía respecto de su mujer se ha transformado en el miembro alcohólico del grupo. El costo social que este cambio de estabilidad implica es la legalización del rol del alcohol como síntoma depositado en la persona que tenía una conducta bebedora moderada. Esta etapa de crisis es el resultado del fracaso del grupo familiar en adaptarse a la cultura del lugar de destino mediante reglas y valores familiares que fueron efectivas y funcionales en la sociedad de origen. Puede ocurrir que algunos pueden ser adaptativos también en la nueva cultura, pero la imposibilidad de hacer efectivos ciertos patrones considerados como nodales para la identidad familiar, impiden al sistema permanecer abierto<sup>8</sup>. La crisis de polarización de los roles puede ser causa de divorcio, pero, en el caso de los pacientes alcohólicos, cuando no se produce esta circunstancia se equilibra el sistema, como vimos alrededor del síntoma. Debido al estado de confusión y de desorganización en que se encuentra el grupo, lo menos frecuente es que pueda activar un cambio de roles. Nuestra hipótesis, entonces, es que en esta etapa la modificación del status de anomalía a patología respecto de la ingestión alcohólica es para las familias migrantes el resultado de la desadaptación. Siendo ella producto del desfasaje de las normas y valores entre la sociedad de origen y la de destino se va incrementando en función del tiempo. Esta patología lleva implícitos dos tipos de mensajes:

- 1) Con respecto a la sociedad receptora: estabilizar el sistema familiar.
- 2) Con respecto a la sociedad de origen: ligar a la familia al pasado donde el beber era valorado positivamente<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> En determinado momento por razones de supervivencia la mujer se ve obligada a trabajar. Al desaparecer como núcleo del sistema familiar quiebra las reglas del sistema anteriormente descrito y la familia se dispersa. Para contrarrestar esta situación de desequilibrio busca un nuevo factor de cohesión alrededor del cual pueda estabilizarse; será alcohólico, generalmente el hombre, quien cumpla ese rol.

<sup>9</sup> Recordemos: ambos cónyuges aceptan y fomentan que el hombre sea el salidor, que frecuente el bar y que tenga hábitos de ingestión.

Es interesante observar cómo el tiempo de residencia en el lugar de destino produce el aumento del síntoma alcohólico. En un reciente trabajo de investigación realizado por el Centro de Salud Mental se observó que las familias recién migradas y aquellas con una residencia no mayor de cinco años tienen como norma la ingestión moderada compartiendo la bebida ambos cónyuges; en cambio en las familias con un tiempo de residencia mayor de diez años se observó que la norma es la ingestión excesiva: quien bebe es el hombre sin la compañía de su mujer. Esta observación comprueba nuestra hipótesis.

A medida que transcurre el tiempo y que el grupo familiar se va comprometiendo cada vez más con el nuevo medio y debido al desfase arriba mencionado la familia se estructura alrededor del hábito alcohólico "atribuido" al miembro rotulado como "bebedor". Será él quien re-estabilice el sistema en caso de crisis del ciclo de vida<sup>10</sup>.

### Experiencia clínica

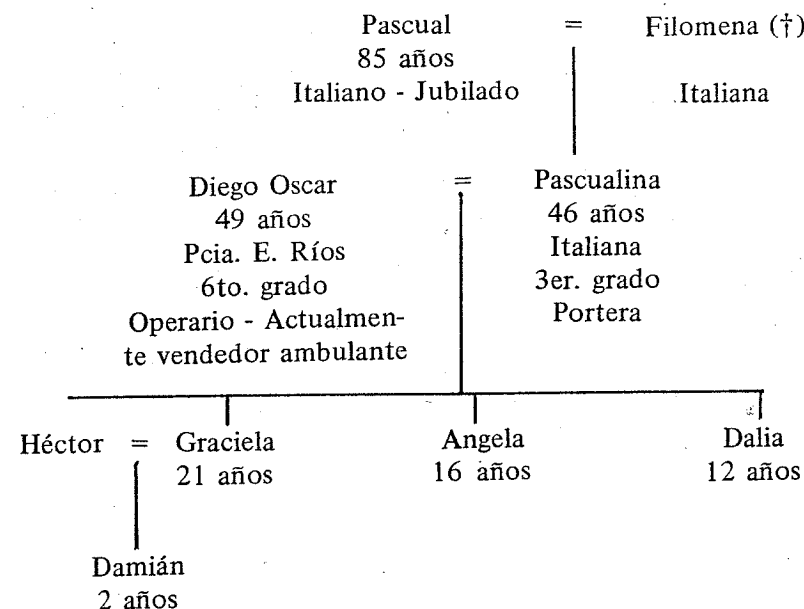
De las doce últimas familias tratadas y en seguimiento en el curso de la segunda mitad del año pasado hemos escogido a dos de ellas para ejemplificar lo expuesto anteriormente.

#### a) Familia F

El motivo de consulta de la Familia F. es el alcoholismo manifiesto de Diego Oscar. La ingestión le acarrea dificultades en su trabajo y le crea problemas familiares, específicamente, la separación de su nieto, como veremos más adelante. Desde hace seis meses está suspendido en su trabajo acusado de negocio ilícito. En realidad, él no estuvo comprometido en el hecho, sino que al no querer denunciar a sus compañeros fue incluido en el proceso de despido.

A partir de la primera entrevista vamos conociendo las

<sup>10</sup> Juega un papel importante la separación de los hijos quienes rompen el aglutinamiento al entrar en contacto con la escuela, poniendo en peligro la estabilidad del sistema.



respectivas historias de vida de cada uno de los integrantes y que sintetizaremos a continuación. *Diego Oscar* nace en Victoria, Entre Ríos; a los 20 años viene solo a Buenos Aires, permaneciendo sus padres y hermanos en su ciudad natal. Su padre también es alcohólico. Diego Oscar se ve esporádicamente con su familia de origen cuando lo visitan en Buenos Aires o cuando él viaja a Victoria. La frecuencia de visitas desde un principio se vio reducida por la negativa de Pascualina de acompañarlo ya que ésta debía asistir a su padre Pascual. Diego Oscar comenta que en su pueblo natal ya acostumbraba a beber moderadamente pero que su deseo de tomar se incrementó hace unos dos años. La característica de Diego Oscar es la de ser muy callado; sólo responde a las preguntas de los terapeutas y acepta resignadamente las acusaciones de Pascualina respecto a la falta de responsabilidad en las obligaciones paternas. Diego Oscar trabaja ahora como vendedor ambulante, en espera de la resolución del juicio de despido.

*Pascualina* por su parte, llega de Italia a los 18 años con su

madre ya que su padre había inmigrado antes trayendo después a toda la familia. Unica hija mujer es la menor de sus hermanos. A los 25 años de edad fallece su madre, quedando a su cargo las tareas del hogar paterno. Antes de conocer a Diego Oscar ha tenido dos pretendientes, descendientes de italianos, que no fueron del agrado de Pascual. Este tampoco aceptó a su actual yerno, poniendo como excusa su origen argentino y del interior. Pascualina se define como una mujer fuerte, que siempre se hizo cargo del hogar y que ahora, debido al despido de su marido, empieza a trabajar como portera de una escuela. *Nunca le molestó que su marido tomara.* Desde hace dos años esta situación cambia y se hace insoportable. Diego Oscar y Pascualina se conocen en un hospital, donde ésta cuida a su madre enferma. Diego Oscar concurre a la misma institución para visitar a una señora amiga. El noviazgo de ambos es muy breve aceptando finalmente Pascual la incorporación de un extraño a su grupo familiar. El casamiento se realiza después del fallecimiento de Filomena. A su vez, Pascual, quien hasta ese momento había sido alcohólico, se jubila y pierde "espontáneamente" el interés por la bebida. Pascualina impone como conditio sine qua non vivir con su padre, quien se incorpora a la familia como un integrante más, adquiriendo un poder muy importante ya que desprecia constantemente a su yerno aliándose con su hija en las peleas conyugales.

Respecto de las hijas, *Graciela* se casó dos años atrás. Todos coinciden en señalar esa fecha como la del comienzo de la patología de Diego Oscar. El marido de Graciela es hijo de italianos oriundos del mismo pueblo que Pascual y Filomena. El nuevo matrimonio se va a vivir a la casa de los padres de Héctor. Ante las dificultades surgidas en la pareja, Graciela decide retornar con su hijo Damián a la casa de sus padres. Fracasa un intento de reconciliación y se entabla un juicio de divorcio.

*Angela*, por su parte, a partir del despido de Diego Oscar trabaja como empleada en un comercio.

La familia F. es una *familia aglutinada*, cuyo eje de poder pasa por la alianza de Pascualina con su padre, alianza en la

que no es admitido Diego Oscar. También la familia de Héctor es una familia aglutinada, ello explica el fracaso del matrimonio Héctor-Graciela. Esta pareja intenta constituir su propio sistema de normas a partir de las de sus familias de origen. Siendo éstas aglutinadas, como habíamos dicho, fracasan en su intento. Cada conflicto conyugal se resuelve mediante la intervención de las respectivas familias nucleares.

En la familia Diego Oscar-Pascualina, el primero funciona como miembro marginal y sólo se lo acepta como engendrador de la especie. En una primera etapa la incorporación de Diego Oscar a la familia de Pascualina produce dos efectos:

- Equilibra el sistema tras la muerte de Filomena.
- Reemplaza la ingestión de Pascual, quien a partir de dejar de ser alcohólico, es valorizado y estimado.

Pero en realidad, la norma para ser aceptado en la familia, es justamente la de *tener* una conducta bebedora, como la tuvo Pascual, quien funciona ahora, frente a Diego Oscar, como opuesto positivo. Como la pareja no logra articular sus propias reglas y normas y, por el contrario, se imponen las de Pascualina, queda constituida la nueva familia alcohólica alrededor del hábito de ingestión tal como había sido entre Pascual y Filomena.

La necesidad de una terapia aparece en el momento en que Graciela se separa definitivamente de Héctor, porque, a raíz del juicio de divorcio y ante la presencia de un miembro alcohólico en la casa, peligra la tenencia de Damián. La situación de crisis del grupo familiar se ve reflejada también en el noviazgo de Angela y el desarrollo de Dalia. Debido a que la pareja nunca pudo estabilizarse dinámicamente, la posibilidad de la separación de las hijas produce en ella la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio que el alcohol podrá ocupar perfectamente.

Llamamos la atención sobre el hecho que el proceso conyugal de Graciela y su regreso al hogar paterno señala a su vez la imposibilidad de la separación de los subsistemas Diego Oscar - Pascualina - Graciela. Este hecho a pesar de preocupar a la pareja, aparece irrelevante frente al problema del alcoholismo de Diego Oscar en quien recaen las acusaciones de todo el

grupo. En fin, la ingestión de Diego Oscar "protege" a la familia de hechos trascendentes del ciclo de vida que no pudieron ser resueltos. De este modo esos niveles de tensión y hostilidad permanecen en estado latente:

- Ocultar el fracaso de Graciela.
- Ayudar a la abstención del suegro, ya que por la estructura de este sistema familiar si Diego Oscar deja de tomar Pascual volvería a ingerir.
- Disminuir la preocupación de la pareja frente a la probable dificultad de las hijas de separarse y formar otro hogar.
- Ocultar las diferencias conyugales.

Nuestra tarea fue valorar a Diego Oscar<sup>11</sup>, lograr que su juego de escalada simétrica se tornara un juego de complementariedad para con Pascualina y obtener de ella aceptación de aliarse con su marido. Esto último fue lo más difícil, ya que Pascualina se resistía no sólo a cumplir con las tareas prescritas sino a aceptar las constantes redefiniciones de su relación con Diego Oscar. Como consideramos que la pareja se había detenido en el momento del ciclo de vida correspondiente a su noviazgo prescribimos tareas de regalanteo<sup>12</sup> con el fin de separar el subsistema Pascual-Diego Oscar/Pascualina.

Presentamos a la familia un nuevo modelo de su sistema familiar señalando el altruismo de Diego Oscar por sacrificar la fuerza y el empuje que tuvo durante el noviazgo para ayudar a valorizar a Pascual y mantener la relación con su hija. De ese modo Diego Oscar había entrado como débil al grupo familiar permaneciendo la pareja en la casa de los padres de su mujer para que ésta no sufriera la separación.

Sin embargo la tarea más exitosa fue la de modificar los rituales familiares respecto al hábito de ingestión. El objetivo

<sup>11</sup> Las normas rígidas del grupo empezaron a cambiar, ya que en una de las sesiones descubrimos que Diego Oscar con su trabajo ambulatorio ganaba más dinero que Pascualina y Angela juntas.

<sup>12</sup> Como salidas de los cónyuges o el arreglo y cuidado de Pascualina.

era que Diego Oscar reemplazara la relación complementaria con la botella por su esposa. Se buscó que Pascualina aceptara el beber frente a la sistemática oposición al mismo. Prescribimos la tarea de que Diego Oscar bebiera en su casa, cosa que nunca había hecho, recibiendo ayuda de su esposa, quien debió servirle la cantidad de bebida que él pidiera. El objetivo también tenía otra finalidad: que Diego Oscar reemplazara el ritual de beber fuera de su casa, como en su lugar de origen, como una forma de insertarlo en una nueva realidad social de la que no se había hecho cargo todavía.

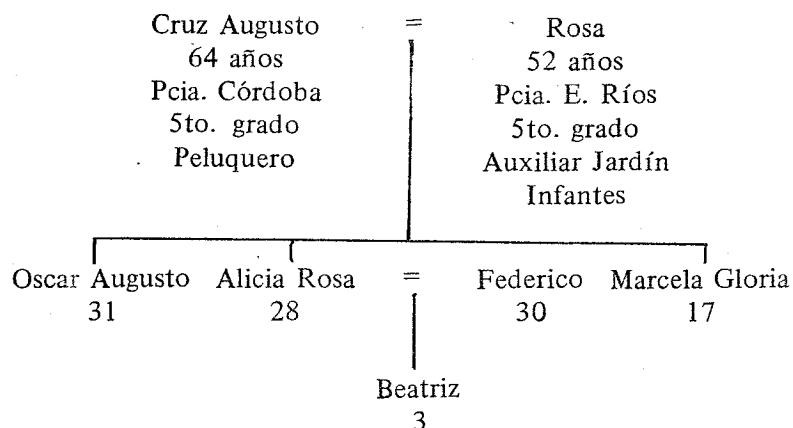
A partir del nuevo juego de complementariedad entre los cónyuges, el poder que Pascualina había puesto en su padre<sup>13</sup> es puesto en su marido, quien se convierte en un bebedor social pudiendo moderar la cantidad de ingestión.

En nuestro trabajo con alcohólicos nunca imponemos la abstinencia ya que esto implica un enfrentamiento con el sistema y el desconocimiento de hábitos particulares de ingestión<sup>14</sup>. La tarea terapéutica se considera concluida cuando el sistema encuentra un nuevo modelo de funcionamiento cuando el alcohol pierde su efectividad como síntoma que permite mantener la estabilidad.

Así ocurrió con el tratamiento de la familia F. Diego Oscar empezó a defender su situación con respecto a su trabajo y a registrar que en realidad era él quien mantiene el hogar. Además, pese al grave momento económico encontró un trabajo mejor. Después de dos meses de tratamiento con ocho entrevistas en total, se comenzó con un remunerado seguimiento bimestral mediante el cual pudo apreciarse la remisión del síntoma y con ello la modificación del status como familia alcohólica.

<sup>13</sup> El poder de Pascual forma parte del mito familiar porque el verdadero poder es de Pascualina.

<sup>14</sup> Cf. página 196, primer párrafo, de este mismo trabajo.

b) *Familia P.*

Vienen a la consulta motivados por el problema de Cruz Augusto. Son derivados por un psiquiatra particular que conoce nuestra experiencia en alcoholismo. A la primera entrevista concurre la pareja sola agregándose después, a pedido de los terapeutas, Marcela y finalmente Oscar Augusto.

El paciente identificado es un bebedor crónico que por recomendación médica dejó de beber bebida blanca pero que siente hacia el vino una "afinidad" muy especial. Nace en Córdoba y llega muy joven a Buenos Aires. Gusta tomar moderadamente y siempre frecuenta lugares nocturnos en compañía de amigos. Con el tiempo se aleja de sus compañeros y el lugar de ingestión pasa a ser la peluquería, donde a veces pernocta; otras deambula por el barrio o por la estación.

Rosa es entrerriana. Viene sola a Buenos Aires y va a vivir a la casa de un hermano mayor. No le gusta salir; por el contrario permite y alienta las salidas de su marido quedándose en compañía de sus hijos.

Se conocieron hace 32 años en casa del hermano de Rosa. Al poco tiempo se casaron en E. Ríos en su pueblo natal.

El primer hijo, Oscar Augusto nace con una oligofrenia severa. A partir de ese momento C. Augusto comienza a beber en forma desmesurada y sus salidas nocturnas son cada vez más

frecuentes. Durante 20 años este funcionamiento familiar no trae mayores conflictos; Rosa afirma no haber percibido la ingestión de su marido. Esta afirmación contrasta con la realidad ya que, como dijimos antes, era frecuente que C. Augusto no volviera a su casa o si lo hacía estaba en estado de ebriedad. Desde este momento la familia comienza a vivir con lo que llamamos anteriormente "anomalía funcional": el beber y las salidas del paciente identificado no eran registradas todavía como problema. Este surge cuando Alicia Rosa está de novia y se comienza con los preparativos para el casamiento. Ambos cónyuges incrementan sus conductas, C. Augusto con su ingestión y sus salidas y Rosa con su encierro familiar. A partir del casamiento de Alicia, Rosa comienza a trabajar en un jardín de infantes ausentándose casi todo el día del hogar. El cuidado de O. Augusto recae en su padre y en Marcela, quien debe reemplazar a su madre en las tareas del hogar. El motivo de consulta coincide con el momento en que Marcela termina el ciclo secundario y se prepara para estudiar teatro, actividad que no es del agrado de sus padres.

A partir de estos datos comenzamos a relacionar el alcoholismo de C. Augusto con la presencia del hijo enfermo ya que en la interacción familiar este nexo había sido para nosotros fundamental<sup>15</sup>. Se daba para la familia una afinidad entre la irreversibilidad de la enfermedad de O. Augusto y el sentido que el grupo familiar asignaba al síntoma del padre: si dejaba de beber voluntariamente —orgullo del alcohólico— su hijo se curaba mágicamente. Paradojalmente, por otro lado, si C. Augusto remitía su síntoma y su hijo no se curaba era el culpable de la enfermedad. Este mito era sostenido por las afirmaciones del médico y por las acusaciones no explícitas de su esposa<sup>16</sup>. Frente al dolor de haber engendrado un hijo

<sup>15</sup> La familia negaba la importancia de la enfermedad del hijo concentrando todas sus energías en la patología del padre.

<sup>16</sup> Rosa hace culpable a su esposo del origen de la enfermedad evitando de ese modo su propia culpabilidad y el haber fracasado en engendrar un hijo sano.

mogólico el alcohol ha servido para estabilizar el sistema y focalizar el problema en la enfermedad de C. Augusto y no en la patología congénita.

La función del alcohol en este sistema familiar es, entonces, originar una situación de doble vínculo en la pareja. C. Augusto toma, por un lado, para proteger a su mujer ya que si deja de hacerlo el hijo va a seguir estando enfermo y podría acusarse a Rosa de la responsabilidad; por el otro, se protege a sí mismo porque mientras siga tomando se confirma que el alcohol no es el culpable de la enfermedad de su hijo, hecho comprobado por la presencia de las dos hijas sanas que también él engendró. Cualquiera de las dos soluciones conduce a la ingestión y C. Augusto termina siendo el acusado ya que en la conciencia de la familia el hábito de la ingestión condujo a los conflictos y desgracias familiares. Esta afirmación se refuerza también en la elección de los nombres: el hijo enfermo recibe el nombre de su padre mientras que la primera hija sana el de su madre.

El momento del ciclo de vida en que el grupo familiar toma conciencia del problema coincide con un segundo impacto que recibe el grupo familiar al conocer Alicia Rosa a su actual marido. Hasta ese momento Rosa formaba un subsistema muy cerrado con sus tres hijos y su esposo buscaba la compañía de la botella y de sus amigos. Al peligrar la estabilidad lograda desde el nacimiento de Augusto, con el noviezgo de A. Rosa el grupo no puede abordar otra anomalía ya que el conflicto ha superado las fronteras del sistema y por lo tanto los márgenes de estabilidad permitidos. En esta etapa se produce una catástrofe y el sistema pasa de su estado de equilibrio a uno nuevo a raíz del cual se generan nuevas conductas:

— El grupo familiar percibe ahora el alcoholismo de C. Augusto, es decir, la anomalía funcional se ha transformado en patología. A partir de este momento el paciente es rotulado como enfermo.

— Rosa comienza a trabajar de auxiliar de un jardín de infantes, con lo que el cuidado de O. Augusto pasa a depender más de Marcela y de C. Augusto, quien lo lleva a la peluquería.

Durante diez años la familia funciona en este sistema de equilibrio: alternan en el cuidado de O. Augusto, padre e hija: Rosa se hace cargo recién por la noche cuando su marido está ausente. Cuando la estabilidad se ve amenazada por las intenciones de Marcela de independizarse (y dejar a C. Augusto solo con su hijo), es el momento en el que el grupo familiar inicia su consulta. La familia concurre al tratamiento con la necesidad del fracaso terapéutico ya que ello significará sellar definitivamente lo antedicho. Nuestra tarea fue romper el mito de la irreversibilidad del alcoholismo, fomentar el acercamiento conyugal, quebrar la homeostasis familiar patológica.

A pesar de haber transcurrido la mayor parte de la vida en la ciudad había ciertos aspectos que denotaban la repetición de costumbres, de su lugar de origen, que de por sí no eran patológicas, sino que la relación entre los cónyuges las había transformado en tales. Rosa estuvo durante muchos años encerrada en el subsistema con sus hijos y rompe abruptamente esa condición. Tratándose de una familia migrante su decisión de salir a trabajar sería indicio de adaptación si se interpretara esa actitud como una apertura del sistema<sup>17</sup>. Sin embargo, a partir de ese momento los cónyuges se distancian cada vez más.

A partir de centrar la atención en los objetivos fijados por nosotros la pareja logra una nueva estabilidad al realizar por primera vez tareas conjuntas tales como salidas, discutir el futuro de Marcela y plantearse la necesidad de que O. Augusto concorra a una Institución especializada. C. Augusto puede reducir y moderar adecuadamente la ingestión a partir de la colaboración de su esposa que hasta ese momento la rechazaba totalmente.

<sup>17</sup> La decisión tampoco responde a una causa económica ya que el trabajo de su marido es lo suficientemente rentable como para sustentar a toda la familia.

## Resumen

A partir del fracaso de los modelos clínicos tradicionales en dar asistencia al paciente alcohólico hemos escogido el modelo interaccional con el fin de poder comprender el problema desde otra óptica y brindar así un tratamiento psicoterapéutico adecuado. La teoría general de los sistemas permite explicar el síntoma alcohólico desde la interacción del grupo familiar y de su relación con el entorno. Pasamos entonces a enfocar el problema tomando como núcleo de estudio a la familia alcohólica y la aparición del síntoma por relaciones conflictivas en un sistema rígido y cerrado. Por el desfase del choque entre culturas diferentes, la significación del síntoma en las familias migrantes es de desadaptación; ellas repiten con la ingestión pautas valoradas en el lugar de origen.

*Refutamos los conceptos positivistas que sostienen una diferencia cuantitativa entre sobriedad/intoxicación basadas en aspectos de homogeneidad y de continuidad entre ambos estados.* Pensamos que la diferencia es de orden cualitativo, que existe una poderosa significación interaccional y que ambos estados engendran normas y valores; con la diferencia de que el estado alcohólico se transforma en un estado normativo rígido y estereotipado.

Hasta que aparece el síntoma la ingestión alcohólica cumple la función con anomalía ya que no era registrada como problemática por la conciencia del grupo.

Pero en el momento que un cambio serio afecta la organización del sistema familiar la anomalía se hace patológica; los conflictos superan las fronteras del grupo produciéndose una catástrofe al cambiar la estabilidad de uno a otro estado.

Finalmente, la definición de sobriedad y de intoxicación alcohólica es un concepto relativo porque depende del momento histórico y de las distintas clases sociales que viven en nuestra sociedad. El profesional no deberá hacer extensivo su concepto de salud y enfermedad sino comprender los hábitos de los grupos en tratamiento.

## Summary

Since the traditional clinic models have failed in giving assistance to the alcoholic patient, we have chosen the interactional model in order to be able to comprehend the problem from another point of view and thus offer an adequate psychotherapeutical treatment. The general theory of

systems makes it possible to explain the alcoholic symptom based on the interaction of the family group and its relation with the environment. We therefore centre our study considering the alcoholic family and the appearing of the symptom as a result of conflictive relations in a rigid and closed system. Due to the clash between different cultures, the significance of the symptom in migratory families is disadaptation: ingesting they repeat valued norms of their places of origin.

We refute the positivist concepts that sustain a quantitative difference between sobriety/intoxication based on aspects of homogeneity and continuity in between both states. On the contrary we believe the difference is qualitative: that there exists a powerful interaction significance and that both states engender norms and values, but that the alcoholic state is transformed by them into a normative, rigid, and stereotyped one.

Until the symptom appears, the alcoholic ingestion can be characterized as an anomaly not registered by the group's conscience as a problem.

But when a serious change affects the organization of the family system the anomaly makes itself pathological, the conflicts surpass the group's frontiers producing a catastrophe when the stability changes from one state to the other.

Finally, the definition of sobriety and alcoholic intoxication is a relative concept because it depends on the historical moment and on the different social classes. Instead of making extensive his own concept on health/illness to the group in treatment the professional should comprehend the group's habits.

## Bibliografía

- ADIS CASTRO. "Salud mental y alcoholismo". *Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina*. Año 1974, vol. 20.
- BATESON, G. *Pasos hacia una ecología de la mente*. Ed. Carlos Lohlé, Bs. As., 1972
- BATESON, G., FERREIRA, A. y otros. *Interacción familiar*. Ed. Tiempo Contemporáneo. Bs. As., 1971.
- VON BERTALANFFY, L., ROSS ASHBY, W. y otros. *Tendencias en la teoría general de los sistemas*. Ed. Alianza Universidad S.A., Madrid 1978.
- CANGUILHEN, G. *Lo normal y lo patológico*. Ed. Siglo XXI Argentina Editores S.A., 1971.
- COSER, L. *Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*. Ed. Amorrortu editores, Bs. As., 1970.

- FRANKEL, D. "La familia del enfermo mental". *Ficha cátedra Psicología Social, Carrera de Psicología*. UBA 1978.
- FRANKEL, D., MARTINOLI, E. "El conflicto familiar". *Ficha Carrera Sociología*. UBA, 1979.
- VALLE, M., GERMANI, G. *Sociología de la modernización*. Ed. Paidós, Bs. As., 1971.
- HALEY, J. *Terapia no convencional*. Ed. Amorrortu editores, Bs. As., 1980.
- HALEY, J. *Terapia para resolver problemas*. Ed. Amorrortu editores, Bs. As. 1980.
- HALEY, J., HOFFMAN, L. *Técnicas de terapia familiar*. Ed. Amorrortu editores, Bs. As., 1976.
- JACKSON, D. (Comp.). *Comunicación, familia y matrimonio*. Ed. Nueva Visión, Bs. As. 1977.
- LAING, R., PHILLIPSON, H., RUSSELL LEE, A. *Percepción interpersonal*. Ed. Amorrortu editores, Bs. As., 1978.
- PITTMAN, D. *Alcoholismo, un enfoque interdisciplinario*. Ed. Hormé S.A.E. Bs. As., 1966.
- SCHNITMAN, D. *Thinking Culturally in Family Health Care Working Draft*. December 1978 - San Francisco, USA.
- SLUZKI, C. "Migration and family conflict". *Family Process*. December 1979, Vol. 18, Nro. 4.
- STEINGLASS, P. "A life history model of the alcoholic family". *Family Process*. September 1980. Vol. 19.
- TISMINETZKY, M. *Salud y Enfermedad. Una experiencia interdisciplinaria*. Ed. Galerna, Bs. As., 1978.
- TISMINETZKY, M., FRONTINI, N., FRANKEL, D. Investigación realizada por el equipo de alcoholismo del Centro de Salud Mental de San Justo en la localidad de Rafael Castillo, Pdo. La Matanza, Pcia. Bs. As., 1980.
- WATZLAWICK, P. *El lenguaje del cambio*. Ed. Herder. Barcelona, 1980.
- WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. JACKSON, D. *Teoría de la comunicación humana*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Bs. As., 1971.
- WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. FISCH, R. *Cambio*. Ed. Herder, Barcelona, 1976.
- WILDEN, A. *Sistema y Estructura*. Ed. Alianza Universidad, S.A. Madrid, 1979.
- WOLIN, S. "Disrupted family rituals". *Journal of studies on alcohol*. Editorial Office: Rutgers University Center of Alcohol Studies, New Brunswick, N.Y., Vol. 41, Nro. 3, March 1980.

## CONCURSO 1982 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR

La Revista TERAPIA FAMILIAR instituyó un concurso de trabajos teóricos, clínicos o de investigación que signifiquen un aporte relevante al desarrollo del conocimiento y de la práctica de nuestra disciplina.

Recordamos que las condiciones son las siguientes:

- El concurso se realizará anualmente a partir de 1980.
- Los trabajos podrán ser presentados individual o grupalmente, pudiendo tratarse de terapeutas familiares o de equipos interdisciplinarios residentes en el país.
- El jurado estará compuesto por 6 (seis) personalidades reconocidas en nuestra disciplina y será designado por los responsables de la Revista Terapia Familiar. En caso de empate se requerirá el voto del Director de la Revista.
- El premio consistirá en un diploma y la publicación del trabajo en la Revista TERAPIA FAMILIAR. Podrá ser compartido o declarado desierto. El jurado podrá otorgar menciones a otros trabajos que serían eventualmente publicados.
- Los trabajos, que deberán ser inéditos, serán presentados en 7 (siete) copias escritas a máquina, a doble espacio, tamaño carta. Serán firmados con un seudónimo; que a su vez figurará con el título del trabajo en la cara externa de un sobre cerrado conteniendo en su interior el nombre y domicilio del o los autores.
- La recepción de los trabajos quedará a cargo de los responsables de la Revista TERAPIA FAMILIAR, hasta el 31 de Agosto de 1983. El trabajo premiado y las menciones que hubiera resuelto el jurado serán publicados en el segundo número de la revista de ese mismo año.

Comité de Redacción.



INSTITUCION PSICOTERAPEUTICA

Directores: Dr. Felipe Díaz Usandivaras  
Dra. Mirta I. Méndez Puig

Estimado Colega:

*Queremos por este medio darle a conocer Témpora, Institución Psicoterapéutica. Llegamos a ella a través de siete años de experiencia clínico-institucional y con un desarrollo propio: La Residencia Terapéutica Intermedia.*

*Estamos implementando una modalidad de trabajo que denominamos "Familia Terapéutica".*

*Somos una Institución abierta.*

*Témpora está integrada por las siguientes áreas:*

RESIDENCIA TERAPEUTICA  
INTERMEDIA

CLINICA PSIQUIATRICA

COMUNIDAD DEL TIEMPO  
(HOSP. DE DIA)

TALLERES TERAPEUTICOS

CENTRO INSTITUCIONAL

Solicitar entrevistas o informes  
Lunes a sábados de 9,30 a 21 hs.  
T.E. 771-8114/8108

SOLER 5961  
CAPITAL FEDERAL

A.F.E.C.

ABORDAJE FAMILIAR DE LA  
ENFERMEDAD CORPORAL

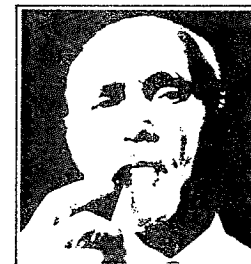
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO MEDICO-PSICOLOGICO

DRA. RUTH M. BELOTTINI  
LIC. MARTA BENDERSKY  
DR. BERNARDO CHOMSKI  
DRA. ANALIA KORNBLOT  
LIC. JAIME SZWARSTEIN  
DRA. SILVIA WASERTREGUER DE GUILLERMAN

TEL. 825-8995 / 783-0344

## TEMAS de PSICOLOGIA SOCIAL

Publicación de la Primera Escuela Privada de Psicología Social  
fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière Octubre 1982 - Nº 4



Ecología, Ecología Humana y Psicología Social  
Enrique Pichon-Rivière

Concepción y abordaje psicoterapéutico de grupo familiar  
IRDES

Psicoterapias breves  
Marcos Bernstein

Comento de " " PIDALA EN LIBRERIAS ESPECIALIZADAS

## PRIMER ENTRENAMIENTO INTENSIVO EN PSICO- TERAPIA FAMILIAR PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA.

En la segunda y tercera semanas de mayo de 1983 se realizará en Buenos Aires, en la sede de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, el *primer entrenamiento intensivo en terapia familiar para profesionales de América Latina*.

Dicho entrenamiento, a cargo de los Dres. Alfredo Canevaro y Analfá Kornblit, y de los Lics. Alicia Arbiser y Jaime Szwarcstein, realizado con un criterio teórico-clínico, comprenderá seminarios teóricos, trabajo en cámara de Gesell diariamente, revisión de video-tapes, situaciones claves con familias simuladas y observación de grupos multifamiliares. Se planteará el modelo de abordaje específico para familias con niños y con pacientes psicóticos y psicósomáticos.

El programa comprende 80 horas de trabajo (8 horas diarias, de lunes a viernes).

Arancel: 650 dólares.

Los interesados deben escribir a nombre de *Entrenamiento Intensivo*, Sociedad Argentina de Terapia Familiar, Gorostiaga 1731, Buenos Aires (1426), Argentina, adjuntando su *curriculum vitae*, antes del 10 de marzo de 1983. Serán notificados sobre su aceptación el 30 de marzo, debiendo enviar antes del 20 de abril un cheque o giro por valor de 150 dólares para reservar su lugar. Los 500 dólares restantes deben ser abonados al comienzo del curso. Una agencia de turismo local orientará a los interesados para su alojamiento.

## ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE

### Summer Practicum in Family Therapy Rome, June 1-25, 1983

four days per week for a total of 100 hours over the four weeks.

**OBJECTIVE:** To enable foreign therapists to gain experience in our model of therapy, supervision and training.

**ORGANIZATION:** Dr. Andolfi will lead the English speaking group. Groups in French will be led by Drs. Menghi, Nicolò and Saccu.

**ACTIVITIES:** Clinical work, participation in training groups, observation of direct supervision, theoretical seminars, study of clinical videotapes, indirect supervision, simulations, teaching related to leadership of training groups, a two-day workshop will be offered. Instruction will take place

**ELEGIBILITY:** A minimum of three years training in family therapy and clinical experience in the field. Preference to teachers of family therapy. Priority on the basis of the date of application and professional experience.

**FEE:** \$1,400. A non-refundable deposit of \$400 will be required upon acceptance to hold your place. The remaining \$1000 is payable at the beginning of the program.

**APPLICATION:** Application forms must be received, together with applicants Curriculum Vita, by March 1, 1983. Candidates will be notified of their acceptance by March 20th. Late applications will be considered only if space is available, at an extra charge of \$50.

#### REGISTRATION

To reserve your place, mail this registration form to:



Maurizio Andolfi  
ISTITUTO  
DI  
TERAPIA FAMILIARE  
via Reno, 30  
00198 Roma

Make checks payable to  
Paolo Menghi

Name .....  
Address .....  
City .....  
State ..... Zip .....  
Office Phone .....  
Home Phone .....  
Profession .....  
Degree .....

Check off your choice below:

- ☐ Summer Practicum 1983  
☐ Please put me on your waiting list for 1984

For further information write to  
Daniela Piccone at the above address,  
of phone at (06) 426790.

Date .....

# Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Palo Alto, CA*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.*

## FAMILY PROCESS

149 East 78th Street  
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE \_\_\_\_\_

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

### INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$27.00 per year Canada &  
Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

### INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$38.00 Canada &  
Latin America

☐ \$42.00 All other countries

NAME \_\_\_\_\_

ADDRESS \_\_\_\_\_

CITY \_\_\_\_\_ STATE/COUNTRY \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

Fall 1982

Volume 10 Number 3

# THE American Journal of Family Therapy

● RECONCILING FEMINIST  
AND FAMILY SYSTEMS  
THERAPIES

● COMPARING BEHAVIORAL  
AND SYSTEMS FAMILY  
THERAPIES

● TALK ABOUT A PAST  
RELATIONSHIP  
PARTNER

● UNILATERAL FAMILY  
THERAPY FOR  
ALCOHOL ABUSE

● RELATIONSHIP ENHANCEMENT  
WITH PREMARITAL  
COUPLES

● SEXUAL AND MARITAL  
DEFENSIVENESS  
SCALES

● INTERVIEW WITH  
MARA SELVINI PALAZZOLI  
AND GIULIANA PRATA

● BOOK REVIEWS

● JOURNAL FILE

● RESEARCH & CLINICAL EXCHANGE



BRUNNER/MAZEL Publishers

*The American Journal of Family Therapy*, formerly the *International Journal of Family Counseling*, is published quarterly by Brunner/Mazel, Inc., 19 Union Square West, New York, NY 10003. Application to mail at second-class postage rates is pending at New York, NY, and at additional mailing offices.

Address all correspondence regarding subscriptions, back issues and bulk sales to: Helen Mack, Brunner/Mazel, Inc., 19 Union Square West, New York, NY 10003. *Subscription rates:* individuals \$22/1 year; institutions \$36/1 year; outside the United States add \$4.00. Back issue rates on request. Make checks payable to Brunner/Mazel, Inc.

Address all advertising correspondence to: Alice Weisman, Brunner/Mazel, Inc., Box 419, Larchmont, NY 10538.

CENTRO

de

Docencia  
Investigación y  
Asistencia  
Psicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli  
Dr. Carlos María Díaz Usandivaras

PSICOPATOLOGÍA DE ADULTOS

PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL

PISCOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE

TERAPIA FAMILIAR Y MARITAL

DOCENCIA - INVESTIGACION

ACASSUSO 907 - SAN ISIDRO - T.E. 743-8645 - Bs. AS.

**SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA  
DEL "HOSPITAL ITALIANO"**

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- Consultorio Externo: Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- Internación: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- Hospital de Día: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón

Gascón 450

Tel. 811-4149

# THIS IS YOUR JOURNAL

Share it with your friends and colleagues.

For those interested in subscribing, an order form is provided below.

Please Enter My:

Individual Subscription

☐

1 year @ \$20  
(4 issues)

☐

Check is enclosed

☐

Bill me for this order  
plus postage and handling

Institutional Subscription (libraries and multi-reader establishments)

☐

Enclosed is a check for \$30 (1 year's subscription)

☐

Bill us \$30 plus postage and handling

(Orders outside of North America, add \$2 per year for postage and handling)

Name \_\_\_\_\_

Institution \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

Mail to: JOURNAL  
OF MARITAL  
AND FAMILY  
THERAPY  
924 W. 9th  
Upland, CA  
91786



American  
Association  
of Marital and  
Family Therapy

## Indicaciones sobre los trabajos que se envíen como colaboraciones

Aquellos trabajos originales o comunicaciones sobre Congresos, conferencias y seminarios que traten el tema específico de la terapia familiar, deben ser enviados a:

**Alfredo A. Canevaro, Gorostiaga 1731 - Cap. Federal (1426) - Rep. Argentina.**

Las colaboraciones deberán ser originales y en tres (3) copias mecanografiadas a doble espacio, con un resumen final en castellano e inglés. La propiedad literaria de los artículos enviados pertenece a la revista y ésta se reserva todos los derechos de reproducción y publicación . . . . .

## FICHA DE SUSCRIPCION

**Sres. de Terapia Familiar:**

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

**Dirección**

**Código Postal**  **Localidad**

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por

pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL      Argentina \$ 400.000.—  
Exterior u\$s 26.—